

**ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОҶИКИСТОН
БА НОМИ АБӮАЛӢ ИБНИ СИНО**

Кафедраи акушерӣ ва гинекологии №1

АВОРИЗИ ҲОМИЛАГӢ

*(материалҳои таълимӣ, ки дар намуди
лекция баён карда шудаанд)*



**Душанбе
«Ҳикмат»
2009**

МУАЛЛИФОН:

мудири кафедраи акушерӣ ва
гинекологии №1 ДДТТ ба номи
Абӯалӣ ибни Сино, узви вобастаи АУ
ҚТ, д.и.т., профессор.

Додхоева М.Ф.; дотсент, н.и.т.

Узакова У.Д.;

ассистент, н.и.т. **Давлатова М.Ф.**

МУҚАРРИЗОН:

директори ПИТ АГ ва П

д.и.т., профессор **Қурбонова М.Х.**

доктори илми тиб **Рустамова М.С**

*Дастури таълимӣ тибқи қарори Шӯрои таъбу наشري Вазорати
тандурустӣ протоколи №2 аз 25 сентябри соли 2008 барои чоп тавсия
шудааст.*

МУНДАРИЧА

I. АМРОЗИ ДАВРАИ ҲОМИЛАДОРӢ	6
1. Сарторикии бармаҳал.....	6
2. Презклампсия ва эклампсия.....	12
3. Ҳомиладорӣ ва касалиҳои экстрагениталӣ.....	22
а) Иллатнокии дил.....	29
б) Баландфишорӣ.....	35
в) Камхунӣ.....	37
4. Пеш аз мӯҳлат қатъ гардидани ҳомиладорӣ....	41
5. Бисёробӣ, камобӣ.....	49
II. АМРОЗИ ДАВРАИ ВАЛОДАТ	54
1. Аномалияи қувваҳои валодат.....	54
2. Коси танг.....	65
3. Таваллуд ҳангоми тифли калон.....	75
4. Таваллуд ҳангоми ҳолатҳои кӯндаланг ва қачии тифл.....	78
5. Таваллуд ҳангоми бисёртифлӣ.....	81
III. ХУНРАВИӢ ДАР ДАВРАИ ҲОМИЛАДОРӢ ВА ВАЛОДАТ	86
1. Хунравиҳои нимаи аввали ҳомилагӣ.....	86
2. Пешомади машина.....	91
3. Пеш аз мӯҳлат кандани машинаи дуруст чойгиршуда.....	93
4. Хунравии марҳалаи сеюми таваллудкунӣ.....	95
5. Садамаи ҳеморрагӣ.....	99
6. Синдроми лахташавии умумии дохилирагӣ.....	102
IV. МАҶРӢҲИЯТИ ВАЛОДАТӢ	104
1. Даридани гарданаки бачадон.....	106
2. Даридани бачадон.....	108

	V. АМРОЗИ УФУНАТИИ	
	БАЪДИВАЛОДАТӢ	112
1	Шаклҳои марҳалаи якуми сироятҳои баъдитаваллудӣ.....	113
2	Шаклҳои марҳалаи дуҷуми сироятҳои баъдитаваллудӣ.....	115
3	Шаклҳои марҳалаи сеҷуми сироятҳои баъдитаваллудӣ.....	117
4	Шаклҳои марҳалаи чоруми сироятҳои баъдитаваллудӣ.....	123

САРСУХАН

Дар замони ҳозира дар давраи гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон ба забони давлатӣ зиёди муассисаҳои таълимию тадқиқотӣ аз вуҷуд надоштани ва нарасидани китобҳою дастурҳои омӯзиши касбӣ ба забони давлатӣ душвориҳои калон эҳсос менамоянд.

Ин китоб мувофиқи мазмунаш китобҳои дарсии фундаменталиро доир ба «Момодоягӣ» иваз карда наметавонад. Онро ҳамчун лексияҳо аз «Момои амрозӣ» истифода бурда, талаботи хонандагонро қонеъ гардонидан мумкин аст.

Дар дастури таълими зерин диққати асосӣ ба амрози давраи ҳомилагӣ, давоми валодат ва баъдитаваллудӣ ҷалб карда шудааст.

Китоби дарсии мазкурро донишҷӯёни ҳамаи факультетаҳои ДДТТ истифода бурда метавонанд.

Муаллифон бо миннатдории самимӣ ҳамаи фикрҳои танқидӣ ва дархостҳои хонандагонро қабул мекунанд ва дар наишҳои ояндаи китоб онҳоро ба назар мегиранд.

I. АМРОЗИ ДАВРАИ ҲОМИЛАДОРӢ

САРТОРИКИИ БАРМАҲАЛИ ҲОМИЛАДОРӢ

(гестозҳои бармаҳал)

САБАБ: Сарторикии ҳомиладорон ё гестозҳо (gestatio - ҳомилагӣ) ҳолати амрози мебошанд, ки бо сабаби ҳомиладорӣ пайдо мешаванд. Омиле, ки ба пайдоиши гестоз мусоидат мекунад, тухми бордоршуда мебошад. Гестози бармаҳал одатан дар семоҳаи аввали ҳомиладорӣ вомерхурд. Яке аз шаклҳои асосии гестози бармаҳал ин вайроншавии вазони системаи ҳозима мебошад.

ПАТОГЕНЕЗ. Назарияҳои зиёде мавҷуданд, ки кӯшиши фаҳмондани механизми гестозҳои бармаҳалро доранд:

**рефлекторӣ,
неврологӣ,
хуморалӣ,
аллергӣ,
маснӯӣ,
кортиковиссералӣ.**

Нақши асосиро дар патогенези гестози бармаҳал (қайкунӣ) вайрон шудани ҳолати функционалии системаи асаб мебошад. Як қатор зухуроти сарири гестози бармаҳал (қайкунӣ, серлуобии даҳон, босуротҳои пӯст) ба аломатҳои невроз шабоҳат доранд. Дар мӯҳлатҳои бармаҳали ҳомиладорӣ аломатҳои невроз дар намуди вайроншавии функсияи нафас ҳозима зухур меёбад, зеро ҳомиладорӣ пеш аз ҳама вайроншавии фаъолияти ҳозимаро ба вуҷуд меорад. Маълум аст, ки рефлексҳои ҳозима ба марказҳои вегетативии миёнаи диэнсефалӣ вобастагӣ дорад. Ангезишҳои атрофии марказгурезе, ки ба ин миёна меоянд, мумкин аст, ҳосияти вайроншуда гиранд. Ё худ тағйиротҳо дар худ марказҳои миёнаи диэнсефалӣ ба вуҷуд биёянд. Ҳамаи ин тағйиротҳо ба хусусияти ҷавобии марказгурез таъсири ҳидро мерасонанд. Агар хусусияти системаи асаб тағйир ёбад, он гоҳ реаксияҳои рефлекторӣ зуд вайрон мешаванд, вайронша-

вии вазоифи ҳозима: гум кардани иштиҳо, дилбеҳузурӣ, серлуобии даҳон, қайқунӣ ба вучуд меояд. Нақши бузургро дар пайдоиши гестозҳои бармаҳал инчунин вайроншавии нейроэндокринӣ ва мубодилаи моддаҳо мебозанд, ки он ба пайдоиши реаксияҳои рефлектории ғайриэтидолоӣ оварда мерасонад. Вайроншавии ҳуморалӣ низ ба пайдоиши реаксияҳои рефлектории патологӣ мусоидат мекунад. Маълум аст, ки ҳангоми ҳомиладории бисёртифлӣ гестозҳо вазнинтар мегузаранд. Ҳангоми қайқунии ҳомиладорӣ мувофиқати муваққатии оғози қайқунӣ ба зиёдашудани миқдори ҳормони гонадотропин рост меояд.

Зухуроти сарири аз намудҳои:

- бештарвохӯранда
- камвохӯранда (дерматозҳои ҳомиладорон, тетания, остеомалатсия, атрофияи зарди шадидаи чигар, диққи нафаси ҳомиладорӣ)

Дар навбати худ намудҳои бештарвохӯранда ба чунин намудҳо тақсим мешавад:

- қайқунии ҳомиладорӣ,
- серлуобии даҳон

Камвохӯранда:

дерматозҳои ҳомиладорон,
тетания,
остеомалатсия,
атрофияи зарди шадидаи чигар,
диққи нафаси ҳомиладорӣ.

Қайқунии ҳомиладорӣ қариб дар 50-60% ҳомиладорон вохӯранд, вале ҳамагӣ 8-10% онҳо мӯҳтоҷи табобат мебошанд.

Се дараҷаи вазнини қайқунии ҳомиладориро фарқ мекунам. Чӣ қадар бармаҳал қайқунӣ оғоз ёбад, ҳамон қадар вазнин мегузарад.

Дараҷаи 1 - шакли сабуки қайқунии ҳомиладорӣ мебошад. Ҳолати умумӣ қаноатбахш мемонад. Дар як шабонарӯз то 5 маротиба қай мекунад. Қайқунӣ ҳангоми наҳорӣ, ҳангоми истеъмоли хӯрок ба вучуд меояд. Аз 2-3

кг зиёд вазн талаф намедихад. Ҳарорати бадан, намнокии пӯст ва пардаҳои луобӣ мӯътадил мемонанд. Набз аз 80 адад дар як дақиқа зиёд намешавад. Фишори хун бетағйир, таҳлили сарии пешоб ва хун мӯътадиланд.

Дарачаи 2 - қайкунии вазнини миёна. Дар ин намуди гестоз ҳолати умумии зан вайрон мешавад. Зани ҳомила аз сустӣ ва сарчархзанӣ шикоят мекунад. Қайкунӣ дар як рӯз 6-10 маротиба такрор меёбад. Дар 1-1,5 ҳафта зан зиёда аз 3 кг вазнро талаф медиҳад. Дар баъзеи занон мумкин аст ҳарорати субфебрилии бадан мушоҳида шавад. Намнокии пӯст ва пардаи луобӣ мӯътадиланд. Набз то 100 адад зарба дар як дақиқа мерасад. Фишори хун мумкин аст каме паст шавад. Ҳаногми муоинаи пешоб реаксия бар асетон мусбат (+, ++ ва +++) мегардад.

Дарачаи 3 – қайкунии вазнини ҳомиладорӣ. Ҳолати умумии зан зуд бад мешавад. Қайкунӣ то 20-25 маротиба меафзояд. Дар як қатор ҳолатҳо қайкунӣ аз ҳаракати зан низ ба вучуд меояд. Азбаски қайкунӣ шабона ҳам давом меёбад, бинобар он хоби зан вайрон мешавад. Зан бениҳоят лоғар мешавад (то 8-10 кг вазн талаф медиҳад). Занҳои ҳомиладор на хӯрок ва на обро аз худ карда наметавонанд, ки дар натиҷа беобшавии организм ва вайроншавии мубодилаи моддаҳо ба вучуд меояд. Аз инҷо вучуди зан заҳролуд мегардад. Пӯст ва пардаи луобӣ хушк мешаванд. Ҳарорати бадан ($37,2 - 37,5^{\circ}\text{C}$) баъзан то 38°C баланд мешавад. Набз то 120 зарба дар як дақиқа мерасад, фишори хун паст шуда, пешоб кам мешавад. Ҳангоми муоинаи пешоб реаксияи асетон мусбат (+++ ё +++) мебарояд, баъзан дар пешоб сафеда ва силиндрҳо пайдо мегарданд. Ҳангоми таҳлили хун – диспротеиннемия ва хипербилирубинемияро мушоҳида кардан мумкин аст.

Яке аз шаклҳои вазнинтарини қайкунӣ - ин қайкунии манънашаванда аст. Агар ҳангоми табобат натиҷаҳои самарабахш дида нашаванд, он гоҳ ин ҳолат ҳамчун нишондод барои қаткунии ҳомилагӣ ҳисоб кардан лозим.

Қайкунии вазнин дар замони муосир хеле кам вомехӯрад.

Табобати шакли сабуки қайкунии ҳомиладорӣ аз рӯи қоида амбулаторӣ буда, вазни зани ҳомиларо, анализи пешобро ба асетон дар зери назорат мегиранд. Қайкунии дараҷаи 2 ва 3 табобати статсионариро талаб мекунад.

Дар як хучра ду маризи бо ҳам монандро бистари кардан мумкин нест, зеро дар зани шифоёфтаистода мумкин аст беморӣ аз нав хурӯҷ гирад. Вариантҳои гуногуни рефлексотерапия самарائي хуб медиҳад. Барои бартараф намудани беобӣ ва захролудии организм бояд ба миқдори 2-2,5 литр табобати инфузионӣ дар як шабонарӯз гузаронид. Ҳар рӯз дар зарфи 5-7 рӯз маҳлули 5% глюкоза (1000 мл) бо кислотаи аскорбинат ва инсулин (12 ЕД) бояд гузаронид. Барои афсурда кардани маркази қайкунии мумкин аст серукал. Қоидаи асосии табобати доругии қайкунии дараҷаи миёна ва вазнин ин истифодаи усули воридкунии парентералӣ дар зарфи 5-7 рӯз мебошад. Инчунин барои табобати қайкунии витаминҳоро (В₁, В₆, В₁₂, С) истифода бурдан мумкин аст.

Барои пешгирӣ ва муолиҷаи захролудии чигар метионинро тайин кардан мумкин аст, ки ӯ хислати зиддизахрӣ дошта, таъсири витаминҳо, ҳормонҳо, ферментҳоро ғайб мегардонад, инчунин синтези холин ва фосфолипидҳоро аз ҷарб зиёд мегардонад.

Барои табобати қайкунии ҳомилагӣ сплениро 2 мл дар зарфи 10-12 рӯз ба дохили мушак истифода мебаранд, ки ӯро аз испурчи ҷорвои шохдори калон ҷудо мекунад. Ин дору мубодилаи метионинро зидди захри чигар афзун месозад, ба системаи маснӯӣ таъсири мӯътадилкунанда мерасонад. Аз самаранокии табобат қатъи шудани қайкунии, илова намудани вазни бадан, эътидол гаштани анализи хун ва пешоб шаҳодат медиҳад. Агар табобат бесамара бошад, он гоҳ ҳомиладорӣ бояд қатъ карда шавад.

Нишондодҳо барои қатъи ҳомиладорӣ:

Қайкунии манънашаванда.

Зиёд шудани асетон дар таҳлили пешоб.

Бошиддат талаф додани вазн.

Тахикардияи зиёд.

Вайрон шудани функсияи системаи асаб.

Ранги зард гирифтани карияи чашм ва пӯст.

Ҳипербилирубиннемия ва тағйироти КОС.

Луобчоришавӣ - (птиализм) мумкин аст, бо қайқунӣ якҷоя гузарад ё худ дар шакли алоҳидаи сарторикии бармаҳал рӯй диҳад. Ҳангоми луобчоришавии зиёд зани ҳомила дар шабонарӯз метавонад қариб 1 литр обро талаф диҳад, ки ин ба беобшавии организм, ҳипопротеиннемия, вайроншавии руҳии зан оварда мерасонад.

Табобати луобчоришавии зиёд бояд дар статсионар гузаронида шавад. Ҳар замон дахонро ба қиёми маҳлули ментол чайкандан лозим аст. Ҳангоми талафи зиёди моеъ маҳлули Рингер–Локка, маҳлули 5% глюкоза қатрагӣ ба дохили варид мефиристанд. Гипноз ва сӯзандору самаран хуб медиҳад: ҳангоми матсератсияи рӯй малҳами рухро истифода мебаранд.

Намудҳои камвоҳӯрандаи гестози бармаҳал.

Дерматозҳои ҳомиладорон – шакли камвоҳӯрандаи гестозҳои бармаҳали ҳомиладорӣ мебошанд. Ин гурӯҳи бемориҳои гуногуни пӯст буда ҳангоми ҳомиладорӣ пайдо мешаванд ва вақти ба охир расидани ҳомиладорӣ нест мешаванд. Яке аз бештарвоҳӯрандаи дерматоз ин хоришаки ҳомиладорӣ мебошад. Ў мумкин аст дар минтақаи узвҳои берунии ҷинсӣ пайдо шавад ё худ дар тамоми бадан паҳн гардад. Бо сабаби хориш мумкин аст ҳаяҷоннокӣ ва вайроншавии хоб ба вучуд ояд. Хоришаки ҳомиладориро бояд бо як қатор хоришақҳои маризҳои дигар (касалии қанд, бемории замбуруғии пӯст, трихомониаз, реаксияи баланҳассосӣ) ташхиси тафриқавӣ гузаронд. Барои табобати ин авориз гиёҳҳои оромбахш, афканишоти фавқулбунавш истифода мебаранд. Ниҳоят кам экзема воমেҳурад, ки ин маризро вируси ҳерпесӣ ба вучуд меорад. Ҳерпес ниҳоят хавнок буда, хеле кам вомеҳӯрад. Ин беморӣ ба марг расониданаш мумкин аст. Сабаби пайдоиши он номаълум аст. Ў дар намуди рихинакӣ зухур меёбад. Аксар вақт ин беморӣ ба вайроншавии вазои фиғадудҳои тарашуҳи дохилӣ ва хусусан ғадуди наздисипар-

шакл вобастагӣ дорад. Барои табобат калсий, витамин Д, инчунин мавқеи малҳамҳои зиддиуфунатӣ истифода мебаранд. Агар табобат самара надиҳад, пас лозим меояд, ки ҳомилагӣ қатъ карда шавад.

Тетанияи ҳомиладорӣ – ҳангоми ин беморӣ кашишхӯрии мушакҳои чанбарҳои боло «дасти момодоя», баъзан чанбарҳои поён ва рӯй ба вучуд меояд. Асоси ин беморӣ суст ё қатъ шудани фаъолияти ғадуди наздисипаршакл мебошад, ки дар натиҷаи он мубодилаи калсий вайрон мешавад.

Агар ин авориз вазнин гузарад бояд ҳомиладориро қатъ намуд. Барои табобат паратиреоидин, калсий, дигидротахистерон, витамин Д истифода мебаранд.

Остеомалятсияи ҳомиладорӣ – ин авориз ниҳоят кам вомерӯрад. Дар ин ҳолат ҳомиладориро ҳатман қатъ бояд намуд. Аксар вақт остеомалятсия пинҳонӣ мегузарад. Ҳангоми ин авориз мубодилаи калсий ва фосфор вайрон шуда, декалсинатсия ва мулоимшавии устухонҳоро ба вучуд меорад. Зухуроти асосӣ – симфизопатия, дард дар пойҳо, устухонҳои кос ва мушакҳо, парастезия, роҳгардӣ тағйир меёбад ва рефлексҳои қадкашакҳо зиёд мешаванд. Агар пайванди қовуқро палмосем, он гоҳ дарднокӣ эҳсос карда мешавад. Дар наворҳои рентгенӣ зиёд шудани фосилаи пайванди қовуқро мушоҳида кардан мумкин аст, ки дар фарқият аз остеомалятсияи асли тағйироти деструктивӣ мушоҳида карда намешавад. Ин аворизро бо воситаи витамин Д, рағани моҳӣ ва афканишоти фавқулбунавшӣ табобат мекунад.

Атрофияи зарди шадиди чигар ниҳоят кам вомерӯрад ва мумкин аст оқибати қайкунии зиёди ҳомиладорӣ бошад. Ҳангоми ин авориз ҳуҷайраҳои чигар бо тағйироти чарбуғӣ ва сафедагӣ гирифта шуда, ҳаҷмаш хурд мешавад, зан зардӣ пайдо мекунад, сипас вайроншавии вазнини руҳият, кома ва ғавти зан мушоҳида карда мешавад. Тамоми ин чараён 2-3 ҳафта давом мекунад. Ҳомиладориро ҳатман бояд қатъ намуд. Баъзан баъди қатъи ҳомиладорӣ сиҳатшавии бемор дар гумон мебошад.

Дикки нафаси ҳомиладорӣ – хеле кам вохӯрда, сабаби ӯ афсурдашавии вазоифи ғадуди наздисипаршакл мебошад, ки дар натиҷа мубодилаи калсий вайрон мешавад. Дикки нафаси ҳомилагиро аз хурӯчи дикки нафаси тоҳомилагӣ дошта бояд фарқ кунем.

ПРЕЭКЛАМСИЯ ВА ЭКЛАМПСИЯ

Гестози дерина ин аворизи нимаи дуҷуми ҳомилагӣ мебошад, дар ин вақт номуваффақияти механизмҳои адаптационии организми модар ба ҷанини инкишофёбанда дида мешаванд. Сабаби ба вуҷуд омадани гестози дерина ин ҷанини инкишофёбанда аст.

Дар момоии муосир луғати «токсикоз» ба луғати «ВПП - гестоз» иваз карда шудааст. ВПП – гестоз (варам, протеинурия, гипертензия) – амрози вазнини, ки барои модар ва тифл оқибатҳои бадъ дорад, 20-25% сабаби фавти модар ин гестозҳои дерина мебошанд, фавти перинаталӣ бошад дар ин ҳолат 3-4 маротиба меафзояд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар структураи фавти модари намудҳои вазнини гестози дерина ҷои дуҷумро ишғол мекунад.

Басомади гестоз ба ҳисоби миёна аз 2 то 14%-ро ташкил медиҳад. Омилҳои «хавф» инкишофи гестози дерина:

- дар занҳои нахустин ҳомила то 20 сола ва аз синни 30 сола боло
- дар занҳое, ки дар ҳомили пешина эклампсия гирифта шуда будаанд
- ҳомиладорон, ки андозаи калони машимаро доранд (бисёртифлӣ, бузургтифлӣ)
- дар занҳое, ки аломатҳои изогемоконфликт доранд
- дар занҳое, ки гирифтори бемориҳои экстрагениталианд (гипертензияи шараёнӣ, диабет қанд, гломеруло- ва пиелонефрит, бисёрвазнӣ, камхунӣ дараҷаи вазнин)
- ин авориз хусусияти ирсӣ дорад, яъне дар апаву хоҳарҳо ва духтарҳо бештар дида мешавад.

Тасниф. Дар замони муосир таснифе вучуд надоард, ки табибони момиро қаноатбахш созад. Шаклҳои тоза ва омехтаи гестозхоро фарқ мекунанд, ки ин дар заминаи дигар амрози саломатӣ вомерӯрад. Шакли омехта бештар дар зиммаи бемории гипертоникӣ, бемории гурдаҳо, дил, синдроми диэнсефалӣ, касалиҳои эндокринологӣ вомерӯрад.

Гурӯҳи татқиқоти ТУТ (Ташкилоти Умумичаҳони Тандурустӣ) таклифи худро пешниҳод мекунад. Асосиатсияи Ҷумҳуриявии Акушер-гинекологҳои Тоҷикистон дар асоси таснифи ТУТ пешниҳод кардари, таснифи худро пешкаш кард, ки ба тариқи зайл дар поён нишон шудааст:

- **Гипертензияи музмин, ки вучуд дошт то ҳомилагӣ ва якӯмин бор то 20 ҳафтаинаи ҳомилагӣ ташхис шудааст ва баъди 6 ҳафтаи баъди валодат манъ намешавад, ки ду дараҷаи ҷараёни он дида мешавад:**
 - **Мӯтадил**
 - **Вазнин**
- **Гипертензияи шараёни, ки якӯмин бор баъди 20 ҳафтаинаи ҳомилагӣ ташхис шудааст ва баъди 6 ҳафтаи баъдивалодатӣ манъ мешавад. Ду дараҷаи ҷараёни он фарқ мекунанд:**
 - Мӯтадил**
 - Вазнин**
- **Протеунирияи ҳомиладорӣ**
- **Презклампсия – ба гипертензияи шараёнии илова ғаштани протеинурия. Ду дараҷаи ҷараёни он фарқ мекунанд:**
 - **Мӯтадил**
 - **Вазнин**
- **Эклампсия – зухуроти асосиаш ҳамалот**

Сабабҳо ва патогенез: сабаби гестози дерина то замони муосир нофаҳмо мондааст. Вобастагии ин патология бо ҳомиладорӣ бешубҳа мебошад. Зиёда аз 44 назария вучуд дорад, ки кӯшиш мекунанд сабаби пайдоиши гестозро

шаҳр диҳанд. Новобаста аз он ки шумораи зиёди назарияҳо аз тарафи муаллифони гуногун, ки дар замонҳои мухтариф пешниҳод карданд, табиати гестозҳо то замони мо нофаҳмоянд. Масъулиятҳои сершумори адабиётҳои нишон медиҳанд, ки тасаввури мо доир ба гестозҳо бой шуданд, вале ҳанӯз гестозҳо илман асоснок карда намешаванд. Дар солҳои охир аксарияти тадқиқотчиён инкишофи гестозро ба тағйиротиҳои морфологӣ, вазоифи биохимиявии машина вобаста мекунанд. Варианти нопурраи трофобласт дар шараёнҳои спиралии бачадон оварда мерасонанд, ки дар натиҷа шараёнҳо хусусияти хоси ҳомиладориро намегиранд, яъне дилататсияи пурра намешаванд ва қобилияти ба стимулҳои вазоактивӣ ҷавоб доданро нигоҳ медоранд. Ин ба гипоперфузия ва гипоксияи трофобластҳо оварда мерасонад, ки дар натиҷа фаъолияти вазоифи ва биохимиявии трофобластҳо тағйир меёбад. Фосфолипидҳои пардаи ҳуҷайраҳо, моддаҳои фаъоли биологӣ ихроҷ мекунанд, ки ба ҷузҳои хунин (пеш аз ҳама ба тромбоситҳо) ва эндотелии рағҳои бачадону машинавӣ таъсир мекунанд. Эндотелий вазифаи мураккаб нигоҳ доштани бутунии системаи рагиро иҷро мекунад, ҳамчунон тонуси девораи рагиро танзим намуда коагулятсияи дохилии рагиро пешгирӣ мекунад. Ҳамаи ин механизмҳо дар шароити гипоперфузия ва гипоксия вайрон мешаванд. Ҳосилоти простасиклин суст шуда тромбосан бошад зиёд мешавад, ки ин ба ихтилоҷи рағҳо ва деструксияи тромбоситҳо оварда мерасонад. Эндотелиоситҳо дар фаъолгирии ангиотензин ва сустшавии брадикинин иштирок мекунанд. Ихроҷи вазоконстрикторӣ пурзӯро зиёд шуда ва ихроҷи омили сусткунанда аз эндотелий суст мегардад. Ин на танҳо ихтилоҷи рағҳоро пурзӯр мекунад, инчунин оксидшавии перекиси озоди ҷарбуғиро фаъол мегардонад, дар маҷрои хун маводҳои захрнок зиёд мешаванд ва нуфусоти рағҳои хунгард зиёд мешавад. Ин ҷараён тадриҷан суръат гирифта аввал дар рағҳои бачадонӣ машина сипас дар рағҳои умумӣ паҳн мешавад. Тағйиротиҳо дар системаи гемостаз, ки ба ихроҷи барзиёди тромбосани A_2 , вазопресин ва вай-

роншавии таркиб ва вазоифи рағҳои бачадонию машина ин тағйироти дуҷумӣ мебошад. Баландшавии фаъолияти тромбоциталӣ ва адгезияи онҳо дар якҷоягӣ бо зиёдшавии омили Виллебранди хун мегузаронад, ки ин нишондоди осебияти девораи рағҳо мебошад. Вақте, ки ҷараёни агрегатсия бузургии заруриро доро мегардад, он гоҳ фибрин дар рағҳои бачадонию машина, дар системаи микросиркулятсия, ҷигар, шӯш, мағзи сар зиёд мешавад. Тағйиротҳо бештар дар рағҳои бачадонию-машина ва микросиркулятсияи гурдаҳо ба вучуд меояд. Ҳамин тариқ ҳамаи механизмҳои патофизиологӣ ба ихтилоҷи мунташакири рағҳои хурди организми ҳомила оварда мерасонад, инчунин нуфузоти капиллярҳо вайрон намуда ба баромадани моеъ ва сафедаҳо ба бофтаҳо оварда мерасонанд, ки ин ба пастшавии ҳаҷми хуни гардишкунанда мусоидат мекунад. Аз рӯи гуфтаҳои дар боло зикр шуда ҳангоми гестоз, осебияти пурхурӯҷи эндотелиоситҳои рағҳои бачадонию – машинавӣ ва агрегатсияи тромбоцитҳо ва вучуд меояд, ки мувофиқи он дар момои як қатор маводҳо истифода мебарданд, масалан: аспирин, меъри ночизи аспирин ихроҷи протромбини A_2 -ро суст мекунад, инчунин тақсими агрегатҳои тромбоцитарӣ ва рағҳои ихтилоҷшуда мамолият карда бо ҳамин гестозҳо пешгирӣ мекунад. Вале ин гуна амалиётҳо натиҷаҳои қаноатбахш надод.

Симптомҳои асосии клиникии вайроншавиҳои гестатсионӣ:

- **Гипертензияи шараёнӣ**
- **Протеинурия**
- **Вайроншавии вазифаи узвҳо**
- **Ҳамалот**

Шаклҳои клиникии гестози дерина:

Гипертензияи шараёнӣ чунин ташҳис карда мешавад:

- Ҳангоми ченкунии ду каратаи фишори диастоликӣ 90 мм сут. сим. ё аз ин боло (фосила байни ченкунӣ 4 соат).

Гипертензияи мӯътадил:

- Ҳангоми ченкунии ду каратаи фишори диастоликӣ аз 90 мм сут. сим. то 105 мм сут. сим. (фосила байни ченкунӣ 4 соат).
- Фишори систоликӣ аз 140 мм сут. сим. ва боло.

Гипертензияи ванин:

- Ҳангоми ченкунии як каратаи фишори диастоликӣ аз 120 мм сут. сим. ва боло
- Ҳангоми ченкунии ду каратаи фишори диастоликӣ аз 110 мм сут. сим. ва боло (фосила байни ченкунӣ 4 соат).
- Фишори систоликӣ аз 160 мм сут. сим. ва боло.

Протеинурияи гестатсионӣ чунин ташхис карда мешавад:

- ин талаф додани сафеда дар пешоби шабонарӯзӣ – 300 мг

Прееклампсия.

Прееклампсия - ин ба гипертензияи шараёни хамроҳи шудани протеннурия

Ду намуди прееклампсия вучуд дорад:

- мӯътадил
- вазнин

Мейёрҳои ташхиси прееклампсияи мӯътадил:

- Ҳангоми ченкунии ду каратаи фишори диастоликӣ аз 90 мм сут. сим. то 105 мм сут. сим. (фосила байни ченкунӣ 4 соат).
- Фишори систоликӣ аз 140 мм сут. сим. ва боло.
- Талаф додани сафеда дар пешоби шабонарӯзӣ – 300 мг то 3 г/л

Мейёрҳои ташхиси прееклампсияи вазнин:

- Хангоми ченкунии як каратаи фишори диастоликӣ аз 120 мм сут. сим. ва боло
- Хангоми ченкунии ду каратаи фишори диастоликӣ аз 110 мм сут. сим. ва боло (фосила байни ченкунӣ 4 соат).
- Фишори систоликӣ аз 160 мм сут. сим. ва боло.
- Талаф додани сафеда дар пешоби шабонарӯзӣ – аз 3 г/л ва боло
- Гипертензия ва протеинурияи гуногун бо омехта шудани чунин аломатҳо:

Гиперрефлексия

Сардари

Вайроншавии босира

Олигурия (хориҷкунии пешоб кам аз 400 мл дар муддати 24 соат)

Варами шӯш

Дард дар меҳроби меъда

Hellp - синдром

Эклампсия – зухуроти асосиаш ҳамаҷо ва гум кардани ҳуши бемор мебошад. Ҳамаҷо аз 4 зина иборат мебошад. Зинаи 1 - кӯтоҳмуддат буда, 20-30 сония меёбад ва кашишхӯрии фибрилярии мушакҳои рӯй ба вучуд меорад. Зинаи 2 – кӯтоҳмуддат буда, 30 сония давом меёбад, кашишхӯрии тоникӣ мушакҳо то қатъи амали нафас ба вучуд меояд. Зинаи 3 – кашишхӯрии клоникӣ буда, 2 дақиқа идома меёбад, нафаскашӣ вайрон мешавад, сианози бемор дида мешавад, аз даҳон луоби кафдор мерезад. Зинаи 4 - зинаи ҳалшавандаю сардиханда буда, нафас оҳиста барқарор мешавад. Ҳуши бемор мумкин якҷанд дақиқа вучуд наомада бошад.

Эклампсия аз вайроншавии функсияи чуқури узвҳо шаҳодат медиҳад, ки мумкин аст ба фавти зан оварда расонад. Сабаби асосии фавти зан ин хунрезӣ ба мағзи сар мебошад. Тифл мумкин аст, ки аз гипоксия, ки дар вайроншавии хунгардиши бачадонию-машина ба вучуд меояд

фавтад ё худ дар асари бармаҳал чудошавии машина ме-
фавтад. Ҳангоми эклампсия ҳамалот як маротиба ё якчанд
маротиба паи ҳам бар ҳам вучуд ояд. Ин ҳолатро статуси
эклаптикӣ, агар баъди ҳамалот зан ба ҳуш наояд, он гоҳ
инро комаи эклампсӣ меноманд. Зани ҳомила мумкин аст,
бидуни ҳамалот ҳушашро гум кунад: он гоҳ онро экламп-
сияи безклампсия меноманд. Эклампсия метавонад ба
модар ва тифл аворизҳои зеринро диҳад:

1. Норасогии гурда.
2. Норасогии дилӣ
3. Варами шӯш
4. Хунрезӣ ба мағзи сар, тромбозҳо, варами мағзи
сар, кома.
5. Аломати ЛУД (лахташавии умумии дохилирагӣ)
бо вайроншавии бо хун таъминшавии узвҳои
ҳаётан муҳим.
6. Норасогии чигар.
7. Аломати шадиди дистресси респираторӣ.
8. Хунрезӣ ва чудошавии турпардаи чашм.
9. Бармаҳал чудошавии машинаи дуруст
ҷойгиршуда.
10. Гипоксия, гипотрофия ва фавти тифл.
11. Таваллуди бармаҳал.

Табоботи вайроншавиҳои гипертензионӣ

Ҳангоми презклампсия мӯътадил табоботи амбулаторӣ гу-
заронидан мумкин. Зани ҳомила бояд дар назорати доимӣ
истад, фишори шараёнӣ дар давоми рӯз ду бор таҳқиқ
кард. **Шароити муҳими бурди амбулаторӣ ин:**

- ҳомиладор маълумот дар бораи аломатҳои хавфнок
бояд дошт
- вучуд доштани имконияти воридшавии зуднок ба
стационар

Дар занҳое ҳомила, ки бо презклампсияи вазнин ва экламп-
сия дучор шуданд чунин амалиётҳо гузаронидан лозим:

- госпитализатсияи зуднок
- ташхиси ҳаматарафа
- табобат бо қаткунии саривактии ҳомилағӣ

Дар занҳое ҳои́ла, ки бо преэклампсияи вазнин ва эклампсия дучор шуданд чунин табобати медикаментозӣ гузаронидан лозим:

- Пешгирӣ ва табобати ҳамалот
- Терапияи антигипертензионӣ
- Валодат

Пешгирӣ ва табобати ҳамалот.

Нақшаи оиди истифодни маҳлули сулфат магний ҳангоми преэклампсияи вазнин ва эклампсия

Тарзи ворид-кунӣ	Миқдори боркунанда	Миқдори нигоҳдоранда
Доҳили мушакӣ	10 грамм: 5 граммӣ (20 мл 25% р-ра или 10 мл 50% маҳ-ли) $MgSO_4$ бо 1,0 мл 2% маҳлули лигнокаин дар як шприц доҳили мушак аз ҳарду тараф	5 грамм $MgSO_4$ бо 1,0 мл 2% маҳлули лигнокаина дар як шприц дар фосилаи 4 соатӣ
Доҳиливаридӣ	4-6 грамм (20-25 мл 25%) маҳ-ли $MgSO_4$ бо маҳлули лактат Рингер омехта шуда. Агар ҳамалот такрор шудаанд боз 2 грамм иловагии он д/в ворид мекунанд	1-2* грамм дар давоми як соат пеш аз валодат, дар мавриди валодат ва 48 соат баъди таваллуд! Дар 500 мл маҳлули Рингера 5 г $MgSO_4$ омехта месозанд)

Ёри таъҷили ҳангоми инкишоф ёфтани ҳамалот

1. Ба ёр расонидан шахсонро водор намудан, лекин беморро танҳо намондан
2. Ба сатҳи ҳамвор беморро гузоштан, сарро ба паҳлӯ гузаронидан

3. Ҳолати беморро ташхис намудан (фишори хун, набз, нафаскашӣ). Аз ҳешон сӯҳбат оиди воқеа ва собиқа чаъм кардан
4. Ҳангоми ҳамалот беморро қапидан. Агар забон байни дандонҳо дар мандааст онро озод кардн лозим.
5. Вентилятсияи ёридиҳанда ё худ беморро ба нафасгирӣ сунъӣ мегузаронанд.
6. Баъди барқароршавии нафас миқдори боркункндаи маҳлули $MgSO_4$ ворид кардан
7. Дар мавриди фишори шараёنى будани 160/110 истифода бурдани доруи антигипертензионӣ лозим аст
8. Бистарии зуднок ё гузариш ба ҳучраи эҳёгарӣ
9. Дар роҳхат маълумот сохтан оиди вазифаи узвҳои муҳими дарунӣ, амалиётҳои иҷрокарда

Терапияи антигипертензионӣ

Мақсади терапияи антигипертензионӣ

- пешгирии инсулт
- пешгирии энцефалопатияи гипертензионӣ

Хусусияти табобати пастфишорӣ аз дараҷаи баландшавии фишори диастоликӣ вобаста аст. Ҳангоми он ба 105 мм сут. сим. баробар ва аз он баланд бошад метавонем гидралазин 5 мг даруниваридӣ ҳар яки 5 дақиқа то пастшавии фишори шараёنى; лабетолол 10 мг д/в ё нифедипин 10 мг ворид намоем.

Бурдани таваллуд. Таваллуд ҷарёни гестозро ва гипоксияи тифлро вазнинтар мекунад. Бинобар ҳангоми интиҳоби усул ва вақти таваллуд инро дар хотир нигоҳ дошт. Чи тавре, ки дар боло зикр шуд таваллуд ҷузъи ҳатмӣ муолиҷаи гестоз аст. Агар дар чунин занҳо роҳҳои валодатӣ ба таваллуд омода бошад, он гоҳ беҳтар аст, ки таваллуд бо воситаи роҳҳои табиӣ валодатӣ ба анҷом расад.

Нишондодҳои асосии каҷтқардани пешазмуҳлатии валодат:

- **Эклампсия**
- **Прееклампсияи вазнин**
- **Норасогии дилӣ бо варами шуш.**
- **Хунрезӣ ба мағзи сар, тромбозҳо, варами мағзи сар, кома.**
- **Аломати ЛУД (лахташавии умумии дохилирагӣ) бо вайроншавии бо хун таъминшавии узвҳои ҳаётан муҳим.**
- **Норасогии гурда.**
- **Норасогии чигар.**
- **Аломати шадиди дистреси респираторӣ.**
- **Хунрезӣ ва ҷудошавии турпардаи чашм.**
- **Бармаҳал ҷудошавии машинаи дуруст ҷойгиршуда.**
- **Гипоксия, гипотрофияи тифл.**

Таваллудбедоркуниро аз кафондани обаки наздитифлӣ оғоз мекунанд. Агар дар зарфи 2 соат баъди рехтани обаки тифл таваллуд сар нашавад, он гоҳ ба дохили варид окситосин ё простогландинҳо ворид мекунем. Қайд бояд кард, ки дар тамоми чараёни валодат ва давраи 48 соати баъдивалодатӣ табобати пастфишоркунандаро ва ҳамалотпешгирикунандаро истифода бояд кард.

Таваллуд бояд ҳатман бедард карда шавад, ҳангоми шаклҳои вазнин аз анестезияи перидуралӣ истифода мебаранд. Дар давраи 3 – пешгирии хунрезиро мегузаронанд.

Аз рӯи нишондодҳои зерин амалиёти ҷарроҳии буриши қайсариро мегузаронанд:

1. Эклампсия вақти ҳомила ё таваллуд, агар таваллуд бо воситаи роҳҳои табиӣ имконнопазир бошад.

2. Аворизҳои вазнини гестоз (хунрезӣ ба мағзи сар, ҷудошавии турпардаи чашм, норасогии шадиди гурдаҳо, чигар, кома, бармаҳал ҷудошавии машинаи дуруст ҷойгиршуда).

3. Бесамаранокӣ муолиҷа ҳангоми шаклҳои вазнини гестоз ва прееклампсия, ҳангоми тайёр набудани роҳҳои табиӣ таваллудӣ.

4. Бесамара будани таваллудбедардкунӣ ё сустии кувваи валодатӣ.
5. Бад шудани ҳолати зоянда (баланд шудани фишори шараёни, тахикардия, дикки нафас), инчунин бад шудани ҳолати тифл, ки дар ин вақт роҳҳои табиӣ валодатӣ омода нестанд.

ҲОМИЛАДОРӢ ВА ИЛЛАТҲОИ ДИЛ

Дар байни касалиҳои системаҳои дилу-рагӣ дар занҳо бештар иллатҳои дил вомехӯрад. Онҳо дар занҳо нисбат ба мардон 2-3 маротиба бештар дида мешаванд.

Ҳомилагӣ дар ин гуна маризон натиҷаи хуб намедихад; амрози системаҳои дилу-рагӣ ва пеш аз ҳама дар байни касалиҳои экстрагениталӣ иллатҳои дил дар марғи занони ҳомиладор яке аз ҷойҳои аввалро мегирад. Сабабҳои ингуна натиҷаҳои номусоид инҳо мебошанд: но-пурра ва номунтазам муоинаи занони ҳомиладор дар зинаи амбулатори ва надониستاني асоси ғаъолиятии системаи дилу-рағии занони ҳомиладор аз тарафи баъзе духтурон; вучуд надоштани назорати умумии касалиҳо аз тарафи моомён (акушерҳо) ва духтурони оилави; аз назорат саркашӣ кардани баъзе занҳои ҳомила, ки иллати дил доранд (баъзе занҳо хоҳони модаршавӣ доранд, лекин натиҷаҳои бади ин касалиро барои саломатии худ ба назар намегиранд); натиҷаҳои хуб надодани табобат; ҳатогихо ҳангоми бурдани валодат ва давраи баъди- валодатӣ. Таҷрибаи як қатор муаллифон нишон медиҳад, ки сари вақт маълум кардани иллатҳои дил дар занони ҳомиладор, ташкили шӯъбаҳои момии кардиологӣ ва марказҳои ташхиси консултативӣ, табобати пурра бо такроран ҳобонидани онҳо дар давраи ҳомиладорӣ, дуруст бурдани валодат ва давраи баъдивалодатӣ имкон медиҳанд, ки ғавтият дар байни занони ҳомиладор бо иллатҳои дил кам шавад.

Ташхиси иллатҳои дил дар занони ҳомиладор ва ҳалли масъала дар бораи он ки ҳомилагӣ нигоҳ дошта шавад, мураккаб мебошад. Ин пеш аз ҳама бо тағйирёбихое, ки дар системаи дилу-рагӣ ҳангоми ҳомилагӣ ба вучуд

меоянд (пайдошавии ғуввасҳо дар нӯги дил, баландшавии тапиши II, дил хиперстеникӣ ё дили хобида, ҳангоми баланд истодани диафрагма), вобаста аст.

Нақшаи муоина:

- 1. Ҷамъи пурраи анамнез (пайдоиш ва инкишофи касалӣ, собиқаи момой);**
- 2. Гузаштани ташҳиси момой;**
- 3. Маълум кардани иллати дил, шаклҳои он, тағйирёбии миокард, дигар узвҳо (системаи рағӣ, шушӣ, ҷигар, гурда);**
- 4. Маълум кардани шаклҳои вайроншавии хунгардишӣ;**
- 5. Маълум кардани тарбод (ревматизм) ва фаъолнокии вай;**
- 6. Маълум кардани манбаи сироят (тонзиллит, хайморит, дигар касалиҳо).**

Маълумотҳои собиқагии зерин: ишора ба дард дар бугумҳо буда баъди гулудардӣ, тангнафасӣ, беҳолӣ, дилзанӣ, ки баъди қори ҷисмонӣ (пеш аз ҳомиладорӣ) ба вучуд меоянд, аҳамияти қалон доранд.

Ҳангоми гузаштани ташҳиси момой аворизҳои момиро дар валодат, мисол, ҳомиладорӣ аввалин дар занҳои аз 30-сола боло, пешомад бо қос, ҳолати қўндалангии ҷанин, қоси танг ва инчунин, вақти ҳомиладориро ба назар гирифта лозим аст.

Ёфтани ҳалли масъала дар бораи имқонияти давом додани ҳомиладорӣ дар мўҳлати то 12-ҳафтаина будани ҷанин, барои онки дар ин мўҳлат исқоти сунъии инструменти ё меѓикаментози (меѓепристон) бештар ба амал оварда мешавад, аҳамияти қалон дорад. Қатъ кардани ҳомиладорӣ дар мўҳлатҳои аз ин зиёд (аз 22 ҳафтаина зиёд) тарзҳои қиддири интиҳоб меқунанд (бурриши хурди қайсар, мутаасиршавии фаъолияти валодат).

Барои ташҳиси иллати дил дар ҳомиладорон, ба ғайр аз садогушқунӣ ва ангиштзанӣ, муоинаи ултрасадоҳо, рентгенографияи дил, электрокардиография, фонокардиография, маълум кардани суръати ҳаракати хун ва фишори венагӣ истифода мешаванд, лекин хавфнокии вайроншавии инкишофи ҷанинро ба назар гирифта аз муоинаи

рентгенӣ дар давраҳои аввали ҳомиладорӣ (то 8 ҳафта) даст кашидан лозим аст.

Хангоми маълум кардани зинаҳои норасоии хунгардиш таснифи Н. Д. Стражеско ва В. Х. Василенкоро истифода мебаранд.

Сабабҳои норасоии дил хангоми ҳомиладорӣ гуногун мебошанд ва ба он мусоидат мекунанд:

1. Зиёдшавии ҳаҷми хуни ҳаракаткунанда ва ҳаҷми дақиқагии дил (асосан дар VII-VIII-моҳа будани чанини зани ҳомиладор);

2. Ба вучуд омадани сарторикии деринаи ҳомиладорон;

3. Авҷгии тарбод, пайдошавии эндокардити септикий;

4. Сироятҳои роҳҳои болоии нафас, зуком, пневмония, эмболии шохҳои артерияҳои шуш;

5. Миқдори гипертензия (баландшавии фишор)-и шушӣ ва дили шушмонанд.

Нишондодҳои норасоии дил хангоми ҳомиладорӣ чунинанд:

тангнафасӣ, тағйирёбии вақти бозгаштани хун, зиёдшавии тапиши дил, зиёдшавии нафаскашӣ, вайроншавии тапиши дил.

Дар занҳои ҳомиладори сиҳат ҳаҷми дақиқагии шуш зиёд мешавад, ки ин дар бораи мушкулшавии нафас ва ё вонамуд кардани тангнафасӣ маълумот медиҳад.

Агар тангнафасӣ якҷоя бо сулфа, ҷудошавии балғам, бо пайдошавии хирозҳои устувор дар асоси шуш гузарад, ин дар бораи норасоии дил маълумот медиҳад.

Хурӯҷҳои тахикардия ё ин ки буғумшавӣ бо дилзанӣ, кабудшавии (сианоз) лабҳо ва почая дастҳо, варами венаҳои гардан, калоншавӣ ва пайдошавии дарди ҷигар изтиробӣ баландро ба вучуд меорад. Ҳаҷми ҳаётгии шуш хангоми ба вучуд омадани манъшавӣ дар онҳо бениҳоят кам мешавад. Хангоми гипертрофияи меъдачаи чапи дил вақти бозгашти хун баъди ворид кардани 5 мл маҳлули

10%-и сулфати магний ба вена ҳисси гармиро дар дахон пайдо мекунад, ки он аз 14-16 сония то 18-20 сония дароз мешавад.

Барои дили шушмонанд манъшавии гардиши хун дар системаи венагӣ, чигар, гурдаҳо, меъда варамҳои даврӣ хос мебошанд. Агар ангиизи сохти асабӣ вучуд надошта бошад ва ҳарорати бадан баланд набошад, зиёдшавии набз то 100-110 ва аз 110 боло дар 1 дақиқа дар бораи талафнопазирӣ (декампенсатсия) маълумот медиҳад.

Хуруҷҳои тахикардияи пароксизмалии тез-тез ба вучуд оянда, давомнок ба вайроншавии вазнин таҳдид мекунад ва табобати махсусро талаб мекунад. Ҳамин ҳел аҳамиятро ҳам нафаси аз 24-маротиба дар 1-дақиқа зиёд буда дар бар мегирад, ки дар бораи шакли манъшавӣ дар шуш маълумот медиҳад.

Экстрасистолаҳои алоҳида-алоҳида ва гурӯҳӣ, асосан пайдоиши асабӣ доранд ва дар ҳомиладорон тез-тез дида мешаванд. Аритмияи милт-милт бисёр вақт ҳангоми иллати клапани митралӣ ба амал омада, аломати ҷиддии вайроншавии миокард мебошад. Вай бештар эмболияро ба вучуд меорад, ки барои зани ҳомиладор ҳавфи калон дорад.

Муайян кардани фаъолнокии просесси тарбодӣ ҳангоми ҳомиладорӣ мушкул аст, барои он ки ҳарорати субфебрилӣ, зиёдшавии суръати тақшиншавии эритроцитҳо, лейкоцитоз, ба тарафи чап ҳаракати формулаи лейкоцитарӣ дар занҳои ҳомиладори сиҳат ҳам дида мешаванд. Нишондодҳои лаборатории шакли фаъоли тарбод (якҷоя бо дигар аломатҳо) чунинанд: миқдори лейкоцитҳо аз 110×10^9 зиёданд, суръати тақшоншавии эритроцитҳо аз 35 мм/соат зиёд аст, формулаи лейкоцитарӣ бениҳоят бисёр ба тарафи чап нигаронанд. Новобаста аз фаъолнокии табобат, анемияи ҳипохромӣ, протеинурия, цилиндрурия, пастшавии миқдори ретикулоцитҳо, норасогиҳои дуру дарози хунгардӣ аҳамияти таҳхисии муайянро доранд. Муайянкунии титри О-стрептолизин (дар эътидол титри вай 1:350) дар хун аҳамияти таҳхисӣ дорад. Дар фазаи фаъоли

касалиҳои тарбодӣ ин титрҳо 1:1000 ва аз он зиёд ҳам мешаванд.

Баъди маълум кардани таъхис ва давраҳои инкишофи иллатҳои дил дар ҳомиладорон масъаларо дар бораи давом додани ё надодани ҳомиладорӣ ҳал кардан лозим аст. Дар ин ҳолат дараҷаҳои фаъоли рафти тарбодро, миқдори касалиҳои ҳамроҳикунанда ва аворизгирии ҳомиладориро ба назар гирифтани лозим аст. Агар норасогии дарғоти даҳлезу-меъдачаи чапи дил маълум карда шавад ва чунин ҳулоса бароварда шавад, ки ин иллат ҳангоми ҳомиладорӣ ва валодат беҳавф аст, он гоҳ ҳатогии калон ба миён меояд. Инро ба назар гирифтани лозим аст, ки норасогии митралии «тоза» дар ин ҳолат кам вомерӯрад. Бештар вақт норасоӣ ва суддабандӣ якҷоя вомерӯранд, ки яке аз ин иллатҳо нисбат ба дигараш бартар аст.

Нигоҳ доштани ҳомиладорӣ танҳо дар чунин ҳолатҳо мумкин аст:

1. Ҳангоми иллатнокии дил, ки аломатҳои норасогии гардиши хун ифода наёфтаанд ва шиддатгирии равиши тарбодӣ дараҷаи 1-и ҳавфӣ (бо Л.П.Ванин), дар давраҳои аввали инкишофи норасогии митрали (тангнафасӣ, тахикардия), вақто ки то ҳол вайроншавии гемодинамакӣ пайдо нашудааст;

2. Ҳангоми мавҷуд будани нишонаҳои марҳалаҳои тарбод - давраи AI (бо Нестеров) дараҷаи 2-юми ҳавф.

Дар чунин ҳолатҳо нигоҳ доштани ҳомиладорӣ номумкин аст:

1. Ҳангоми норасогии митралии ифодаёфта бо регургитатсияи (ба қафо баргаштани хун) баланд;

2. Ҳангоми марҳалаҳои фаъоли тарбод (зинаи AII);

3. Аритмияи милт-милти нав ба вучудомада, гипертензияи шушӣ (давраи II) - дараҷаи III-и ҳавф, ҳангоми иллатҳои талафнопазирӣ (декомпенсиридашуда), (ғайри талафшуда)-и дил бо аломатҳои норасогии хунгардиш;

4. Ҳангоми марҳалаҳои фаъоли тарбод (давраи AIII), атрио- ва кардиомегалия, аритмияи милт-милти давомнок

бо пайдоиши тромбозмболия, гипертензияи шуш (зинаи III-даври IV-и ҳавф).

Дар мавриди вусъатёбии ҳомиладорӣ дар просесси валодат норасогии хунгардиш тез вусъат мегирад.

Дар давоми якчанд солҳо чунин меҳисобиданд, ки ҳангоми суддатбандии суроҳии даҳлезу-меъдачаи чап ҳомиладорӣ мумкин нест. Дар замони ҳозира ин масъала ба таври индивидуалӣ, вобаста ба давраҳои иллатнокӣ ҳал карда мешавад. Ҳангоми инро бо тарзи муолиҷавӣ муайян кардан аз рӯи таснифи А. Н. Бакулев ва Е. А. Дамир истифода мебаранд. Мувофиқи ин тасниф 5-давраи инкишофи суддати митралиро фарқ мекунанд.

- Дар давраи I, яъне вақто ки нишондодҳои талафнопазирӣ (декомпенсатсия) вучуд надошта бошад, ҳомиладорӣ ва валодат мумкин аст.
- Дар давраи II-юми инкишофи иллатнокӣ, ки бо аломатҳои норасогии дилу-рағӣ мегузарад, пайдошавии тангнафасӣ баъди сарбории ҷисмонӣ, ҳомиладорию дар шароитҳои назорати доимии духтур нигоҳ доштан мумкин аст. Ҳангоми валодат ҷангакҳои момаириро истифода бурдан лозим аст.
- Дар давраи III сустшавии гардиши хун дар шуш пайдо шуда, фишори венагириро меафзояд, ҷигар калон мешавад.
- Дар давраи IV нишондодҳои сустшавӣ дар гардиши хуни даври калон ва хурд бо тезӣ намоён шуда, фишори венагӣ бениҳоят баланд, ҷигар бо тезӣ калону зич шуда, ассит ва варами атрофӣ пайдо мешавад. Давраи V (аз рӯи таснифи Стражеско-Василенко) ба давраи тағзия рост меояд.

Дар давраи III, IV ва V ҳомиладорӣ тамоман манъ аст.

Ҳангоми иллатҳои аортавӣ (моҳрагӣ) мумкин будан ё мумкин набудани ҳомиладорӣ аз миқдори аломатҳои ат-

рофии иллат: баландшавии фишори аортавӣ, тапиши дучанди, шуввosi диастоликӣ ва аломатҳои вайроншавии хунгардиш вобаста аст. Дар давраи талафии (компенсатсия) иллат ҳомиладорӣ ва валодат мумкин аст. Дар давраҳои талафнопазирии иллатнокии шохраг ҳомиладорӣ мумкин нест. Бемороне, ки якчанд иллатнокии дилдоранд, барояшон ҳомиладорӣ тамоман манъ аст. Марҳалаҳои инкишоф, шаклҳои иллатнокӣ (миқдор ва дараҷаи намоёни аломатҳои гипертензияи шушӣ) ва аворизҳои ба амаломада (иллатҳои тарбоди ҳамроҳкунанда, аневризми дилу-рагҳо ва ғайра)-ро ба ҳисоб гирифта, масъалаи ҳомиладории маризонеро, ки иллатҳои дилии модарзодӣ доранд, ба тарзи индивидуалӣ ҳал кардан мумкин аст.

Ҳангоми иллатҳои тетрадо Фалло, аломати Эйзенгеймер, нуксони назарраси девораи байни меъдачаҳо, коарктатсияи баланди шохрагӣ ҳомиладорӣ тамоман манъ аст.

Дар замони ҳозира момоён ба он диққат медиҳанд, ки оё баъди амалиёти дил ва махсусан баъди амалиёти комиссуротомияи митралӣ ҳомиладорӣ ва роҳҳои бурдани он мумкин аст ё не? Дар чунин ҳолат онро ба назар бояд гирифт, ки гардиши хун баъди гузаштани 1-1,5 соати амалиёт барқарор шудааст. Пешгӯии амалиёт ва натиҷаҳои вай аз он ки мариз то амалиёт дар кадом давраи иллат буд, аз муваффақиятнок гузаштани амалиёт, инчунин аз омилҳои иҷтимоӣ (касб, шароитҳои оилавӣю хоҷагӣ ва ғайра) вобаста аст. Баъд аз он ки хунгардиш барқарор мешавад, барои ҳомиладор шудан иҷозат додан мумкин аст: лекин баъди гузаштани якчанд сол пас аз амалиёт ҳомиладор шудан номумкин аст, чунки рестеноз (аз нав суддатбандӣ) ба вучуд меояд, ки ин равиши шиддатгирии ояндаи тарбод мебошад. Дар мавриди ҷой доштани натиҷаҳои номуносиб баъди гузаштани амалиёт, яъне инкишофи ревмокардити баргарданда, эндокардити зершаддиди септикӣ, рестеноз ё аз сари нав суддабандии митралӣ ҳомиладорӣ мумкин нест. Инчунин баъди гузош-

тани орият ё узви сунъӣ (протез) ба дароғатҳои дил ҳомиладорӣ тамоман мумкин нест.

Усулҳои пеш аз мӯҳлат қатъ кардани ҳомиладорӣ дар заноне, ки иллатнокии дил доранд

Бо нишондодҳои қатъкунии ҳомиладорӣ дар мӯҳлати то 12-ҳафтаина ҳомилагӣ гарданчаи бачадонро кушод қардан лозим аст. Бо ин мақсад вибродилататорро истифода бурда, баъд даруни бачадонро тарошида тоза мекунанд. Пеш аз ин зани ҳомиладорро бо ёрии қарахтқунии парасервикалии маҳлули новокаин, бо маводҳои беҳушкунандаи (наркозӣ) сомбревин, ки онро ба дохили вена мегузаронанд, бедард мекунанд.

Ҳангоми нишондодҳои аборти сунъии вақташ гузашта (IV-VI- моҳагии чанин) дар зери беҳушқунии интубатсионӣ ва қабул кардани релаксантҳои таъсиршон кӯтоҳ (листенон), буриши хурди қайсарӣ гузаронида мешавад. Истифодабарии буриши қайсарии маҳбалӣ ба мақсад номувофиқ аст, чунки ин амалиёт дар ҳолати ноқуллай ҷойгирии бемор гузаронида мешавад, яъне пойҳояш аз буғумҳои зону ва косу-рон ба тарафи ишқам қатъ карда мешаванд. Ин мавқеи ҷойгирӣ зудии набз, зудии нафас, нишондоди фишори артериявӣ ва венагири тағйир медиҳад. Ҳангоми беморро баъди амалиёт ба мавқеи уфуқӣ (горизонталӣ) гузаронидан мумкин аст, ки вокунии (реаксия)-ҳои вазнин (зиёдшавии набз, пастшавии фишори артериявӣ ва венагӣ, камшавии талаботи оксиген) ва ҳатто коллапс пайдо шаванд.

Табобати ҳомиладорон бо иллатнокии дил ва тайёрии онҳо ба валодат бояд, ки бо иштироқи акушер ва терапевт ва баъзан бо иштироқи кардиохирург гузаронида шавад.

Чамъи чорабиниҳои табобати пешгирикунӣ ҳангоми бурдани ҳомиладории беморони иллатнокии дил дошта аз ҷунин лаҳзаҳо иборат аст:

- 1. Тартиби беҳдоштӣ (гигиена, беҳдорӣ, саломатӣ) мувофиқат-кунанда;**
- 2. Табобати ҷисмонӣ;**
- 3. Табобати ғизоӣ;**
- 4. Тайёрии пешгирии руҳӣ ба валодат (психопрофилактика);**
- 5. Оксиген-терапия;**
- 6. Табобати доругӣ.**

Ҳомиладорони иллатнокии дил дошта бояд, ки рӯзона дар ҷойгоҳ дар давоми 1-2 соат ва бо ҳоби давомнок (9-11 соат) истироҳат кунанд. Ҳангоми норасогии дилӣ тартибот бо тарзи фарди (индивидуалӣ) муайян карда мешавад. Барои беҳтар гардонидани гардиши хун машқҳое, ки бо чуқур нафас кашидан ва бо ҳаракати бугумҳои дасту пой алоқагӣ доранд, гузаронида мешавад.

Ҳангоми пешниҳоди паҳрезӣ вазифаи витаминҳоро карам, лимон, рағани офтобпараст ва ҷуворимаққа, обпази гули буттагии хордор ва дигарҳо иҷро карда метавонанд. Ҳангоми норасогии идрор ё ҷудошавии пешоб (диурез) ва қабули маводҳои идрорӣ (диуретикӣ) ҳӯрокворихое, ки аз калий бойанд, ба монанди картошка, мавиз, зардолуқоқ, хурмо пешниҳод карда мешавад. Дар ҳолати пайдошавии сарторикии ҳомиладорӣ ҳӯроки беморро тағйир медиҳанд. Барои бемороне, ки иллатнокии дил доранд, тайёрии пайдарпаи пешгирии руҳӣ барои валодат, бартараф кардани тарс пеш аз валодат, муносибати бодикқатонаи духтурон ба бемор аҳамияти калон дорад. Ҳомиладорони иллати дил доштаро дар аввали ҳомиладорӣ барои муоинаи муфасссал, дар 25-26, 32 ва 37-38 ҳафта ва тайёри барои валодат ба тарзи нақшавӣ бистарӣ кардан лозим аст. Ҳангоми пайдошавии нишонҳои талафнопазирӣ дар вақтҳои гуногуни ҳомиладорӣ беморон бояд, ки бо тезӣ бистарӣ карда шаванд ва масъалаи давом додани ҳомилагӣ ҳал карда шавад.

Ҳангоми норасоии назарраси дил қабули дурударози оксигени нармкардашудаи гарм (бо воситаи катраи бинӣ) пешниҳод карда мешавад. Ҳамаи ин чорабиниҳо бо-

яд дар якҷоягӣ бо терапияи доруворӣ, маводҳои дилиюрагӣ, зиддитарбодӣ гузаронида шаванд. Ҳомиладорони норасоии хунгардиши давраи I-IIA дошта, вояи ками панҷаналӣ (наперстянка)-ро истеъмол бояд кунанд. Онро бо миқдори 0,03 - 0,05 г 2-3 маротиба дар 1 рӯз оҳиста-оҳиста то 0,02 г 2 маротиба дар 1 рӯз кам карда дурудароз пешниҳод кардан мумкин аст. Таъсири ҷамъшавии (кумулясия) панҷаналиро (наперстянка) дар бофтаҳо ба ҳисоб гирифта, онро бо строфантин (пешакӣ 2-3 рӯз додани вояи панҷаналӣ манъ карда мешавад) иваз кардан мумкин аст. Агар валодат ногаҳон сар занад, бетанаффус дар табобати панҷаналӣ селонидро ба дохили варид дар маҳлули 5%-аи глюкоза (0,5-1 мл) истифода бурдан мумкин аст. Дар мавриди табобати давомнок селанидро бо 1 ҳаб (0,25мг) ё бо 5-10 ҷақрагӣ 3 маротиба дар 1 рӯз пешниҳод мекунад. Ин мавод қобилияти ҷамъшавиро дорад, барои ҳамин баъди ба даст овардани натиҷаи хуб вояи онро паст мекунад. Коргликони бо дохили варид бо миқдори 0,5 мл маҳлули 0,06% дар 10 мл маҳлули 40%-аи глюкоза якҷоя карда, ворид карда дуру дароз қабул мекунад. Ҳангоми норасоии давраи I дар нимаи аввали ҳомиладорӣ дар давоми 2-3 ҳафта қиём ё шираи алафи испорак ё адрасмонро (горисвет) бо 1 қошуқи ошӣ 4-маротиба дар 1 рӯз қабул кардан мумкин аст. Ҳангоми талафинопазирӣ (декомпенсатсия) давраи IIБ, III строфантин пешниҳод мекунад. Вайро дар давоми 2-дақиқа бо миқдори 0,5-0,75 мл маҳлули 0,05% дар 10-20 мл маҳлули 20%-и глюкоза омехта карда ба дохили варид оҳиста-оҳиста ворид мекунад. Ин мавод ҳангоми норасоии шаруи дил натиҷаи хуб медиҳад. Аз маводҳои пешоброн маводи ғайрисимобӣ гипотиазид бо 1-2 ҳаби (0,05 г) дар як шабонарӯз - 2-3 рӯз пешниҳод мекунад. Пайдошавии гипокалимияро ба ҳисоб гирифта якҷоя хлориди калийро (per os) бо 0,5 г 3-5 маротиба дар 1 рӯз ва ғизоҳои аз намакҳои калий бойро (хурмо, мавиз) пешниҳод мекунад.

Терапияи зиддитарбодиро ҳангоми ҳомиладорӣ ҷӣ дар марҳалаҳои шадид ва ҷӣ дар марҳалаҳои музмин мегу-

заронанд. Дар марҳалаҳои музмин будани ин касалӣ кистозаи асетилсалисилатро бо 2-3 г дар 1 рӯз ва дар марҳалаи шадид то 4 г дар як шабонарӯз пешниҳод мекунанд. Салисилати Na-ро ҳангоми рафти тарбоди ғайрибугумӣ бо 5-6 г дар 1 рӯз қабул мекунанд ва баъд вояи онро то 3-4 г дар як шабонарӯз кам мекунанд. Ҳангоми шакли шадиди тарбод дар вақти ҳомиладорӣ (ба ғайр аз ҳафтаҳои аввали он) салисиллатҳо ва преднизалонро бо миқдори 0,03-0,05 г дар як рӯз қабул мекунанд ва оҳиста-оҳиста вояи шабонарӯзии онро то 0,01 г кам мекунанд. Аз маводҳои ноҳассоскунанда глюконат калсийро дар ҳафтода бо 0,5 г 3 маротиба дар 1 рӯз, димедролро бо 0,01 г дар шаб истифода мебаранд. Ҳангоми баландшавии ҳаяҷоннокӣ қиём ё широи алафи дар биёбон сабзида (настойка пустырника) бо 40 қатра 3 маротиба дар 1 рӯз қабул мекунанд. Дар якҷоягӣ бо терапияи доруворӣ пай дар пай витаминҳоро ворид мекунанд: витамини С бо 100-300 мг дар 1 рӯз (per os); витамини В₁ бо 1 мл маҳлули 5%-а, эрвит бо 1 мл 1 бор дар шабонарӯз ба дохили азола мегузаронанд.

Бурдани валодат ва давраҳои баъдивалодатӣ

Бурдани валодат ва давраҳои баъдивалодатӣ дар ҳомиладорони иллати дил дошта вазифаи масъулро талаб мекунад ва барои ҳамин ба ин гуна беморон пеш аз мӯҳлат диққат додан лозим аст. Лекин, баъзе беморон бо ин гуна иллат ба консултатсия ё таваллудхонаҳо дар охири ҳомиладорӣ ё ин ки дар просесси валодат меоянд, ки ин вақти табобатро маҳдуд мекунад. Бештар вақт заноне, ки касалиҳои дилу раганд, бо роҳи буриши қайсарӣ амалиёт карда мешаванд. Буриши қайсариро ҳомиладороне, ки хипертензияи якҷумини шушӣ, аритмияи милт-милтӣ доранд, вазнин мегузаронанд, барои ҳамин ин гуна занонро буриши қайсар гузаронидан мумкин нест. Дар замони ҳозира нишондод барои валодат бо роҳи буриши қайсарӣ дар чунин ҳолатҳо ба амал меояд:

- 1. Ҳангоми эндокардити зеришадид ва баргарданда;**
- 2. Ҳангоми норасоии митралӣ бо регургитасияи ифодаёфта ва вайроншавии хунгардиш, ҳангоми суддати митралӣ ва**

зиддинишондодҳо ба коррексияи чарроҳии вай, иллатҳои шохрағӣ дар давраҳои инкошофи норасоии хунгардиш;
3. Ҳангоми якҷоягии иллатҳои дил бо якҷоягӣ бо амрози момой (ҳолати кӯндалангии чанин, пешомади машина, коси танг).

Усули беҳтари қарахткунӣ ҳангоми амалиёт беҳушкунӣ (ба воситаи буг ё газ) закиси нитроген бо якҷоягии оксиген ва қабули релаксантиҳои таъсиршон кӯтоҳ аз ҳама гуворо мебошад. Қарахткунӣ чузбӣ танҳо дар вақти номумкин будани беҳушкунӣ ингалясионӣ истифода мешавад. Дар солҳои охир валодат дар занҳо бо иллатҳои дили намуди кабуд дошта, дар шароитҳои оксигенатсияи ҳипербарӣ гузаронида мешавад, ки ин барои чанин ва модар натиҷаи хуб медиҳад. Агар пешакӣ маълум карда шавад, ки валодатро бо роҳҳои табиӣ ба ҷо оварда мешавад, он гоҳ то саршавии фаъолияти валодат промедол (1-2 мл маҳлули 1-2% зери пӯст), маводҳои спазмолитикӣ, витамини В₁ то 0,01-0,02 г дар давраи аввали валодат мегузаронанд. Ба сифати маводи бедардкунанда закиси N-ро бо оксиген (1:1 ё 1:2) бо ёрии дастгоҳи НАП-60 таъсири қатъ кардандоштаро истифода мебаранд. Ҳангоми ҳаста-шавии зани зоянда ҳоби табобатиро бо ёрии ГОМК, предидон (виадрил) истифода мебаранд. Дар давраи 2-юми валодат қарахткунӣ асабҳои чинсиро истифода мебаранд. Ҳангоми ҳодисаҳои талафнопазирӣ ба бемор оксигени нармқардашударо ба воситаи кастораи бинӣ мегузаронанд. Ҳангоми вусъат ёфтани вайроншавии гемодинамика ба дохили варид маводи кардиотоникӣ (строфантин, дигоксин, селанид)-ро ворид мекунанд.

Вақто, ки сараки чанин ба ҳамгӣ ё қаъри кос мефарояд чангакҳои момоиро дар зери таъсири беҳушкунӣ истифода мебаранд. Гузаронидани амалиёти истихроҷ бо ҳаво (ваккум - экстраксия) мумкин нест, барои он ки вай зӯрзаниро бартараф намекунад. Баъди таваллудшавии чанин ба болои ишками зан бори вазнин мегузаронанд (ҳалтаи хокдори вазнаш 800-1200 г), то ки вориди ҳаҷми зиёди хуни аз рағҳои бачадон озодшударо ба гардиши қа-

лони хун қатъ созад. Барои камшудани хунравӣ дар давраи 3-юми валодат дарҳол баъди таваллуди ҷанин ба дохили азалаи зан 1мл эргометрин ё ин ки ба дохили варид 0,25-0,5мл (0,05-0,1мг) метилэргометрин дар 10 мл маҳлули 40%-аи глюкоза гузаронида ва худ аз худ баромадани ҳамроякро интизор мешаванд. Ҳангоми хунравии зиёд, хун ё моддаҳои хунивазкунандаҳоро чакра-чакра мегузаронанд (хун на бояд аз 5 шабонарӯз зиёд нигоҳ дошта шуда бошад). Дар давраи барвакти баъдивалодатӣ занро ба ҷароғи салюкс, гармкунак гарм мекунанд.

Бурдани давраи баъдивалодатӣ диққати махсусро талаб мекунад, барои он ки дар ин вақт вайроншавии гемодинамикӣ, шиддатгирии просесси тарбод бештар ҷой доранд. Ҳангоми иллатҳои талафшуда ва рафти эътидолии давраи баъдивалодатӣ машқҳои хосро дар ҷойгаҳ пешниҳод карда мешавад. Ҳангоми иллатҳои талафнопазиршуда мӯҳлати риояи речаи ҷойгаҳӣ вобаста аз давраи талафнопазирӣ ва фаъолнокии равиши тарбод муайян карда мешаванд.

Нуқтаи назари табобати ҳангоми талафнопазирӣ дар давраи баъдивалодатӣ ба монанди давраи ҳомиладорӣ мебошад.

Шиддатнокшавии ҳавфовари ҳамаи занҳоро, ки иллати дил доранд, ба назар гирифта, терапияи зиддитарбодӣ ва ноҳассоскунандагиро истифода мебаранд; ҳангоми равиши фаъоли тарбодӣ преднизалон илова мекунанд.

Навзодҳо аз ҷунин модарон диққати махсусро талаб мекунанд, барои он ки дар онҳо баъзан ҳипотрофия, вайроншавии инкишоф маълум карда мешавад. Агар дар модари кӯдак талафнопазирӣ инкишоф гирад ва шакли фаъоли тарбод муайян гардад, додани шири сина ба кӯдаки навзод тамоман манъ аст.

Баъди аз статсионар ё шифохона ҷавоб шудан беморро ба зери назорати маслиҳатгоҳ занона ва духтури ноҳиявӣ равон мекунанд. Пешгирии аворизҳо, ки ҳангоми ҳомиладорӣ ва валодат гузаронида мешаванд, ҷунинанд:

1. Сари вақт маълум кардани иллати дил;
2. Сари вақт дида баромадани масъалаи давом додани ҳомиладорӣ;
3. Назорати махсуси тиббӣ, момоён ва терапевтҳо;
4. Бистарӣ кардан;
5. Иҷрои пай дар пай чорабиниҳои табобатӣ.

ҲОМИЛАГӢ ВА БЕМОРИИ БАЛАНДФИШОРӢ

Бемории ҳипертонӣ дар ҳомиладорон баъзан вақт вомерӯрад. Бо як қатор маълумотҳо ин беморӣ дар 1, 2%-и ҳомиладорон дида мешавад. Агар бемории ҳипертоникӣ то ҳомиладорӣ ба вучуд омада бошад, муайян кардани вай мушкул нест.

Ташҳиси беморӣ дар асоси маълумотҳои зерин акс ёфтааст:

1. Сардари дар собиқаи беморӣ, касалии ҳипертонӣ, ки то ҳомиладоршавӣ маълум карда шудааст.

2. Баландшавии фишори артериявӣ то 20 ҳафтаи ҳомиладорӣ.

3. Муайян кардани тағйирёбиҳои амрозӣ аз тарафи дил (тапиши 2 дар асоси дил ва болои шохраг шунида мешавад, гипертрофияи меъдаи чап); дар ЭКГ шиддати қувваи электр (вольтаж)-и дандонаҳои баланшудаи комплекси ORS, пастшавӣ ё дандонаҳои манфии Т, дандонҳои чуқури S₃.

4. Микдори аломатҳои неврологӣ, майнагӣ (серебралӣ), тағйирёбии қаъри чашм (тангшавӣ, печутобхӯрӣ, нобаробарии қутри рағҳои шабакия).

Гузаштани ташҳиси касалии ҳипертоникӣ дар давраи ҳомиладорӣ андаке мушкул мебошад. Вай дар нишондодҳои зерин асос ёфтааст: сари вақт (дар давраи 4-моҳагии чанин) пайдошавии фишори артериявӣ ва вучуд надоштани аломатҳои, ки барои пре/эклампсия хосанд - протеинурия ва варамо.

Баъди маълум кардани касалии ҳипертонӣ, дар ҳомиладорон давраҳои касалиро дида баромадан лозим

аст. Дар давраи 1-и касалӣ ҳомиладориро давом додан мумкин аст; дар давраи 2 асосан дар марҳалаи Б (бо таснифи А. Л. Мясников) ҳомиладориро бояд қатъ кард. Лекин, ҳангоми хоҳиши устуворонаи зани бемор, ки мақсади доштани кӯдакро дорад, ҳомиладориро дар зери назорат ва табобати доимӣ давом додан мумкин аст. Дар давраи 3-юми касалӣ ҳомиладорӣ кам дида мешавад ва умуман манъ аст.

Рафти ҳомиладорӣ ҳангоми касалии ҳипертонӣ як қатор аворизҳоро ба вучуд меорад:

- Норасогии комплекси фетопласентарӣ,
- пайдошавии пре/эклампсия,
- пеш аз мӯҳлат чудошавии машинаи эътидол ҷойгиршуда,
- рафтани хун дар мағзи сар (инсулт),
- ҳипоксия ва ҳипотрофияи тифл,
- таваллуд кардани тифли мурда.

Маълум карда шудааст, ки фоизи аворизҳои ҳомиладорӣ дар беморони давраи 2-юми касалии ҳипертонӣ нисбат ба даври 1-ум баландтар мебошад. Ҳамин ҳел гестози дерина дар 41,2-53%-и ҳолатҳо, чудошавии пеш аз мӯҳлатии машина дар 1,2%, бугшавӣ (асфиксия)-и тифл дар шиками модар дар 5,3-1,3%, бачапартоӣ дар 8,8%, энсефалопатияи ҳипертонӣ дар 2% дида мешавад.

Рафти касалии ҳипертонӣ дар вақти ҳомиладорӣ хусусиятҳои хоси худро дорад. Қариб дар нисфи ин беморон фишори артериявиашон дар 14-ҳафтаи аввали ҳомиладорӣ баланд мешавад. Дар мобайни ҳомиладорӣ ин фишор баъзе вақт паст мешавад (дар давраи 1-и касалӣ то сатҳи эътидолӣ мерасад ва дар давраи 2-юм аз он пастар мешавад). Дар 3-моҳи боқимондаи ҳомиладорӣ фишори артериявӣ дар бисёр ҳолатҳо меафзояд. Дар ҳолати шиддатгирии касалӣ, ки дар вақтҳои гуногуни ҳомиладорӣ метавонад ба вучуд ояд, фишори артериявӣ аз ҳад зиёд баланд мешавад.

Рафти валодат дар заноне, ки касалии ҳипертонӣ доранд хосиятҳои хоси худро дорад: тез-тез презеклампсия,

эклампсия ба вучуд омада, хунравии зиёд дар давраи 3-юми валодат дида мешавад. Дар соатҳои аввали баъдивалодатӣ фишори артериявӣ тез-тез ва зиёдтар паст мешавад (ба 90-105 мм. сут. сим.) ва дар рӯзҳои оянда бошад, боз баланд мешавад.

Табоботи касалиҳои ҳипертоникӣ дар ҳомиладорон фардӣ гузаронанда мешавад ва аз давраҳои касалӣ вобаста аст. Табобат бояд, ки умумӣ бошад: речаи мудофиакунанда, диетотерапия (миқдори даркории карбогидратҳо дар хӯрок), табоботи оромбахш ва антигипертензионӣ: адонис бром, новопоссит; нифедипин, метилдопа, клофелин ва лабетолол.

Дар асоси маълумотҳои назораткардашуда маълум карда шудааст, ки баъди валодат, дар заноне, ки касалии ҳипертонӣ доранд, беморӣ метавонад авҷ гирад ва ба зинаҳои вазнин гузарад.

ҲОМИЛАДОРӢ ВА КАМХУНӢ

Инкишофи ҳомиладории эътидол ба тағйирёбии таркиб ва миқдори хуни атрофӣ оварда мерасонад. Аз ҳисоби гидремия - зиёдшавии миқдори плазма, миқдори умумии хун нисбат ба сатҳи бадан зиёд мешавад; дар якҷоягии ин ғоизи гемоглобин ва миқдори эритроцитҳо дар воҳиди ҳаҷми хун паст мешавад. Дар ҳафтаҳои аввали ҳомиладорӣ суръати таҳшиншавии эритроцитҳо зиёд шуда, оҳиста-оҳиста миқдори лейкоцитҳо (нейтрофилҳо) афзуда, миқдори албуминҳо дар хун кам мешавад.

Анемия дар ҳомиладорон то 70-80% дида мешавад. Дар 70-95% ҳолатҳо ин анемия гипохромӣ буда, дар натиҷаи норасоии оҳан вусъат меёбад. Баъзан вақт дигар шаклҳои анемия воমেҳӯранд. Анемияи гиперхромӣ – В₁₂-фолиеводефиситӣ (мегалобластикӣ), анемияи гемолитикӣ ва гипопластикӣ. Анемия метавонад то давраи ҳомиладоршавӣ ҳам пайдо шавад. Бештар вақт бошад, он дар рафти ҳомиладорӣ (асосан дар давраи 2-юми он) вусъат меёбад.

Дар таърихи беморони анемияи гипохромӣ дошта маълумотҳо дар бораи миқдори барзиёди касалиҳои пеш гузаронидашуда диққатро ба худ ҷалб мекунад: бемориҳои шадиди сироятӣ, зуком, бемориҳои меъдаю рӯда, инвазияҳои кичҷавӣ, тонзиллит, отит, гайморит, хунравии такрорӣ. Дар баъзе беморони анемия дошта, шаклҳои вайроншавии инкишоф: менархе дермонда (дар 17 солагӣ ё дертар аз он), сикти чанинӣ, валодати пеш аз мӯҳлат ва инчунин гипотензия дида мешаванд.

Ҳангоми таҳқиқи шираи меъда ахилияи мӯътадил ба назар мерасад, ки ин дар бораи алоқаи байни анемия ва ахилия шаҳодат медиҳад. Дар баъзе беморон анемия метавонад ҳамчун бемории касбӣ, ки бо вайроншавии шароитҳои санитарӣ - беҳдошти меҳнат вобастагӣ дорад, ба вучуд ояд. Дар патогенези анемияи гипохромии ҳомиладорон чунин омилҳо аҳамият доранд:

- 1. Вайроншавии ҷабиши оҳан (ахилия);**
- 2. Хӯроки камсамар (норасогии оҳан);**
- 3. Сарфи баланди оҳан ҳангоми ҳомиладорӣ (дар рафти просесси инкишофи чанин то 500 мг оҳан сарф мешавад);**
- 4. Мубодилаи баланди бофтагӣ ҳангоми ҳомиладорӣ.**

Дар баъзе занон анемияи гипохромӣ дар натиҷаи хунравии сикти чанин, пешомади машина, пеш аз мӯҳлат ҷудошавии машина, даридани бачадон вусъат меёбад.

Ҳангоми таҳқиқи хун маълум мекунам, ки мувофиқи пастшавии консентрасияи гемоглобин миқдори эритроцитҳо кам шуда (андозаи нишондоди рангӣ паст мешавад), қутри мобайни эритроцитҳо хурд шуда ва миқдори оҳан дар зардоби хун кам мешавад, гипохромияи онҳо анизо- ва пойкилоситозро ба вучуд меоварад, миқдори нейтрофилҳо кам мешавад. Ҳангоми аз назар гузаронидани пӯст ва луопардаҳо берангшавии ба қайд гирифта мешавад, баъзан ҳомиладорӣ бо ҳарорати субфебрилӣ мегузарад. Таҳқиқи резистентнокии эритроцитҳо, миқдори билирубин ва консентрасияи оҳан

дар зардоби хун дар бораи вайроншавии зиёди эритроцитҳо шаҳодат медиҳад.

Тасвири клиникӣ анемия:

**мондашавии сабук,
сарчархзанӣ,
камқувватӣ,
дилзанӣ,
тангнафасӣ,
пайдошавии ҳол дар пеши чашм,
тангнафасӣ ҳангоми сарбории ҷисмонӣ,
рехтани мӯйҳо, шикастани нохунҳо,
вайроншавии мазза.**

Ташҳиси анемияи гипохромӣ бо маълумотҳои таҳқиқи клиникӣ ва гематологӣ асос ёфтааст.

Рафти валолат ва давраи баъдивалолатӣ ҳангоми анемия як қатор хосиятҳои худро дорад: фоизи хунравии гипотоникӣ, гузаронидани ҷарроҳӣҳо дар давраи 3-юми валолат ва дар давраи баъдивалолатӣ, касалиҳои септикий баъдивалолатӣ баланд мешаванд.

Инкишофи кӯдакон ва навзодон бо ягон хосиятҳоиашон аз якдигар фарқ намекунанд. Ҳангоми якҷо шудани анемия бо гестози дерина ва амрози дилию рагӣ дар навзоидашудагон тез-тез шаклҳои гуногуни гипотрофия, асфиксия ва садамаи дохилии косаи сар дида мешавад.

Табобати анемияи гипохромӣ дар давоми хомиладорӣ бо пешниҳоди парҳези аз оҳан бой буда ва доруҳои оҳандор асос ёфтааст. Бемороне, ки аз анемияи камчинии оҳан азоб мекашанд, бояд ҳӯрокеро, ки аз гӯшт ва чигар (дар намуди ҷӯшонидашуда) бой аст, истеъмол кунанд. Дар якҷоягӣ бо себ, сабзӣ, анор, лаблабӯ, котисиёҳ, витаминҳои В₁₂, В₁, В₆, ва кислотаи аскарбинатро ҳам истифода бурдан лозим аст.

Усули асосии табобати дарунии анемияи оҳанкамчинӣ ин қабули доруҳои оҳандор на бо роҳи парентералӣ, балки бо воситаи хӯрдан мебошад. Аз ҳама самаранок ин хабҳои феррокал (2-6 хаб ҳангоми хӯроки 3

маротиба дар як рӯз), ферроплекс, феррамид, гемостимулин буда, онҳоро бо кислотаи аскорбинат қабул кардан зарур аст. Ҳангоми пешниҳоди табобат ташҳиси касалиро дуруст кардан лозим аст, чунки вай метавонад сабаби камчинии оҳан дар организм (заҳми меъдаи хунраванда, рӯдаи 12-ангушта) шавад.

Табобати пай дар пай бо ин доруҳо самаранок буда барои гузаронидани хун имконияте намедиҳад. Ҳангоми анемияи пасгеморрагӣ табобати пай дар пай ва гузаронидани доруҳои оҳандор пешкаш карда мешавад.

Анемияи мегалобластии гиперхромӣ дар шароитҳои хати миёнаи собиқ ИДС баъзан воমেҳӯрад: дар як қатор ноҳияҳои ҷанубӣ ин шакли анемия ҳомиладориро мураккаб мегардонад. Дар патогенези вай норасоии витамини В₁₂ аҳамият дорад, ҳамин ҳел анемияи гиперхромиро ҳамчун гиповитаминоз ҳисоб кардан мумкин аст.

Тасвири клиникии анемияи гиперхромӣ хело характернок мебошад. **Ба ғайр аз шаклҳои маълум буда (сусти, сарчархзанӣ, берангшавӣ, тахикардия, гипотезния), аз тарафи роҳи ҳозима вайроншавии иштиҳо (анорексия), камхунӣ, дилбеҳузурӣ, глоссит, стоматит, гипо- ва ахлогидрия, метеоризм, диарея, калоншавии ҷигар ва сипурз, варамҳо, протеинурия дида мешавад.** Ҳангоми таҳқиқи гематоликий аз ҳад зиёд пастшавии миқдори гемоглобин ва баландшавии эритроцитҳо, нишондоди рангини баланд (дар баъзе беморон), анизоситоз бо бартарии микроцитҳо, пойкилоситоз, пайдошавии мегалоситҳо ва мегалобластҳо меёбанд. Ҳангоми таҳқиқи хуни сафед лейкопения, ҳаракати нейтрофилҳо ба тарафи чап, эозинофилия, лимфопенияро ошкор кардан мумкин аст.

Барои табобат витамини В₁₂ (200 мкг ҳар рӯз ё як рӯз пас ба дохили азала)-ро маъмулан дар давоми 2-3 ҳафта қабул кардан зарур аст. Ҳангоми дар вақташ маълум кардани касали табобати пай дар пай самаранок хуб медиҳад.

Анемияи гемолитикӣ ва гипопластикӣ ҳангоми ҳомиладорӣ кам воমেҳӯрад. Бо назардошти ҷиддӣ будани

беморӣ масъаларо дар бораи дуруст гузоштани ташхис ва нигоҳ доштани ҳомиладорӣ бояд ҳангоми консултатсия бо гематолог ҳал кард.

ПЕШ АЗ МҶҲЛАТ ҚАТЪ ГАРДИНДАНИ ҲОМИЛАДОРӢ СИҚТИ ЧАНИН (БАЧАПАРТОӢ)

Сиқти чанин, ё бачапартоӣ, ин қатъ гардидани ҳомилагӣ дар давоми 22 ҳафтаи аввали ҳомиладорӣ (5,5 моҳи момой) мебошад. Қатъ гардидани ҳомилагӣ баъди 22 ва то 37 ҳафтара валодати пеш аз мҶҲлатӣ меноманд.

Ҳангоми муайянкунии сарҳади байни сиқти чанин ва валодати пеш аз мҶҲлатӣ дараҷаи қобилияти ҳаётии чанин ба ҳисоб гирифта мешавад. Чанинҳое, ки то 22 ҳафтаина буданашон таваллуд мешаванд, қадашон 30 см буда вазнашон аз 500 г кам мебошад. Дар бисёр ҳолатҳо, инчунин ҳангоми нигоҳубини чиддии тифл онҳо қобилияти ҳаёӣ надоранд.

Кӯдаконе, ки пеш аз мҶҲлат таваллуд шудаанд ва вазнашон то 500 г ва аз он зиёд, қадашон то 30 см ва аз он боло ҳангоми нигоҳубинии муносиб зинда мемонанд. Чӣ қадаре, ки валодатҳои пеш аз мҶҲлатӣ ба охири ҳомиладорӣ физиологӣ наздик шаванд, ҳамон қадар қобилияти ҳаётии кӯдак баланд мебошад. Сиқти чанин дар давраи 14-15 ҳафтаи аввал сиқти барвақт номида мешаванд, баъди ин мҶҲлат, яъне баъди 14-15 ҳафтаина будани чанин, сиқти дер номида мешавад. Мафҳуми «сиқти чанинии дер»-ро бо мафҳуми «валодатҳои бемаврид» ё валодати тифли норасо иваз кардан мумкин аст.

Баъзан чанине, ки пеш аз 22 ҳафтаи аввал таваллуд шудааст, вазнаш аз 500 г кам ва қадаш аз 30 см аст қатъ гардонии ҳомиладорӣ ҳамчун валодати пеш аз мҶҲлати новобаста аз вазни бадан ва қади навзод ҳисобида мешавад. Вобаста аз ҳосияти ба вучудой сиқти чанин ба 2 гурӯҳҳои асосӣ ҷудо мешавад.

1. Беихтиёрона (худ аз худ)

2. Сунъй.

Сикти беихтиёрона бе ягон муҳофизат бар ҳилофи хоҳиши зан ба амал меояд. Агар сикти беихтиёрона аз 2 маротиба зиёдтар такрор ёбад, онро сикти одатшуда (омӯхта шуда) меноманд.

Сикти сунъӣ ин қатъкунии ғарзнокӣ ҳомиладорӣ мебошад. Сикти сунъӣ бо хоҳиши зан ё бо тавсияи духтур ҳангоми бемориҳои гуногун, ки рафти онҳо дар вақти ҳомиладорӣ вазнин мешавад, ба ҷо оварда мешавад. Сикти сунъӣ бояд, ки дар муассисаҳои табобатӣ гузаронида шавад. Дар баъзе ҳолатҳо (ҳангоми ҳолатҳои мураккаби маишӣ ва руҳӣ) занон сикти сунъиро на дар муассисаҳои табобатӣ, балки дар дигар ҷойҳо мегузаронанд, ин тарзи муҳофизаткунии сикти ғайра берун аз беморхонагӣ (чиноятӣ) меноманд.

СИКТИ БЕИХТИЁРОНА ВА САБАБҲОИ БА ВУЧУДОИИ ОН

Сикти беихтиёрона ба он намудҳои амрози момӣ дохил карда мешавад, ки онро духтур бисёр вақт дида менамояд. Маълумотҳои дурусти ҳисобӣ дар бораи сикти беихтиёрона хело каманд, дар бораи миқдори онҳо бо маълумотҳои бевосита ҳукм меронанд (мутаносиби байни миқдори заноне, ки ба беморхона ба сабаби сикти беихтиёрона омадаанд, бо миқдори умумии занони ҳомиладор ва занони навазод, ки дар ин вақт ба беморхона омадаанд). Мувофиқи маълумотҳои як қатор муаллифони, сикти беихтиёрона 2-8%-и миқдори умумии ҳомиладориро ташкил медиҳад. Дар Тоҷикистон он ба 10-11% мерасад. Сабабҳои сикти ҷанини беихтиёрона (бачапартоӣ) аз рӯи ҳосиятҳои гуногун ва бисёр мебошанд. Дар байни онҳо омилҳо ва сабабҳои моил кардашуда, ки бевосита сиктро ба вучуд меоранд ҷудо карда шудаанд. Ба омилҳои моил мекардагӣ бемориҳо захролудӣ, вайроншавии функционалӣ дар занони ҳомиладор ва ба сабабҳои, ки бевосита сиктро ба вучуд меоранд - зарбҳои ҷисмонӣ ва руҳӣ дохил мешаванд. Омилҳои, ки сабаби бевоситаи бачапартоӣ мебошанд, И. Л. Брауде онҳоро омилҳои

«бартарафкунанда» номид. Ин омилҳо просесси ба охир расонино иҷро мекунонд. Чунин тақсимои омилҳои этиологӣ барои он бомаврид аст, ки ба сикти беихтиёроиа, ҷамъи сабабҳои моил мекардагӣ ва бартарафкунанда, оварда мерасонанд. Лекин чунин таснифот, аномалияи ба генетикаи ҷанин хос бударо, ки ба вайроншавии инкишофи ҷанин ва партофтани он оварда мерасонад, ба ҳисоб намегирад.

Дар поён омилҳои асосии, ки сабабгори инкишофи сикти беихтиёроиа номбар карда шудаанд:

1. **Инфантилизм**
2. **Вайроншавии нейроэндокринӣ**
3. **Қаъкунии сунъии ҳомиладорӣ**
4. **Норасогии истмико-сервикалӣ**
5. **Аномалияи хромосомӣ ва генӣ**
6. **Аномалияи тухмхуҷайра ва сперматозоидҳо**
7. **Бемориҳои сироятӣ**
8. **Бемориҳои сироятии музминӣ**
9. **Номувофиқии изоантигении хуни**
10. **Бемориҳо ва иллатнокиҳои инкишофи узвҳои ҷинсӣ**
11. **Заҳролудшавии**
12. **Зарбаҳои**

Зарбаҳои саҳти руҳӣ

Давраҳои рафти (зоҳиршавии) сикт. Чунин давраҳои рафти сикти ҷанинро фарқ мекунонд:

- **Сикти саршуда (шурӯъшуда, оғозшуда);**
- **Сикти авҷгирифта;**
- **Сикти нопурра;**
- **Сикти пурра.**

Сикти саршуда. Дар ин давраи сикт дардҳои муҳозмонанд (кашишкунанда) пайдо шуда, хунравии на он қадар бисёр дида мешавад. Лекин хунравӣ нисбат ба хунравии сикти хавфовар бисёртар ба назар мерасад. Ҳанин аз сатҳи на он қадар калони бачадон ҷудо шудааст, вай дар бачадон ҷойгир мебошад, барои ҳамин ҳаҷми бачадон ба муҳлати ҳомиладорӣ мувофиқ меояд. Канали гарданак ё

маҳкам ё ин ки нимкушо мебошад. Райд кардан лозим аст, ки ҳангоми норасогии истмико-сервикалӣ канали гарданаки бачадон ҳангоми хавфи сиқт ва сиқти саршуда низ андаке кушодтар аст. Ҳангоми сиқти саршуда кӯшиш кардан лозим аст, ки ҳомиладорӣ нигоҳ дошта шавад, лекин дар ин давраи сиқтӣ нисбатан натиҷаи хуб кам ба даст оварда мешавад.

Сиқти авчгирифта - чунин давраи чараёни сиқтӣ мебошад, ки чанин аз девори бачадон ҷудошуда аз ковокии бачадон ба канали гарданаки он тела дода мешавад. Ҳангоми таҳқиқи маҳбалӣ маълум карда мешавад, ки канали гарданаки бачадон кушода аст ва дар он чанин муайян карда мешавад. Тарафи поёни тухм ба маҳбал фаромадааст. Сиқти барвақтина баъзан вақт бо хунравии бисёре чараён мегирад. Дар ин намуди сиқт нигоҳ доштани ҳомилагӣ номумкин аст, чанинро бо тезӣ бояд аз ковокии бачадон бартараф кард.

Сиқти нопурра. Агар як қисми тухми чанин баромада бошад ва қисми дигараш дар ковокии бачадон боқӣ монад, он гоҳ инро сиқти нопурра меноманд. Дар бачадон асосан пардаи обию мӯякчаҳои десидуалӣ ва қисми машина боқӣ мемонанд. Сиқти нопурра ба хунравӣ мусоидат мекунад; хунравӣ мумкин аст, ки давомнок, миёна ё фаровон бошад. Ҷӯяи гарданаки бачадон ангуштро гузаронида метавонад, дар ин ҳолат даҳанчаи берунӣ ва дарунӣ кушода аст. Хачми бачадон ба мӯҳлати ҳомиладорӣ мувофиқ намеояд. Қисми боқимондаи чанин метавонад сабаби пайдошавии хунравӣ ва беморихое, ки бо сироят вобаста аст, гардад ва барои ҳаёт ниҳоят хавфнок мебошад.

Сиқти пурра - ин чунин сиқтест, ки дар чараёни он чанин пурра аз ковокии бачадон (баъзан вақт вай пурра мебарояд) мебарояд. Ҳангоми сиқти пурра бачадон кашиш меҳӯрад, канали гарданаки бачадон маҳкам шуда, хунравӣ манъ мешавад. Дар мӯҳлатҳои барвақти ҳомиладорӣ сиқти пурра нисбат ба мӯҳлатҳои дерӣ ҳомиладорӣ кам дида мешавад.

Сикти сироятнок. Ҳангоми чараёни сикти дурударози беихтиёрӣ аз маҳбал ба бачадон микробҳо, аз он чумла, стафилакоккҳои патогенӣ, стрептококкҳои патогенӣ, энтерококкҳо, анаэробҳо (бактериоидҳо, пептококкҳо ва ғ.) ва дигар микроорганизмҳо гузашта метавонанд. Бисёр вақт сироят ҳангоми сунъӣ манъкунии ҳомиладорӣ бо усулҳои ғайритиббӣ гузашта метавонад. Дар ин ҳолат ба ғайр аз сирояти коккҳо баъзан вақт ба бачадон анаэробҳо гузашта метавонанд. Микробҳое, ки ба бачадон гузаштаанд, ҳангоми сикт барои инкишофи худ муҳити хуберо меёбанд. Ин ҳел муҳит хун ва қисмҳои ҷудошудаи тухми чанин мебошанд. Микробҳое, ки ба бачадон гузаштаанд, элементҳои тухми чанинро сироятнок мекунанд. Дар оянда ин просесс метавонад ба бачадон, найчаҳои он, тухмдонҳо, сифоқи кос гузарад. Соқиткунии сироятнокӣ метавонад сабаби пайдошавии касалиҳои умумии септикӣ, ки барои ҳаёти занон хавфнок аст, гардад. Маҳдудкунии просесс дар минтақаи тухми чанин ё паҳншавии вай дар бачадон ё берун аз он аз заҳрдор будани (вирулентнокӣ) микроб ва муқовимати организм вобаста аст.

Вобаста аз давраҳои паҳншавии сироят чунин сиктҳоро фарқ мекунанд:

1. Сикти беаворизи табларзагӣ (сироят дар бачадон ҷойгир аст);

2. Сикти табларзагии авориздор (сироят аз бачадон дур шудааст, лекин просесс дар минтақаи коси хурд маҳдуд аст);

3. Сикти септикӣ (сироят ҳосияти паҳнёфтаре мегирад).

Ҳангоми сикти табларзаии беавориз сироят аз бачадон берун шуда паҳн намешавад. Ҳангоми соқиткунии табларзагии авориздор сироят бо роҳи лимфогенӣ ва гемогенӣ ё ин ки бо найчаҳои бачадон берун аз бачадон паҳн мешавад. Барои ҳамин илтиҳоби изофаҳои бачадон (салпингоофарит), сифоқи косӣ (пелвиоперитонит), насчи назди бачадон (параметрит) ва дигар қисмҳои насчи коси хурд вусъат мегирад. Просессҳои илтиҳобӣ бисёр вақт ба

фасодшавӣ ва чамъшавии фасод дар пайгаҳҳо (пиосалпинкс), тухмдонҳо (пиовариум), чуқурии бачадону рӯдаи рост, сифоки косӣ ва насчи коси хурд оварда мерасонад.

Чараёни клиникӣ сикти чанин аз давраҳои паҳншавӣ ва хосияти просесс вобаста мебошад. Ҳангоми ба вучуд омадани просессҳои фасодӣ тасвири клиникӣ вазнин мебошад. Ҳолати умумӣ вазнин шуда, ҳарорат аз ҳад зиёд баланд мешавад, вайроншавии системаи асаб, мубодилаи моддаҳо, тасвири хун, тағйирёбиҳо дар дигар системаҳо ва узвҳо ба вучуд меоянд. Симптомҳои барои салпингофарит, параметрит, пелвиоперитонит хос ба қайд гирифта мешаванд. Тасвири клиникӣ сикти септикӣ бо чараёни вазнин ва мураккаб фарқ мекунад. Ҳолати бемор вазнин, ҳоб вайроншуда, иштиҳо нест, забон хушк, пӯст беранг, баъзан вақт варамҳои зардгарӣ ва хокистаранг дида мешаванд. Нишонаҳои барвакти ин намуди сикт ҳарорати баланд ва беҳад зиёдшавии набз, ки ба ҳарорат мувофиқ намеояд, мебошад. Дар бисёр мавридҳо тромбофлебитҳо ва абсессҳои метастатикӣ дар шуш, гурдаҳо, насчи зерӣ пӯст ва дигар минтақаҳо ба вучуд меоянд. Хараёни клиникӣ сикти септикӣ (инчунин саршавӣ ва натиҷаҳои он) ба рафти сирояти септикӣ ва норасоӣ монанд мебошад. Мумкин аст, ки садамаи септикӣ ва норасоии шадиди гурда вусъат ёбад.

Пешгирӣ ва табобати сикти беихтиёрон пеш аз ҳама дар омӯзиш ва барҳамдиҳии сабабҳои пайдошавии ин амроз асос ёфтааст. Пешгирии бемориҳои сироятӣ, чараёнҳои беҳдоште, ки ба пешгирии инфантилизм, вайроншавии эндокринӣ ва дигар бемориҳо ёрӣ мерасонанд, аҳмияти калон дорад. Дар ҳолатҳои бо ҳам муносиб (мувофиқ) бартараф кардани ҳар гуна захролудӣ ва таъсири дигар омилҳои зараррасони муҳити берунӣ ҳатмист. Дар комплекси чораи қатъӣ бар зидди сикти чанин ҳӯроки дуруст ва ғизои аз витаминҳо бой аҳмияти калон дорад, ки ин дар давраҳои зимистон ва баҳор хело зарур мебошад. Маҳдудкунии сикти сунъӣ (хусусан қатъкунии ҳомилагии аввалин), чораи асосии пешгирии сикти беихтиёр мебо-

шад. Дар ин маврид қабули маводҳои самаранок ва зарарнораси пешгирии ҳомилагӣ истифода бурда мешавад. Занонро, ки сикти беихтиёро на аз сар гузаронидаанд, бодикқат муоина карда, сабабҳои пайдоиши ин амрозо бояд муайян кард, баъд то саршавии ҳомилагии оянда таболати мувофиқро бояд гузаронд. Дар мавриди мавҷуд будани нишондодҳо чорабиниҳои умумӣ, муолиҷаи физиотерапевтӣ, маводҳои зидди илтиҳобӣ ва ғайраҳоро гузаронидан лозим аст. Ҳангоми мавҷуд будани носурҳои гарданаку маҳбал, чуқур даридани гарданаки бачадон ва норасоии истмико-сервикалӣ бояд таболати ҷарроҳӣ - амалиёти пластикӣ барои бартарафкунии норасоии қисми истмикӣ ва ҷои даридани гарданаки бачадон зарур аст. Бо роҳи ҷарроҳӣ синехияҳоро, ки баъди тарошидани бачадон ба вучуд омаданд, бояд гирифта партофт. Инчунин иллатҳои инкишофи бачадонро, ки ба соқиткунӣ сабабгор шуда метавонанд, бояд бартараф кард.

Дар маркази солими репродуктивӣ тамоми занонро, ки дар собикаи момой сикти беихтиёро на, соқиткунии одатӣ доранд, ҳомиладороне, ки гирифтори инфантилизм ва вайроншавии эндокринологӣ мебошанд ба қайд мегиранд. Чунин занонро бодикқат нигоҳубин карда, риояи саҳти тартибро пешниҳод мекунанд, ки инҳо; ҳӯроки дурӯст, барҳамдиҳии мутасиркунандаҳои эмосионӣ ва ҷидду ҷаҳди ҷисмонӣ мебошад. Ҳангоми ба вучуд омадани омилҳои хавфнок зани ҳомиларо ба таболатгоҳ раво мекунанд. Дар он ҷо бояд, ки тамоми шароитҳои оромӣ, ҷисмонӣ, руҳӣ ба ғайраҳо фароҳам оварда шуда бошанд.

Таболат дар мавриди сикти саршуда асосан ба монанди таболати давраи пешинаи исқот мебошад. Тартиби бистариро бечуну ҷаро бояд риоя карда, пай дар пай доруҳоро, ки ҳаяҷоннокӣ ва фаъолияти кашишқунии бачадонро паст мекунанд, бояд қабул кард. Агар сабабҳои саршавии сикт бемориҳои вазнини сироятӣ ва захролудшавӣ бошанд, таболати бомақсад ва устувору бахавф бояд бошад, чунки дар ин ҳолат бисёртар ҷанин зарар мебинад. Агар таболат бенатича (бесамар) бошад

хунравӣ дуру дароз давом карда, шиддатнок шавад, барои гирифта партофтани тухми чанин нишондод пайдо мешавад.

Ҳангоми сикти авчгирифта тухми чанинро бо ёрии асбобҳои махсус бартараф кардан зарур аст. Ин амалиётро ба таври таъҷилӣ мегузaronанд, то ин ки хунравии зиёд ва ё сироят пешгирӣ карда шавад. Дар ҳолатҳои сикти дер, ки дар давоми он одатан хунравии зиёд дида намешавад, то он вақте, ки таваллуди беихтиёри чанин ва ҳамроҳаки он зоҳир нагардад, интизор шудан мумкин аст; баъди ин агар шубҳае дар бораи пурра таваллуд шудани чанин ва ҳамроҳак пайдо шавад, он гоҳ бачадонро тарошидан лозим аст.

Сикти пурра – бо кашишкунии бачадон ва теладиҳии тамоми тухми чанин аз ковокии бачадон берун бароварда мешавад. Лекин ҳангоми сикти пурра, асосан дар он сикте, ки дар мӯҳлатҳои барвақти ҳомиладорӣ ба вучуд омадааст, дар бачадон асосан пардаи десидуалӣ (мӯякчаҳои хорион) нигоҳ дошта мешавад. Пардаи десидуалии нигоҳдошташуда ба таҷдиди (регенаратсияи) луобпардаи бачадон мусоидат мекунад; вобаста ба ин чудошавии хуноба дуру дароз давом карда, барои инкишофи сироят ҳавф пайдо мешавад (эндометрити десидуалӣ). Барои ҳамин баъди сикти пурра дар мӯҳлатҳои барвақти ҳомиладорӣ тарошидани бачадон бо мақсади бартараф кардани қисми манъшудаи пардаи десидуалӣ пешкаш карда мешавад. Ҳангоми сикти дерӣ пурра тарошидани бачадонро танҳо дар ҳолати манъшавии қисме аз ҳамроҳак ё ҳангоми пайдо шудани шубҳа ба манъшавии як қисми тухми чанин гузаронидан зарур аст. Агар дар вақти муоинаи тухми чанини афтода дар бораи пуррагии вай шубҳае пайдо нашавад, он гоҳ аз мудоҳилаи ҷарроҳӣ бояд даст кашид.

Сикти нопурра – бо сабаби хунравии зиёд, сирояткунонии қисми боқимондаи тухми чанин, бачадон бо изофааш, сифоқи кос ва насчи он хавнок мебошад. Барои ҳамин, ҳангоми сикти нопурра қисмҳои боқимондаи тух-

ми чанинро аз дохилии бачадон баъди гузоштани чунин ташхис ба таври тарошидан бартараф кардан лозим аст. Танҳо бо асбобҳои махсус ҳолӣ кардани бачадон бемаврид мебошад, ҳангоми сикти дерина машимаро бо ангуштон бартараф мекунанд, баъзе момоён баъди ин оҳиста-оҳиста бачадонро тарошида тоза мекунанд.

БИСЁРОБӢ. КАМОБӢ.

Обҳои наздитифлӣ - муҳити моеъест, ки тифлро ихота мекунад, байни тифл ва организми модар воқеъ аст. Ҳангоми ҳомиладорӣ обҳои наздитифлӣ тифлро аз фишор ихота мекунанд, имконият медиҳанд, ки тифл нисбатан озодона ҳаракат кунад, инчунин барои дуруст ҷойгиршудани тифл дар бачадон мусоидат мекунад. Ҳангоми таваллуд обҳои наздитифлӣ фишори дохили бачадонро баробар мекунанд. Қутби поёни бораки обӣ барангезандаи физиологии ресепторҳои даҳанаи дохили гарданаки бачадон мебошад. Обҳои наздитифлӣ вобаста аз мӯҳлати ҳомиладорӣ аз манбаъҳои гуногун пайдо мешавад. Дар мӯҳлатҳои бармаҳали ҳомиладорӣ ҳамаи сатҳи амнион вазифаи тарашуҳиро иҷро мекунад, дертар мубодила бештар аз сатҳи машинавии амнион ба вучуд меояд, инчунин шуш ва гурдаҳои тифл манбаи мубодилаи обӣ мебошанд.

Таносуби об ва дигар қисмҳои таркиби обҳои наздитифлӣ танзими динамикии мубодиларо нигоҳ медорад. Мубодилаи пурраи обҳои наздитифлӣ дар зарфи 3 соат ба вучуд меояд. Ҳаҷм ва таркиби обҳои наздитифлӣ аз мӯҳлати ҳомиладорӣ, вазни тифл ва андозаи машина вобастагӣ дорад. Бо мурури инкишофи ҳомиладорӣ миқдори моеъи амнионӣ аз 30 мл дар ҳафтаи 38-ӯм миқдори об ба нуқтаҳои балантарин расида, дар ҳафтаи 40-ум каме паст мешавад, яъне ба 600-1500 мл бо ҳисоби миёна ба 1200 мл баробар мешавад.

Миқдори обҳои наздитифлӣ аз 1500 мл зиёд бошад, бисёробӣ меноманд, басомади $\bar{y}$ 0,3-0,5%-ро ташкил медиҳад.

Сабаб. Бисёробӣ метавонад ҳамрадифи аворизҳои гуногуни ҳомиладорӣ бошад. Аксар вақт бисёробиро дар занҳои ҳомилае, ки уфунати музмин доранд, вомерӯрад, масалан: пиелонефрит, бемориҳои илтиҳобии маҳбал, уфунати шадиди респираторӣ, уфунатҳои махсус (сифилис, хламидиоз, микоплазмоз). Бисёробӣ, ҳамчунин дар занҳое, ки патологияи экстрагениталӣ доранд - диабети қанд, ҳомиладории номувофиқатии омили резус, ҳангоми ҳомиладории бисёртифлӣ, нуқсонҳои инкишофи тифл (осебияти системаи марказии асаб, наи ҳозима, поликистоз гурдаҳо, аномалияи скелет) вомерӯрад. Бисёробии шадид ва музминро фарқ мекунанд, ки дар семоҳаи II ва III ба вуҷуд меояд.

Зухуроти сарирӣ. Аломатҳои бисёробӣ ҳангоми чараёни шадиди ӯ хеле хуб ифода ёфтаанд: сустҳои умумӣ, дард ва вазнинӣ дар шикам ва қамар. Ҳангоми бисёробии шадид аз ҳисоби боло истодани диафрагма нафасгирӣ, вайрон шудани фаъолияти дил дида мешавад. Бисёробии музмин одатан зухуроти сарирӣ надорад: ҳомиладор ба тадриҷан чамъшавии об мутобиқ мешавад.

Таъхир аз рӯи шикаҷтҳо, ҳолати умумии зани ҳомиладор, муоинаи дохилии момой ва усулҳои махсуси муоина гузошта мешавад. Шикаҷтҳои зани ҳомиладор чунинанд: гумшавии иштиҳо, тангнафасӣ, сустҳолӣ, ҳисси вазнинӣ ва дард дар шикаму қамар. Ҳангоми муоинаи объективӣ пӯсти рӯй сафедҷатоб, камшавии чарбуи зери пӯст мушоҳида мешавад, дар баъзеи онҳо инъикоси варидӣ дар шикам пурзӯр мегардад. Андозаи гирди бачадон ва баландистии каъри бачадон ба мӯҳлати ҳомиладорӣ мувофиқат намекунад, яъне андозаҳо калонанд. Бачадон калон, пуршиддат ва чандир буда, дорои шакли курра мебошад. Ҳангоми палмосидани бачадон флюктуатсия мушоҳида карда мешавад. Ҳолати тифл ноустувор буда, аксар вақт кӯндаланг, қач ва метавонад пешмоади косӣ гирад.

Ҳангоми палмосидан тифл бо осонӣ ҳолати худро тағйир медиҳад. Қисмҳои тифл бо мушкилӣ палмосида

мешаванд, қисми пешомад боло чой мегирад ва ҳаракатнок мебошад. Дилзании тифл паст шунида мешавад. Баъзан фаъолияти ҳаракатнокии тифл пурзӯр мешавад. Дар ташхиси бисёробӣ маълумотҳои муоинаи маҳбалӣ муҳиманд, яъне гарданаки бачадон кӯтоҳ мешавад, даҳанаи дохилии ӯ кушода шуда, бораки обӣ пуршиддат муайян карда мешавад. Аз усулҳои муоинаи иловагӣ афканишоти фавқулсадоӣ маълумотнок ва ҳатмӣ мебошад, ки имконият медиҳад фетометрия, вазни тахминии тифл, мӯҳлати ҳомиладорӣ, инчунин ҳаҷми обҳои наздитифлӣ, нуксонҳои инкишофи тифл, пласентография (мавқеъ, ғафсӣ, зинаи расиш) гузаронида шавад.

Ҳангоми ташхис гузаронидани бисёробӣ бояд барои ошкор сохтани сабаби ӯ муоинаҳо гузаронем, яъне манбаи уфунат, диабети қанд, номувофиқатии омили резусро ошкор созем.

Хусусияти хоси чараёни ҳомиладорӣ. Мавҷудияти бисёробӣ ба тифл ва модар хатар дорад. Аворизи бештар ин хатари пеш аз мӯҳлат қатъи ҳомиладорӣ мебошад. Ҳангоми бисёробии шадид қатъи ҳомиладорӣ дар ҳафтаи 28-ӯм вомерӯрад. Ҳангоми бисёробии музмин дар баъзе ҳомилагон ҳомиладорӣ то ба мӯҳлати пурра мерасад, вале таваллуд бармаҳал оғоз меёбад. Дар баъзеи онҳо аворизи дигар бармаҳал кафидани пардаи тифлӣ мебошад, зеро ин аз ҳисоби фишори баланди дохили бачадон ба вучуд меояд, ки дар натиҷа метавонад нофаки тифл, қисмҳои хурди тифл афтад ё машина аз девори бачадон бармаҳал чудо шавад.

Дар ҳомиладороне, ки бисёробӣ доранд синдроми фишори вариди холии поён мушоҳида мешавад. Занҳо дар ҳолати бо тахтапушт будан сарчархзанӣ, сустӣ, ғуввос дар гӯшҳо ҳис мекунанд. Ҳангоми ба паҳлӯ гаштан ин аломатҳо мегузаранд, зеро фишори вариди холии поён бартараф гашта, бозгашти хун ба дил зиёд мешавад. Дар мавриди фишор ба вариди холии поён бо хун таъминшавии бачадон ва чузъи фетопласентарӣ бад шуда, ба ҳолати

тифли дохилибатнӣ таъсири манфӣ мерасонад. Аксар вақт ҳангоми бисёробӣ ҳипотрофияи тифл мушоҳида мешавад.

Бурдани ҳомиладорӣ ва таваллуд. Занҳои ҳомилае, ки ба бисёробӣ дучор мешаванд, бояд бистарӣ шаванд ва таъхиси амикро гузашта, сабабҳои инкишофи бисёробӣ муайян карда шавад. Таъхисро собит намуда, бояд тактикаи ҳубтари бурдани ҳомиладориро муайян созанд. Агар дар ҷараёни муоина аномалияи инкишофи тифл, ки ба ҳаёт номувофиқ аст, ошкор шавад, он гоҳ бояд занро барои қатъи ҳомиладорӣ бо воситаи роҳҳои табиӣи валодат омода созем. Ҳангоми ошкор сохтани уфунат бояд табобати зиддибактериявӣ бо назардошти тифл гузаронанд.

Ҳангоми ошкор сохтани номувофиқати изосерологии тифлу модар бояд тактикаи дуруст интиҳоб намуд. Ҳангоми ошкор сохтани диабет қанд бояд табобати компенсаторӣ гузаронд. Дар солҳои охир майли таъсири тифл ба обҳои наздитифлӣ маълум шуда истодааст, ки бояд табобатро ба тифл нигаронд. Индометасин, ки 2 мг/кг дар як шабонарӯз истифода бурда мешавад, диурези тифлро кам намуда, бо ҳамин миқдори обҳои наздитифлӣ кам мешавад.

Дар баъзе ҳолатҳо амниосинтез карда, обҳои зиёдатири ихроҷ мекунанд, вале табобате, ки барои кам кардани обҳои наздитифлӣ гузаронида мешавад на ҳама вақт самара медиҳанд.

Дар ягҷоягӣ бо табобати патогенетикии бисёробӣ бояд табобати ҳипоксияи тифлро бо ҳипотрофияи он гузаронем, барои ин маводҳоро, ки ба хунгардиши бачадонӣи машинавӣ таъсир кунанд, бояд истифода бурд. Маводе, ки зидди ихтилоҷи маводҳое, ки хусусияти реологии хунро беҳтар мекунанд, ба монанди реополиглюкин, трентал, курантил истифода мебаранд, инчунин маводҳое, ки ба ҷараёни мубодила таъсир мекунанд - рибоксин, ситохром С, антиоксидантҳо (токоферол) низ натиҷаҳои ҳуб медиҳад. Ҳангоми бисёробӣ таваллуд бо аворизҳо мегузарад. Аксар вақт сустии қувваҳои валодатӣ мушоҳида мешавад. Бисёробӣ ба аз ҳад зиёд тарангшавӣи мушакҳои

бачадон оварда мерасонад, ки дар натиҷа фаъолияти кашиши мушакҳои ӯ суст мешавад.

Кӯмаки момой аз кафондани бораки оби тифл оғоз меёбад. Бораки оби тифлро бояд эҳтиёткорона кушод, зеро мумкин аст, ки нофаки тифл ва қисмҳои хурди ӯ афтанд, бармаҳал кӯчидани машина ба вучуд ояд. Баъди 2 соат агар қувваҳои валодатӣ хуб инкишоф наёбанд, он гоҳ зарур аст, ки таваллуд стимулятсия шавад. Барои пешгирии хунравӣ дар давраи ҳамроҳакӣ бояд дар охири ин давра метилэргометрин ва окситосин ворид шавад. Агар зан маводҳои кашишкунандаи бачадониро қабул карда бошад, он гоҳ бояд онро дар давраи ҳамроҳакӣ ва баъдитаваллудӣ идома дод.

Камобӣ. Агар обҳои наздитифлӣ ҳангоми ҳомиладории расида аз 600 мл кам бошад, он гоҳ ин камобӣ мебошад, ки баъзан вомехӯрад.

Сабабҳо. То ҳол сабаби камобӣ номаълум аст. Ҳангоми камобӣ боздошта шудани инкишофи тифл мушоҳида мешавад, чунки дар тифли хипотрофик вазоифи гурдаҳо вайрон шуда ва диурези соатии гурдаҳо кам мешавад.

Ҳангоми камобӣ ҳаракати тифл аз ҳисоби хурд будани фазо маҳдуд аст. Баъзан пӯсти тифл бо амнион часпида, бо мурури сабзиши тифл рахҳо ва барчастиаҳо ба вучуд меоранд. Девораҳои бачадон тифлро чафс ихота намуда, ўро қат мекунанд, ки ин ба қачшавии сутунмӯҳра ва нуқсонҳои чанбарҳои ӯ оварда мерасонад.

Зухуроти сарирӣ. Аломатҳои камобӣ одатан зухур намеёбанд. Баъзеи занҳо ҳаракатҳои дардноки тифлро эҳсос мекунанд.

Ташҳис. Ташҳиси камобӣ ба номувофикии мӯҳлати ҳомиладорӣ ва андозаҳои бачадон асос меёбад. Дар ин ҳолатҳо бояд муоинаи фавқулсадоӣ гузаронида, миқдори обҳои наздитифлро аниқ сохт, инчунин мӯҳлати ҳомиладорӣ, андозаҳои тифл, нуқсонҳои ҷойдоштаро муайян кард. Дар рафти ҳомиладорӣ аксар вақт гипоксия, гипотрофия, аномалияи инкишофи тифл мушоҳида меша-

вад. Таваллуд тӯл мекашад, зеро пардаҳои наздифлӣ ба қисми пешомад ҷафс шуда, ба кушодашавии даҳанаи дохилии гарданаки бачадон ва ҳаракати қисми пешомад мамоният мекунад, кӯмаки момой аз кушодани бораки обӣ оғоз меёбад. Баъди 2 соати кушода шудани бораки обӣ агар қувваҳои валодатӣ хуб инкишоф наёбанд, он гоҳ таваллудро танзим мегардонанд. Давраи ҳамроҳакӣ ва баъдитаваллудӣ бо хунталафдиҳии зиёд анҷом мепазирад, ки пешгирии он дар воридкунии метилэргометрин ва окситосин мебошад.

II. АМРОЗИ ДАВРАИ ВАЛОДАТ **АНОМАЛИЯИ ҚУВВАҲОИ ВАЛОДАТ**

Аномалияи фаъолияти кашишхӯрандагии бачадон гуфта, чунин фаъолияти кашишхӯрандагии бачадонро меноманд, ки дар он яке аз нишондодҳои ӯ (тонус, шиддат, давомнокӣ, интервал, ритмнокӣ, зуддӣ ва фаъолияти мунтазам) тағйир ёфтаанд.

Дар байни аворизҳои амали таваллуд 10-20%-ро аномалияҳои қувваҳои валодатӣ ташкил медиҳанд.

Тасниф. Ҳангоми таваллуд 4 намуди аномалияи қувваҳои валодатиро фарқ мекунанд:

- 1. Сустии якуминаи фаъолияти валодатӣ**
- 2. Сустии дуюминаи фаъолияти валодатӣ**
- 3. Фаъолияти валодатии пурзӯр бо таваллуди шадид ва тез**
- 4. Фаъолияти валодатии дискоординатсионӣ**

Сабаб ва патогенез. Хусусият ва рафти таваллуд аз рӯи маҷмӯи омилҳо муайян карда мешаванд ва чун омодагии организми ҳомиладор ба таваллуд баҳо дода мешавад. Тайёрии организм ба таваллуд дар муддати зиёд аз ҳисоби ҷараёнҳое, ки аз лаҳзаҳои бордоршавӣ то таваллуд ба вучуд меоянд, ташаккул меёбад. Моҳиятан ва мантиқан таваллуд ин анҷом ёфтани ҷараёнҳои бисёрзинагӣ дар организми модар ва тифл мебошад. Ҳангоми ҳомиладорӣ бо мурури созиш ва инкишофи тифл таносуби мураккаби ҳормоналӣ, ҳуморалӣ ва неврогенӣ ба вучуд меоянд, ки

дар оянда рафти амали таваллудро таъмин мекунанд. Доминанти таваллуд ин маҷмӯи ягонаи функционалие мебошад, ки аъзоҳои зеринро дар бар мегирад: қушҳои мағзи сарӣ, минтақаи хипофизарии хипоталамус, ҳиссаи пеши хипофиз, тухмдон, бачадон бо системаи машина-тифл. Агар вайроншавии вазифаи яке аз ин аъзоҳои ин система ба вучуд биёяд, пеш аз ҳама вайроншавии фаъолияти бачадон ва кашишхӯрандагии он ба вучуд меояд. Патогенези ин вайроншавиҳо бо омилҳои бисёр вобастагӣ доранд, вале нақши асосиро дар пайдоиши аномалияи фаъолияти валодатӣ қараёнҳои биохимиявӣ дар ҳуди бачадон мебозанд. Нақши бузургро дар саршавӣ ва рафти таваллуд тифл низ мебозад, зеро вазни тифл, анҷоми ирсии инкишоф, таносуби маснуъии тифлу модар ба рафти таваллуд таъсири ҳудро мерасонад. Импулсҳое, ки аз организми тифли болиғ меоянд, синтезҳои омилҳои иммуносупрессориро, аз он ҷумла пролактин ва гонадотропини хорионалиро афсурда мекунанд. Реаксияи организми модар ба тифл чун аллотрансплантант тағйир меёбад. Дар маҷмӯи фетопласентарӣ низ тағйиротҳо ба амал меоянд, яъне эстрогенҳо қамъ шуда, ҳиссиётнокии андроресепторҳоро ба окситасин ва простагландинҳо зиёд мегардонанд. Қамъи ин сигналҳо ин ё он хусусияти фаъолияти валодатиро таъмин мекунанд. Ҳангоми аномалияи фаъолияти валодатӣ қараёнҳои дезогранизатсияи қушҳои миоситҳо ба вучуд меоянд, ки ин ба вайроншавии фаъолияти ферментҳо ва тағйироти миқдори нуклеотидҳо оварда мерасонанд, ки ин аз пастшавии қараёнҳои оксидшавӣ, афсурдашавии нафаси бофтагӣ, сустшавии биосинтези сафедаҳо, инкишофи гипоксия ва асидози мубодилагӣ шаҳодат медиҳад.

Яке аз сабабҳои асосии сустии валодатӣ ин гипокалсиемия мебошад. Ионҳои калсий дар интиқоми сигнал аз пардаи плазматикӣ ба қушҳои кашишхӯрандагии ҳуҷайраҳои суфтамушак нақши бузургро мебозад. Дар патогенези инкишофи сустии қувваҳои валодатӣ сустшавии функсияи адренергӣ нақши муҳим мебозад, ки бо

эстрогенҳо зич алоқаманд мебошад. Омилҳои саририё, ки ба инкишофи аномалияи қувваҳои валодатӣ мусоидат мекунад ба 5 ғурӯҳ тақсим карда мешаванд:

1. Омилҳои момӣ - пеш аз мӯҳлат рехтани обҳои наздитифлӣ, диспропорсия байни андозҳои сараки тифл ва андозаҳои роҳҳои валодатӣ, тағйиротҳои ҷузъӣ ва дистрофикӣ дар бачадон, чандирии гарданаки бачадон, аз ҳад зиёд тарангшавии бачадон аз ҳисоби бисёрбӣ, аномалияи ҷойгиршавии машина, пешомади косӣ, сарторикии дёрина.

2. Омилҳои камбудии (патологияи) аъзои таносул вобастагӣ доранд - инфантилизм, нуқсонҳои инкишофи узвҳои ҷинсӣ, норасогиҳои нейроэндокринӣ, синни зан аз 30 боло ва аз 18 поён, вайроншавии сикли ҳайзӣ, қатъи сунъии ҳамл, амалиёти ҷарроҳӣ дар бачадон, миома, бемориҳои илтиҳобии узвҳои ҷинсии зан.

3. Бемориҳои умумии бадан, уфунат, захролудшавӣ, фарбеҳшавӣ, харобӣ, патологияи диэнсефалӣ, анемия.

4. Омилҳои камбудии аъзои репродуктивӣ - хипотрофияи тифл, уфунати дохилибатнии тифл, анэнсефалия ва дигар нуқсонҳои инкишофи тифл, тифли аз ҳад зиёд расида, ҳомиладории иммуноконфликтӣ, норасоии фетопласентарӣ.

5. Омилҳои ятрогенӣ (истифодаи беасос ва бемавқеи маводҳо ва усулҳои таваллудро стимулятсиякунанда, бедард карда натавонистани таваллуд, бемавқеи қушодани оби бораки тифл. Ҳар яке аз ин омилҳо метавонанд дар алоҳидагӣ ё ягҷоя таъсир расонанд.

Сустии якӯминаи фаъолияти валодатӣ

Ин намууди бештар вохӯрандаи аномалияи қувваҳои валодатӣ мебошад, ки бештар дар занҳои нахустзоӣ вомерӯяд.

Зухуроти сарирӣ. Ҳангоми сустии қувваҳои валодатӣ таваллуд аз 12 ва ҳатто 18 соат зиёд тӯл мекашад (таваллуди тӯлкашида). Давомнокии миёнаи таваллуди эътидол дар нахустзоӣ 11-12 соат ва дар такрорзоӣ бошад, 7-8 соат мебошад. Аломати сустии қувваҳои валодатӣ ин

дардҳои кӯтоҳмуддат, суст, камсамара аз худи оғози давраи I таваллуд мушоҳида карда мешавад. Бо мурури хуруҷгирии амали таваллуд қувва, зудӣ, муддати дардҳо тағйир намеёбанд, ё худ пурзӯршавии дардҳо ниҳоят суст ба вучуд меоянд. Ҳангоми кӯтоҳмуддат, кам ва суст будани дардҳо, суфташавӣ ва кушодашавии гарданаки бачадон ниҳоят суст ба вучуд меояд ва ҳаракати пешравандаи қисми пешомад дар роҳҳои валодатӣ мушоҳида намешавад. Баъди 12 соати фаъолияти валодатӣ хасташавии руҳӣ ва ҷисмонии зан мушоҳида мешавад, баъди 16 соат мадор хароб мегардад. Ҳангоми сустии якӯминаи қувваҳои валодатӣ пеш аз мӯҳлат ё бармаҳал рехтани обҳои наздитифлӣ мушоҳида карда мешавад, ки ин ба сироятёбии тифл ва роҳҳои валодатӣ, инчунин ба гипоксия ва ҳатто фавти тифл оварда мерасонад. Сустии якӯмина ҳангоми табобат накардан ё нодуруст табобат кардан дар тамоми давраи кушодашавӣ идома ёфта, ба сустии чордард мегузарад. Аксар вақт дар занҳои таваллуд кардае, ки сустии қувваҳои валодатӣ доштанд, дар давраи ҳамроҳакӣ ва давраи бармаҳали баъдитаваллудӣ аворизҳо вомерхӯранд. Дар давраи баъдитаваллудӣ инволютсияи сусти бачадон дида мешавад, инчунин эндометрит ва ҷараёнҳои уфунӣ сар мезананд.

Ташҳис. Сустии қувваи валодатиро баъди 2-3 соати назорат ба зани зоянда ташҳис гузаштан мумкин аст. Бо усулҳои анъанавӣ хусусияти рафти фаъолияти валодатиро ва инчунин мувофиқатии қувва, зудӣ, давомнокии амали таваллудро муайян месозанд. Бо воситаи усулҳои беруна ба кушодашавии гарданаки бачадон назорат мекунанд, инчунин ба усулҳои беруна усулҳои дохилиро илова мекунанд. Бо воситаи гистерография ташҳисгузори хеле осон мегардад. Ҳангоми сустии қувваҳои валодатӣ дардҳо шиддат ва зудии суст дошта, тонуси бачадон паст мегардад.

Сустии якӯминаи қувваҳои валодатиро бояд аз давраи прелиминарии патологӣ фарқ кард, яъне ҳангоми давраи прелиминарии патологӣ тағйиротҳои ҷузъии гардана-

ки бачадон мушоҳида карда намешавад, ки ин фарқияти асосии онҳо мебошад.

Муолиҷа. Ҳангоми сустии қувваҳои валодатӣ бояд ҳар чӣ зудтар табобатро оғоз намуд. Ҳангоми бисёробӣ ва камобӣ, агар гарданаки бачадон 3-4 см кушода шуда бошад, бораки обии тифлро мекушоянд, ин амал метавонад барои пурзӯршавии фаъолияти валодатӣ мусоидат кунад. Табобати ояндаро аз рӯи вазъи момоии мушахас муайян месозанд: яъне зан ҳаста ҳаст ё на, таваллуд дар қадом вақти шабонарӯзӣ ба вучуд омада истодааст. Агар зани зоянда ҳаста бошад ва шаб бошад, он гоҳ бояд ҳоби кӯтоҳмуддати истироҳатӣ (доругӣ) кунад. Одатан ҳоби истироҳатӣ 2-3 соат идома меёбад, баъди истироҳат фаъолияти хуби валодатӣ барқарор мешавад. Агар он барқарор нашавад, он гоҳ маводҳои таваллудтанзимкунанда истифода мебаранд.

Агар зан ҳаста набошаду, шабона хуб ҳоб карда бошад, он гоҳ ба муолиҷаи таваллудтанзимкунанда дарҳол шурӯъ мекунанд. Дар момоии муосир маводҳои таваллудро танзимкунандае, ки ба тариқи таъриқ ворид карда мешаванд, васеъ истифода мебаранд, аз он ҷумла окситосин ва простагландин. Окситосин ҳормони ҳиссаи ақибӣ хипофиз мебошад. Хусусияти асосии фармокологии ӯ ин ба вучуд овардани кашишхӯриҳои пурзӯри мушакҳои бачадон мебошад. Барои ба варид дохил намудани окситасин 5 ЕД (1мл) ўро дар 500 мл маҳлули изотоникии натрий хлорид омехта мекунанд. Чакондани онро аз 6-9 қатра дар як дақиқа оғоз мекунанд, сипас баъди ҳар як 10 дақиқа шумораи қатраҳоро ба 5 қатра зиёд мекунанд, вале аз 40 қатра дар як дақиқа зиёд набояд бошад. Агар ин табобат самара надиҳад, он гоҳ ворид кардани ин мавод маъно надорад.

Простагландинҳо моддаҳои фаъоли биологие ҳастанд, ки ҳормони «ҷузъӣ» буда, ба фаъолияти инқибозии мушакҳои суфта таъсир мекунанд. Дар момой простагландинҳои F_{2d} ва E₂-ро васеъ истифода мебаранд. Афзалияти простагландинҳо дар он аст, ки онҳо новобаста

аз дараҷаи кушодашавии гарданаки бачадон ба пурзӯркунии қобилияти фаъолияти инкибозии бачадон доро аст. Простагландини F_{2d} -ро ба дохили варид ба тариқи қатравӣ ворид мекунанд, 5 мг-ро дар 500 мл маҳлули изотоникии хлориди натрий омехта мекунанд. Воридкуниро аз 6-8 қатра дар як дақиқа оғоз карда то 30 қатра дар як дақиқа мерасонанд. Баъди ҳар 3-4 соат пешгирии гипоксияи тифлро мегузаронанд, маводҳои зиддиҳистолоҷӣ ва бедардкунанда (промедол) таъин мекунанд, хангоми фосилаи тӯлонии беобӣ (зиёда аз 18 соат) антибиотикҳо таъин мекунанд. Истифодаи маводҳои кашишхӯрандаро дар зарфи тамоми амали таваллуд ва 30-40 дақиқаи баъдитаваллуд идома медиҳанд. Агар муолиҷаи сустии қувваҳои валодатӣ бесамара бошад, он гоҳ амалиёти чарроҳӣ мегузаронанд. Дар баъзе занҳо амалиёти чарроҳиро дарҳол баъди ташхис гузоштан мегузаронанд, ба инҳо занҳои коси тангдошта, тифли бузургҷусса, таъсироти хадшагии гарданаки бачадон дошта, инчунин занҳое, ки ҳолати ва пешомади нодуруст, ҳипоксияи тифлдоранд, мансубанд.

Сустии дуюминаи қувваҳои валодатӣ

Ин авориз нисбат ба сустии якӯмина камтар вомехӯрад. Ҷ 2% таваллудро авориз медиҳад. Хангоми сустии дуюминаи қувваҳои валодатӣ сустшавии дуюминаи дардҳо вомехӯрад, ки ин дар охири давраи якӯм ва ибтидои давраи дуом ба вучуд меояд. То ин вақт дардҳо сурати хубу қаноатбахш доштанд.

Сабаб. Сабабҳои сустии дуюминаи қувваҳои валодати бо сабабҳои сустии якӯмин табиати умумӣ доранд, вале таъсири манфӣ ва оқибати нохуши онҳо дертар зоҳир мегарданд. Ба ғайр аз ин сустии дуюмина мумкин аст, дар натиҷаи вучуд доштани монеъа ба ҳаракати тифл ба вучуд биёяд, яъне хангоми мувофиқ наомадани андозаҳои тифл ва коси хурди зан, ҳолати нодурусти тифл, тағйироти хадшагии гарданаки бачадон, омосҳо дар коси хурд. Пешомади коси тифл, дер кушода шудани бораки обии тифл, эн-

дометрит аксар вақт ба сустии дуюмина оварда мерасонанд. Сустии дуюминаи кувваҳои валодатӣ мумкин аст пайдоиши ятрогенӣ дошта бошад: бетартибона таъин намудани маводҳои инқибозӣ, бедардкунанда ва зиддиихтилоҷӣ. Сустии чордардро баъзе пизишкони момой ба гурӯҳи алоҳида чудо мекунанд, ки сабаби ӯ зеринҳоянд: норасогии мушакҳои пеши шикам дар занҳои бисёр таваллудкарда, чурраи хати сафед, ноф, қадкашак, бемориҳои системаи асаб (полиемиелит, миастения, осеби сутунмӯҳра), фарбегӣ. Баъзан сустии чордард аз хусусияти қисми пешомад вобастагӣ дорад: пешомади косӣ ба нӯгҳои асабии коси хурд фишорӣ заруриро ба вучуд намеорад, бинобар ин чордард суст аст. Сустии чордард ҳангоми ҳасташавии зан ва харобшавии манбаи нерӯи мушакҳои бачадон ба вучуд меояд.

Зухуроти сарирӣ. Ҳангоми сустшавӣ дардҳо суст, кам, кӯтоҳмуддат шуда, фосилаи байни онҳо зиёд мегардад. Муддати кушодашавии гарданаки бачадон зиёд шуда, ҳаракати қисми пешомад суст ё тамоман қатъ мегардад. Муддати зиёд истодани сараки тифл дар як ҳамвории коси хурд ба бофтаҳои нарм фишори зиёд оварда мерасонад, ки ин боиси пайдоиши носурҳо мегардад. Зан ниҳоят хаста мешавад. Ҳамчунон аломатҳои хорионамнионит ё гипоксияи тифл зухур меёбад.

Ташҳис. Сустии дуюминаи кувваҳои валодатӣ дар асоси хусусиятҳои дардҳо, кушодашавии гарданаки бачадон ва ҳаракати қисми пешомад гузошта мешавад. Назорати доимӣ ба ин нишондодҳо бо воситаи муоинаи дохилӣ ва берунии момой имконият медиҳад, ки сари вақт ташҳиси дуруст гузорем. Вале гистерография ва назорати кардиомониторӣ имконият медиҳад, ки маълумотҳои бештар васеъ дар бораи хусусияти дардҳо ва ҳолати тифл ба даст орем. Ниҳоят зарур аст, ки байни сустии кувваҳои валодатӣ ва номувофиқатии сараки тифл ба коси хурд ташҳиси тафриқавӣ гузаронида шавад.

Бурдани таваллуд. Бурдани таваллуд аз дараҷаи кушодашавии гарданаки бачадон, ҳолати сарак

дар коси хурд, ҳолати тифл ва амрози ҳамрадифи момой вобастагӣ дорад. Агар бораки оби тифл бутун бошад, он гоҳ ўро мекушоянд, чунки ин ба пурзўршавии қувваҳои валодатӣ оварда мерасонад. Агар зан хаста шуда бошад, давраи I-ўми таваллуд бошад, инчунин сараки тифл ба дармади кос ҷафс ё бо сегменти хурд бошад, ҳолати тифл хуб бошад, он гоҳ ба зани таваллудкунанда ҳоби истироҳатӣ (доругӣ) медиҳанд. Баъди бедор шудан таваллудро бо маводҳои инқибозӣ танзим мекунанд. Агар сусии дуюмина ҳангоми дар қисми васеъ ё танги коси хурд будани сараки тифл ба вучуд биёяд, он гоҳ танзими таваллудро дарҳол мегузаронанд. Сарак чӣ қадар боло бошад, ҳамоно қадар фаъолияти танзими зиёд мекунад. Агар сарак дар қисми танг ё бармади коси хурд воқеъ бошад, он гоҳ ба зери пўст окситосин ворид кардан мумкин аст. Агар муолиҷаи доругӣ беамара ё камсамара бошад, он гоҳ вобаста аз ҳолати момой пизишк тактикаи ҳудро муайян мекунад, яъне агар имконият бошад, буриши қайсарӣ, ҷангакҳои момой ва вакуум-экстраксия мегузаронанд. Агар бемориҳои ҳамрадифи экстрагениталӣ ҷой дошта бошад, баъди ташхис гузоштани сусии дуюмина зуд ба амалиёти ҷарроҳии буриши қайсарӣ шурӯъ мекунанд.

Қувваҳои валодатии пурзўр

Чунин намуни вайроншавии қувваҳои валодат нисбатан кам воқеъафтад, ҳангоми ингуна таваллуд дардҳои пурқувват ва бетанаффус мушоҳида карда мешаванд, ки ба таваллуди тез ё пуршиддат оварда мерасонад. Дардҳои пуршиддат дар занҳои нахустзоӣ дар зарфи 4 соат, дар занҳои такрорзоянда дар зарфи 2 соат ба вучуд меояд. Таваллуди тез гуфта чунин таваллудро меноманд, ки давомнокии ӯ дар нахустзоӣҳо 6-4 соат, дар такрорзояҳо 4-2 соат бошад. Фаъолияти валодатии пуршиддат аксар вақт дар зинаи ниҳонии амали таваллуд зоҳир мегардад. Ҳангоми ӯ дардҳо пурқувват ва зуд-зуд мебошанд, ва кушодашавии пурхурӯҷи гарданаки бачадон ба вучуд меояд, инчунин ҳаракати тифл низ аз роҳҳои валодатӣ босуръат мебошад.

Сабаб.

Сабабҳои инкишофи фаъолияти пурзӯри валодатӣ то ҳол хуб омӯхта нашудаанд. Занҳое, ки бемориҳои бада-нию момой доранд (гестозҳо, бемориҳои системаи дилу рағӣ), бештар таваллуди онҳо пурзӯр мебошад. Дар баъзе ҳолатҳо фаъолияти пурзӯри валодатӣ дар натиҷаи ноду-руст таъин намудани маводҳои таваллудтанзимкунанда ба вучуд меояд.

Зухуроти сарирӣ. Ҳангоми қувваҳои валодатии пурзӯр таваллуд шадид оғоз меёбад. Дардҳои пурқувват бо танафуси кӯтоҳмуддат якдигарро иваз мекунанд ва ба зуд кушодашавии гарданаки бачадон оварда мерасонанд. Баъди рафтани обҳои наздитифлӣ дар 1, 2, 3 чордард тифл таваллуд мешавад. Ҳангоми таваллудҳои тез ва пуршиддат зан ноором буда, ҳаракати фаъоли нооромона мекунад, набз ва нафаскашии онҳо зиёд шуда, фишори шараёни ба-ланд мегардад.

Ҳангоми инкишофи шадиди фаъолияти валодатӣ аксар вақт аз ҳисоби вайроншавии хунгардиши бачадонию машимавӣ тифл гирифтори хипоксия мешавад. Дар натиҷаи ниҳоят тез ҳаракат кардани тифл аз роҳҳои валодатӣ осебҳои гуногуни тифл аз роҳҳои валодатӣ, ба монанди кефалогематома, хунрезӣ ба мағзи сар ва ҳароммағз, шикасти қулфак мушоҳида карда мешавад. Хараёни пуршиддати таваллуд сабаби осебҳои чиддии бофтаҳои нарми роҳҳои валодатии модар мегардад, яъне даридани маҳбал, чатан, гарданаки бачадон дида мешавад. Бошиддат ҳаракат кардани тифл аз роҳҳои валодатӣ, хусу-сан ҳангоми кӯтоҳ будани банди нофи тифл, ба бармаҳал ҷудошавии машима оварда мерасонад, ки дар натиҷа тифл ва модарро ба оқибатҳои бад меоварад. Дар натиҷаи тез холишавии бачадон мумкин аст, ки вай дар давраи ҳамроҳакӣ ва давраи бармаҳали баъдитаваллудӣ ба ҳолати гипотоникӣ гирифтор шавад, ки ин ба хунталафдиҳӣ му-соидат мекунад.

Таъхир. Таъхиси ин авориз мушкิลӣ надорад, зеро дар асоси хусусиятҳои дард, суръати кушодашавии гарда-

наки бачадон ва ҳаракати тифл аз роҳҳои валодатӣ метавон таҳқиқ гузошт.

Муолиҷа. Чораҷӯҳои муолиҷавӣ бояд ба сусти кардани фаъолияти баланди бачадон нигарон бошад. Ҳангоми қувваҳои валодатии пурзӯр β – адреномиметик-хоро (бриканил, партусистен, алулент) ё антогинистҳои калсийро (верапапил, изоптин) истифода мебаранд, баъди 10-дақиқаи ворид кардани ин маводҳо самара ба даст овардан мумкин аст. Ҳангоми истифодаи наркози фторотанӣ дардҳо ниҳоят нис сусти мешаванд. Фаъолияти инкибозии бачадонро бо воситаи сульфати магний (маҳлули 25%-10мл ба дохили мушак) сусти кардан мумкин аст.

Фаъолияти валодатии дискоординатсионӣ

Ин авориз ниҳоят кам вомехӯрад (фақат дар 1% та-валлуд). Шаклҳои фаъолияти валодатии дискоординатсионӣ хеле гуногунанд: ихтилоҷи мушакҳои ҳамаи қисмҳои бачадон (тетанияи бачадон), паҳншавии мавҷи кашиишхӯрии бачадон аз сегменти поён ба боло, сусти нашудани гарданаки бачадон ҳангоми кашашхӯрии танай бачадон (дистосияи гарданаки бачадон).

Сабабҳо. Сабабҳои пайдоиши қувваҳои валодатии дискоординатсионӣ хуб омӯхта нашудаанд. Нуқсонҳои инкишофи бачадон, тағйироти ҳадшагии бачадон, тағйиротҳои дегенеративии бачадон, ки дар натиҷаи просессҳои илтиҳобӣ ба вучуд омадаанд ё миомай бачадон боиси қувваҳои валодатии дискоординатсионӣ шуда метавонанд.

Зухуроти сарирӣ. Ҳангоми фаъолияти валодатии дискоординатсионӣ зан ноором шуда, ба кашиишхӯриҳои дарднок шикоят мекунад. Эҳсосоти дарднок бештар чорбандро фаро мегирад. Яке аз аломатҳои қувваҳои валодати дискоординатсионӣ ин қушода нашудани гарданаки бачадон мебошад: новобаста аз дардҳои фаъол ва тонуси баланди бачадон қушодашавии гарданаки бачадон мушоҳида намешавад. Ин ҳолат ҳангоми тетанияи бачадон бештар ифода меёбад. Ҳолатҳои лабҳои гарданаки бача-

дон хусусиятҳои зеринро доро аст: лабҳои гарданаки бачадон гафсу камҳаракат ё борик ба мисли тасма мебошад. Агар сари вақт муолича карда нашавад, он гоҳ канораи гарданаки бачадон варам мекунад. Ҳангоми фаъолияти валодатии дискоординатсионӣ хунгардиши бачадонию машимавӣ вайрон мешавад, ки ин боиси гипоксияи тифл мегардад. Ҳангоми давраи ҳамроҳакӣ ва давраи бармаҳали баъдитаваллудӣ хунравии зиёд мушоҳида мешавад.

Ташҳис. Ташҳиси қувваҳои валодатии дискоординатсионӣ дар асоси хусусиятҳои фаъолияти валодатӣ ва ҳолати гарданаки бачадон гузошта мешавад. Бо воситаи гистерография кашишхурии номунтазам ва аритмиро муайян мекунанд, инчунин, қоидаи сегонаи градиенти поёнраванда вайрон мешавад ва дар қаъри бачадон доминанта вучуд надорад. Дискоординатсияи фаъолияти валодатӣ одатан дар давраи I-ӯми валодат мушоҳида карда мешавад.

Муолича. Ҳангоми дискоординатсияи қувваҳои валодатӣ муолича барои ба тартиб даровардани фаъолияти инкибозии бачадон равона карда шудааст. Ҳангоми ихтилочи пурраи мушакҳои бачадон муоличаро бо наркози фторотанӣ дар якҷоягӣ бо транквилизаторҳо ва маводҳои зиддиихтилоҷӣ оғоз мекунанд. Ҳангоми ин гуна муолича дар ҳол ё баъди бедор шудан қувваҳои валодатӣ мӯътадил мегарданд.

Муолича ҳангоми гипертонуси сегменти поёнии бачадон ва дистосияи гарданаки бачадон умумӣ мебошад. Агар ҳолати тифл қаноатбахш бошад, он гоҳ ба зани зоянда β-адреномиметикҳо, маводҳои зиддиихтилоҷӣ ва транквилизаторҳо медиҳанд. Агар муолича бесамара бошад, он гоҳ наркози момой медиҳанд. Аксар вақт дискоординатсияи қувваҳои валодатӣ амалиёти ҷарроҳиро талаб мекунад. Нишондод барои буриши қайсарӣ ин ҳипоксияи тифл мебошад.

Пешгирӣ. Нақши асосиро дар пешгирии аномалияи қувваҳои валодатӣ Марказҳои Солими Репродуктивӣ мекӯшанд. Бояд занҳои гурӯҳи хавфнокро ошкор сохта,

онҳоро ба таваллуд бояд тайёр намуд. Чораи муҳими пешгиркунанда ин тайёрии психопрофилактики зани ҳомила ба таваллуд мебошад, инчунин тарсро пеш аз таваллуд бояд бартараф намуд, эмосияи мусбатро дар зан бояд пойдор кард. Аз ҳафтаи 38-ӯм зани ҳомиларо дар шӯъбаи то таваллудӣ бистарӣ намуда, маҷмӯи тайёриро барои таваллуд мегузаронанд.

КОСИ ТАНГ

Кос ҳамон вақт танг номида мешавад, агар ҳама ва ё аққалан як андозаш назар бо эътидолӣ 1,5-2 см кӯтоҳ бошад.

Нишондиҳандаи асосии тангии кос ин андози конъюгатаи мустақим аст, ки он ба 11 см баробар аст. Ду хел коси тангро фарқ мекунанд:

1. Коси танги анатомӣ

2. Коси танги функционалӣ

Чӣ тавре, ки дар боло зикр шуд, коси танги анатомӣ, косест, ки дар он ҳама ва ё як андоза кӯтоҳ аст. Бояд ҳаминро гуфт, ки коси танг на ҳама вақт барои эътидол гузаштани валодат муқобилият нишон медиҳад. Дар мавриди ба андозаи кам танг будани кос, пурқувват будани қувваи валодат, на чандон калон будани тифл ва хуб гузаштани сарак, валодат метавонад боэътидол гузарад ва барои модару тифл бомувафақият бошад, яъне коси танги анатомӣ на ҳама вақт метавонад коси танги функционалӣ шавад. Баръакс, дар мавриди калон будани тифл ва бад будани қувваи валодат коси эътидол тангӣ мекунад. Ташхиси коси танги функционалӣ баъди санчиши ҳаматарафаи кос, андозаҳои тифл ва қувваҳои валодат муайян карда мешавад.

Ҳамин тавр косе, ки ҳангоми валодат тифл барои гузаштан аз он муқобилият ва мушкилӣ мекашад, коси танги функционалӣ ном дорад. Дараҷаҳои зиёди тангии кос ҳама вақт характери функционалӣ доранд ва валодат номумкин аст.

Сабабҳои тангии кос мураккабанд, лекин яке аз аломатҳои асосии он инфантилизм мебошад (таъхири сабзиш, тифлият, пушти понифол)? Яъне ҳамаи он сабабҳои, ки ба таъхири сабзиш меорад, ба вучуд омадани коси танг сабабгор мешавад. Инҳо шароити вазнини зиндагӣ, касалиҳои давомноки зан, хусусан дар айёми бачагӣ ва ба балоғатрасӣ, вайроншавии мубодилаи моддаҳо, норасоӣ дар таом, касалиҳои рахит дар бачагӣ, касалии сили устухон ва бандҳо, маҷрӯҳиёти косу пойҳо ва ғайра. Фоизи коси танг то ба 20 мерасад.

КЛАССИФИКАТСИЯ (ТАСНИФ)

Вобаста ба шакл ва дараҷаи тангӣ косро ба гурӯҳҳо тақсим мекунам:

I. Вобаста ба анҷом гурӯҳи зуд-зуд дучор омадани коси танг чунинанд:

1. **Коси баробартанг**
2. **Коси кӯндалангтанг**
3. **Коси пачақ, паҳн**
4. **Коси баробар ва паҳнтангшуда**

II. **Коси танги гоҳ-гоҳ дучороянда:**

Коси қаттангшуда

Коси ассимилятсионӣ

Коси воронкашакл

Коси кифозӣ

Коси спондилолитикӣ

Коси остемолятивӣ

Коси бо экзостоз ва дигар сабабҳо тангшуда.

Коси баробартангшуда 40-45 фоизи косҳои тангро ташкил мекунад. Ҳамаи ансорҳо баробар танганд ва чунин андозҳо доранд: 26 - 29 – 18 – 11 – 9. Коси танги баробартангшуда чунин намудҳо дорад; инфантилӣ, карликӣ (пажногӣ), мардона. Коси инфантилӣ дар занҳое, ки сабзиашон вайрон, узвҳои таносулашон норасида, вайроншавии ҳайз мушоҳида карда мешавад. Намуди чунин занон бачагона аст.

Коси танги мардона дар занҳое, ки қадбаланд, устухонҳояшон калон, мардмонанд ва ғайра.

Коси карликӣ ё пажноғӣ дар занҳое, ки қадашон 120-145 см аст, вомахӯрад ва ҳама андозҳои косаш ниҳоят хурданд.

Коси кӯндалангтанг – андозҳои кӯндаланги кос танганд, лекин андози мустақим эътидол ё калон аст.

Андозҳои таҳмини он: 27-26-28-21 см.

Коси паҳн ду намуд мешавад: коси паҳни оддӣ, ки дар он ҳамаи андозҳои рости кос танг ҳастанд ва паҳни рахитӣ, ки фақат андози рости даромад, яъне конюгатаи мустақим танг аст. Коси паҳни оддӣ бо номи кафшкунандааш - коси Девентер ном дорад. Дар он ҳамаи андозҳои рост аз даромад то баромади кос танг ҳастанд, яъне чорбанд ба симфиз наздик меистад. Андозҳои кӯндаланг эътидоланд. Деформатсияи устухонҳои кос ҷой надоранд. Андозҳои таҳминӣ: 25-28-31-18-11-9. Коси паҳни рахитӣ як қатор деформатсияҳо дорад. Боли устухони тихигоҳ кушод, масофаи байни пешҳои пехмуболом зиёд шуда, он ба масофаи байни қирраҳои он наздик ва ё як хел мешаванд. Чорбанд кӯтоҳу ҳамвор ва қисми поёниаш ба ақиб рафта белчаи болоиаш ба симфиз наздик мешавад. Димоға (мыс) ба шаклӣ нӯл ба ковокии кос медарояд, барои ҳамин ҳам хати рости даромад кӯтоҳ мешавад. Хати рости баромад бошад, калон шуда, кунҷи ковуқӣ кунд мешавад.

Заноне, ки рахитро дар бачагӣ гузаронидаанд, дигар деформатсияҳо ҳам доранд. Одатан намуди ромби Михаэлис ҳам дигар мешавад. Хати рости он ба 2-3 см кӯтоҳ шуда, кунҷи болоии ромб кунд мешавад. Андозҳои таҳминӣ ин намуди кос чунинанд: 26-26-30-18-11-9 см.

Коси паҳн ва баробартангшуда. Дар чунин намуд ҳама андозҳои танг лекин хусусан андозаи рости он тангтар аст. Он ҳам дар мавриди аз сар гузаронидани рахит дучор меояд. Андозаҳои таҳминӣ он: 23-24-, 24-25-, 27-28-, 15-16-, 9-7 см. Хушбахтона чунин намуди кос хело кам вомахӯрад.

Ассимилятсионӣ – косест, ки дар он мӯҳраи V миён ба мӯҳраи I-ӯми чорбанд мустаҳкам пайваст шуда, косро девор мекунонад ва ба гузаштани сараки тифл монегӣ мекунад.

Коси воронкавӣ, дар натиҷаи касалиҳои сил, рахит, спондилит ва дигарҳо пайдо шуда, онро дар занони қад баланд دیدан мумкин аст.

Остеомалативӣ – косе ки дар натиҷаи мулоим шудани устухонҳо шакли худро дигар мекунонад.

Классификасияи коси тангро вобаста ба андозаи ко-нюгатаи мустақим муайян мекунад:

I дараҷа – Cd мустақим 11-9 см, валодат дар бисёр вақтҳо мустақилона мегузарад;

II дараҷа - Cd мустақим 9-7,5 см, валодат бештар бо амали ҷарроҳӣ хотима меёбад;

III дараҷа - Cd мустақим 7,5-6,5 см, валодати мустақилона дар мавриди тифли расида номумкин аст;

IV дараҷа - Cd мустақим 6,5 см ва аз он поён, ин коси танги мутлақ буда, танҳо як роҳи валодат дорад - буриши кайсарӣ.

Ҳангоми дар зан муайян кардани дараҷаи танги 3-4 кос, агар майли кӯдак доштан надошта бошад, ҳомилагӣ дар моҳҳои аввал қатъи кунонида мешавад, агар майл дошта бошад танҳо бо роҳи ҷарроҳӣ таваллуд мекунад.

Муайян кардани коси танг. Аз сабаби он, ки валодат дар мавриди коси танг дар аксарият вақт барои ҳам модару ҳам тифл ғайриқаноатбахш анҷом меёбад, онро бармаҳал дарк намуда, тарзи валодатро муайян кардан зарур аст. Дар маслиҳатҳои занона ба заноне, ки устухони косашон ниҳоят танг аст, қатъи кардани ҳомилагиро пешкаш мекунанд. Ҳамаи занҳои ҳомилаи косашон тангро 2-3 ҳафта пеш аз валодат дар таваллудхона ҷой дода, тарзи валодатро интихоб мекунанд. Андозаҳои косро дар асоси азназаргузаронии умумии гениталӣ, ансорҳои кос, санҷиши маҳбалӣ ва инчунин бо тарзҳои рентгению ултрасодой муайян мекунанд.

Ҳангоми чамъ кардани анамнез ба касалиҳои сил, рахит, шакастану иллат ёфтани устухону бандҳо эътибор медиҳанд. Агар зан пеш аз ин ҳомилагӣ дошта бошад, ҷӣ хел гузаштани ҳомилагию валодати пешинаро муайян мекунанд, вазни кӯдакҳоро мепурсанд.

Ҳангоми азназаргузаронӣ ба нишонаҳои коси танг диққат медиҳанд: қад аз 145 см ва поён, нишонаҳои инфантилизм, пашмҳои баризофа, аломатҳои рахит, пойи кӯтоҳ ва дигарҳо, дар бораи коси танг буданаш маълумот медиҳанд. Албатта ромби чорбандро аз назар мегузаронанд, ки дар мавриди коси танг он шаклашро иваз мекунад. Агар коси паҳн бошад, кунҷи болоиаш кунд, коси баробартангшуда - диаметри рӯсташ аз кундаланг дида дарозтар ва ғайра.

Ба ғафсии устухонҳо эътибор додан зарур аст. Барои ин гирди банди дастро чен мекунанд (индекси Соловьёв). Ҳар қадар ин устухон ғафс бошад, кос танг мешавад ва ё баръакс.

Шакли шикам ҳам тағйир меёбад, он дар зери бори нахуст ҳомила нӯгдор буда, дар занҳои тақроран ҳомила овезон мебошад, чунки сарак дар даромади кос ҷойгир шуда наметавонад.

Хусусан барои муайян кардани коси танг андозҳои коси калонро бодиққат чен кардан лозим аст. Барои он, ки конюгатаи мустақимро муайян намоянд, санҷиши маҳбали гузаронида, конюгатаи диагоналіро (Cd) чен мекунанд ва ба дигар аломатҳои коси танг эътибор медиҳанд, андозҳои баромади косро низ чен мекунанд.

Равиши ҳомиладорӣ дар мавриди коси танг. Равиши давраи I ва II ҳомилагӣ хусусияти хос надорад. Аз барои он, ки сараки тифл дар даромади кос ҷойгир шуда наметавонад, қабри бачадон то диафрагма расида ба нафаскашӣ монев мешавад, барои ҳамин ҳам нафасгирӣ, дилзанӣ ва зуд мондашви занҳои ҳомила дида мешавад. Баъзан ба ҷои сарак коси тифл пеш меояд, ё тифл дар батн кундаланг меҳобад ё дигар пешомадҳои ногувор ба амал меоянд.

Аз сабаби он, ки камари расиш ба вучуд намеояд, оби гирдитифлӣ пеш аз мӯҳлат мерезад.

Ҳамаи занони ҳомилаи устухонҳояшон танг ба қайди консултасияи занона гирифта шуда, назорат карда, 2-3 ҳафта пеш аз валодат ба таваллудхона равона карда мешаванд.

РАВИШИ ВАЛОДАТ

Дар мавриди III ва IV дараҷаи тангии кос валодати тифли расидаи зинда номумкин аст. Агар дар вақташ амалиёти чарроҳӣ гузаронида нашавад, ҳам тифл ва ҳам зан нобуд мешаванд, ки сабаби он кафидани бачадон, инфекцияи септикӣ ва дигарҳо мебошад. Дар мавриди I-II дараҷаи тангии кос оқибати валодат аз ҳаҷми сарак, таври даромад ва гузаштани он аз ковокии кос, конфигуратсияи он ва инчунин аз иқтидори қувваи валодат вобаста аст.

Дар мавриди дараҷаи I-ӯми тангии кос одатан валодат эътидол мегузарад, лекин дар мавриди дараҷаи II-юми тангии кос ҳолатҳои ногувор бисёр дучор меоянд.

{ангоми коси танг яке аз ҳолатҳои ногувор барвақт рехтани оби наздитифлӣ мушоҳида карда мешавад, чунки камари расиш ба вучуд намеояд. Лаҳзаи рехтани об, метавонад бо ҳамроҳии худ банди ноф ва ё дастҳои тифлро барад. Агар ин воқеа рӯй диҳад, тифл ҳатман бо сараш банди нофро фишурда нобуд мегардад ва ё дастҳои афтода коси бе он ҳам тангро боз тангтар карда, ба гузаштани тифл ҳалал мерасонад.

Инчунин бармаҳал рафтани об фаъолияти кашишкунӣ ва кушодашавии гарданакро суст мекунад. Кашишкунӣ ба дарди саҳт мегузарад ва давраи I-ӯми валодат давомнок мегузарад. Дар давраи давомноки беоби микробҳо аз маҳбал ба даруни бачадон гузашта илтиҳоби эндометрий, пласентит ва ҳатто тифлро ҳам сироят мекунанд. Ҳарорати зоянда баланд, набзаш тез ва аз маҳбал риму фасод меояд. Тифл бо гипоксияи дохилибатнӣ ва дигар ҳолатҳои ногувор дучор мегардад. Дар мавриди тангии кос вайроншавии амалиёти қувваҳои валодат мушоҳида карда мешавад, сустии қувваҳои валодат аз ав-

вали он рӯй медиҳад (сустии ибтидоии қувваҳои валодат). Баъзан дар аввали валодат, қувваҳои валодат пуриктидор буда, баъд суст мешаванд (сустии сониявии қувваҳои валодат ба вучуд меояд). Валодат тӯл мекашад, зоянда мондаю шалпар мешавад, функсияҳои системаҳои асаб, дилу раг, мубодилаи моддаҳо вайрон мешаванд, аломатҳои гипоксияи тифл пайдо мешаванд.

Дар давраи рониш мушкилотҳои калон ба амал меоянд. Сарак бардавом дар даромади кос меистад. Сарак ковокии коси тангро бо мушкилӣ бо ёрии дардҳои пуриктидор мегузарад. Ин давра ҳам давомнок аст, барои он ки аз ҳалқаи танги кос гузаштан қувваҳои пуриктидор зарур аст. Агар ҳаҷми сарак ва андозаҳои кос номувофиқ бошанд, бачадон мекафад. Баъзан баъди қувваҳои пуриктидори валодат, он суст мешавад ва ё қатъ мегардад. Тифл аз асфиксия фавт мешавад, эндометрити валодат рӯй медиҳад ва ғайра.

Дар давраи рониш инчунин дар натиҷаи давомнок фишурда шудани бофтаҳои муллоими кос байни устухони сарак ва кос дар онҳо некроз ба амал меояд, байни маҳбалу рӯдаи рост ва ё пешобдону бачадон шикоф ба вучуд меояд.

Пайдо шудани хун дар пешоб, тунук ва дарднок шудани сегменти поён ин аломатҳои ҳавфи кафидани бачадон мебошад. Дар натиҷаи давомнок фишурда шудани асабҳо, парези мушакҳои пой рӯй медиҳад, симфиз кашида ва ё мешиканад. Тифл ҳам ниҳоят азоб мекашад. Дар натиҷаи валодати давомнок гардиши хуни байни бачадону машина вайрон шуда, асфиксияи тифл рӯй медиҳад, дар майнаи тифл хунрезӣ ба амал меояд. Дар зери таъсири фишори саҳт гематома пайдо мешавад. Дар сараки тифл омози калони валодатӣ пайдо мешавад, хангоми баровардани тана кулфаки китф баъзан мешиканад.

Ҳолатҳои номбаршуда сабаб мешаванд, ки басомади мурдатаваллудкунӣ, нобудшавии кӯдак дар ҳафтаи аввали ҳаёт, касалиҳои баъдивалодатӣ дар мавриди коси танг ниҳоят зиёд аст.

Механизми валодат дар мавриди коси баробар тангшуда. Сарак аз ҳама тараф якхела муқобилият мекашад. Он ниҳоят сахт ба рӯи сина ҳам шуда вазъи мувофиқ меҳабд, то аз коси танг гузарад. Хусусияти якҷуми механизми валодат дар мавриди баробар танг шудани кос сахт ҳам шудани сарак ба рӯи сина, нармаки майда ба маркази геометрии кос наздик мешавад. Он хусусан дар байни ҳамвории васеъ ва танги кос ба амал меояд ва барои гузаштани сарак бо андози аз ҳама хурд ниҳоят зарур аст.

Хусусияти дуҷуми дарзи сахмӣ ба кос дар яке аз хатҳои қачи он медарояд. Аз ин ҷо андози кӯндаланги калон низ бо хати қач аз кос мегузарад. Бо ҳамин ҳаракатҳо сараки сахт ҳамшуда аз ҳалқаи танги кос гузашта, давоми ҳаракатҳояш ба механизми валодати эътидол мегузарад, яъне ҷарҳзании берунӣ дар ҳамаи ин моментҳои номбурда давомнок, бо мушкิลӣ, бо сарф кардани қувваи зиёди зоянда ба амал меояд. Аз сабаби он, ки камони қовуқ кунҷи тезро ба вучуд меорад (дар ин намуди кос), нуқтаи тақяғоҳ дар он пайдо намешавад, он хело поён аз он ҷой гирифта, ба ҷатан зиёдтар зӯр меорад ва бештар онро медаронад.

Механизми валодат дар мавриди кӯндалангтангии кос. Агар тангии чунин намуд на он қадар калон бошад, валодат ба таври эътидол мегузарад. Баъзан дарзи сахмӣ аз сабаби танг будани андозаи кӯндаланг ба хати рости даромад мувофиқ шуда аз кос мегузарад (яъне бе ҷарҳзании дарун). Агар пушти сарак ба пеш нигаронида бошад, валодат ба таври пешомади пушти сар ва агар ба қафо нигарон бошад, ба таври намуди қафогии пушти сар мегузарад. Дар мавриди дараҷаҳои зиёди тангии кос амалиёти ҷарғоҳӣ мегузаронанд.

Механизми валодат дар мавриди коси паҳни рахитӣ. Аз сабаби он, ки андози рости даромад хурд аст, чунин хусусиятҳои валодатро дидан мумкин аст.

1. Давомнок истодани сарак бо хати дарзи сахмиаш дар хати кундалангӣ даромад.

2. Каме рост шудани сарак (ба ҷои хамшавӣ), ки дар натиҷаи он нармаки калон назар ба хурд поён ҷой мегирад, яъне сарак бо кос бо андози кӯндаланги хурд медарояд.

3. Ҷойгиршавии асинклитикии сарак.

Одатан асинклитикии пеш ба амал меояд, яъне дарзи сахмӣ ба димоға наздик шуда фарқи пушт дар он андармон мешавад ва фарқи пеш зиёдтар ба кос медарояд. Дар ҳамин ҳолат сарак аз даромади кос мегузарад. Баъди ин ҳеҷ монегӣ наместонад, баръакс чунин намуди кос дар ҳамвориҳои боқимонда ва хусусан дар баромад андозҳои калон дорад ва валодат ниҳоят бо шитоб анҷом меёбад, ки ин ҳам барои тифл ва ҳам барои зоянда иллату маҷрӯҳияти зиёд меорад.

Механизми валодат дар мавриди коси танги паҳни оддӣ. Сарак дар даромад ба таври коси паҳну рахитӣ медарояд, лекин аз сабаби он, ки андозҳои рост дар ҳама ҳамвориҳо хурд аст, он чарх намезанад, истодани дарзи сахмӣ дар андози кӯндаланг дида мешавад. Баъзан механизми валодат ба таври пеш истодани пушти сар мегузарад. Дар қаъри кос сарак чарх намезанад. Агар чархзанӣ рӯй надихад, амалиёти чарроҳӣ гузаронидан зарур мешавад (чангакҳои рости Лазаревич).

Механизми валодат дар мавриди коси баробартанг ва паҳн ба бартарии ин ё он намуди кос вобаста аст. Валодат дар ин намуди тангии кос ниҳоят вазнин ҳам барои тифлу ҳам барои зоянда мегузарад ва бештар нишондод барои амалияти чарроҳӣ мегардад.

Бурдани валодат дар мавриди коси танг. Валодат дар мавриди тангии кос масъулияти баландро талаб мекунад. Тактикаи бурдани валодат, тарзи он ба дараҷа ва намуди тангии кос, ҳаҷми тифл, қувваҳои валодатӣ вобаста аст.

Барои онро муайян кардан ҳаматарафа санҷидани зани ҳомила, хусусан дар вақташ зарур аст. Барои ҳамин ҳам ҳомиларо 2-3 ҳафта пеш аз валодат дар таваллудхона ҷойгир мекунанд. Баъди ҳаматарафа санҷидан тактикаи валодатро муайян мекунанд.

Дар мавриди дараҷаҳои III ва IV тангии кос амалиёти чарроҳӣ, яъне буриши қайсарӣ ҳатмист. Ин ягона тарзест, ки тифли зиндaro ба даст меорад. Дар мавриди дараҷаи I-II тангии кос валодатро ба таври назорат ва поидан мегузаронанд. Динамикаи валодат, ҳолати зоянда ва тифлро бодикқат санҷида муайян мекунанд, ки валодат ба таври табиӣ мегузарад ё амалиёти чарроҳӣ зарур аст. Дар мавриди пайдо шудани ҳолатҳои ногувор, ҳангоми валодати мустақилона ба амалиёти чарроҳӣ мегузаранд. Фақат дар давоми валодат мушоҳида карда мешавад, ки коси танги анатомӣ функционалист ё не. Вақте, ки аломатҳои номувофиқати кос ва сарак пайдо мешавад, ҳатман ба амалиёти чарроҳӣ бояд гузашт.

Барои бармаҳал нарафтани об зоянда бояд рӯи бистар бошад. Баъди рафтани об санҷиши маҳбалӣ ҳатмист, то ки афтодани банди ноф ё дастчаи тифл дар вақташ муайян карда шавад.

Аз сабаби он ки валодат давомнок аст, зоянда мондаю шалпар мешавад. Барои ҳамин ҳам дар вақташ ҳӯрокҳои сабуки зудҳалшаванда медиҳанд. Мунтазам узвҳои таносулиро бо маҳлулҳои антисептикӣ мешӯянд (пешгирии инфекция).

Характери обиятро аз маҳбал назорат мекунанд (хушк, риму фасод ва ғайра), дар вақташ рафтани пешобро таъмин мекунанд. Дар мавриди сустии дард, бояд зоянда каме дам гирад, хобад, баъди он одатан дард пуриктидортар мешавад. Додани ин ва ё он доруҳои дардро пурзӯркунанда хавфнок аст, он ба кафидани бачадон меорад. Агар дард тези саҳт бошад, сегменти поён дардманд шавад, бояд ҳатман наркози чуқур дод, чунки онҳо аломатҳои хавфи кафидани бачадон мебошанд ва зуд ба амалиёти чарроҳӣ бояд гузашт.

Бояд ҳаракати саракро дар кос мушоҳида кард. Дар ҳамин маврид мувофиқати косу саракро муайян кардан мумкин аст. **Тарзҳои Сонгейместер ва Вастен барои муайян кардани мувофиқати косу сарак ёрӣ мерасонад.**

Барои тарзи Сонгейместер тазомерро истифода мебаранд. Зоянда дар як паҳлӣ меҳобад. Аввал конюгатаи беруниро чен мекунанд, баъд тугмаи пешро ба баландии сарак мегузоранд. Дар мавриди мувофиқати косу сарак конюгатаи беруни 3-4 см аз андозаи дуюм ченкарда калон аст, агар баракс бошад, косу сарак номувофиқанд ва валодат мустакилона намегузарад.

Аломати Вастен баъди рафтани об ва ворид шавии сарак ба даромади кос муайян карда мешавад. Зан бо пушташ меҳобад. Кафи дастро ба рӯи қовуқ гузошта, оҳиста ба боло равона мекунанд. Агар даст аз қовуқ ба сарак фарояд, валодат мустакилона мегузарад, агар ба боло барояд ва ё бо сарак дар як сатҳ бошад, андозҳои сараку кос номувофиқанд ва амалиёти ҷарроҳӣ зарур аст. Инчунин санчишҳои ултрасадоӣ ва рентгенӣ барои муайян кардани мувофиқатии косу сарак ёрии амалӣ мерасонанд.

Сарфӣ назар аз он, ки косу сарак бо ҳам мувофиқат мекунанд, агар сустии қувваҳои валодат, аломатҳои бадшавии ҳолати тифл ва дигарҳо дар даромади кос мушоҳида шаванд, бояд амалиёти ҷарроҳӣ, яъне буриши қайсарӣ гузаронид.

Дар давоми валодат бояд дилзании тифлро ҳаматарафа ва бодикқат санчид ва пеши ҳавфи ҳипоксия ва асфикасияро гирифт. Валодат дар мавриди коси танг аз духтур сабр, диққат ва масъулияти калонро талаб мекунад. Ин гуна валодатро бояд духтури ихтисосаш баланду олий барад.

Ҳамаи тарафҳои санчиши чунин зояндаро баркашида, тактикаи валодатро бояд ба ғоидаи тифл ҳал намуд. Барои ин бештар бояд амалиёти ҷарроҳӣ гузаронд.

ТАВАЛЛУД ҲАНГОМИ ТИФЛИ КАЛОН

Тифли калон гуфта тифлери меноманд, ки ҳангоми таваллуд вазнаш 4000 гр. ё зиёда мебошад, тифли гигантӣ – 5000 гр. вазн дорад. Ин амроз дар вақти муосир 10% ташкил медиҳад.

Сабаб ва патогенез. Тифли калон ва гигантӣ, дар гурӯҳҳои зерини занон таваллуд мешаванд:

занҳои бисёрзояндае, ки синнашон аз 30 боло аст;

занҳое, ки дар валодатҳои гузашта тифли калон доштанд;

занҳои фарбеҳ;

занҳои қадбаланд;

занҳое, ки дар вақти ҳомиладорӣ вазни зиёд илова кардаанд;

занҳое, ки ҳомиладориро аз мӯҳлаташ гузарондаанд;

инчунин занҳое, ки бемории қанд доранд.

Хинси кӯдак низ аҳамият дорад, яъне чинси мардона бештар бо вазни калон таваллуд мешавад.

Мубодилаи карбогидратӣ-қандӣ ва чарбуғӣ дар системаи модар – машина-тифл ҳангоми тифли калончусса хусусиятҳои хоси худро дорад, ки ба тифл чарбу қанд бештар мегузаронад. Ин ба зиёдшавии вазни тифл мусоидат мекунад.

Рафти ҳомиладорӣ ва таваллуд. Дар занҳое, ки тифли калон ва гигантӣ доранд, рафти ҳомиладорӣ ва таваллуд хусусиятҳои хоси худро дорад, яъне дар онҳо сарторикии дерина 2 маротиба зиёдтар воমেҳӯрад, бисёрбӣ ва гузаронидани ҳомиладорӣ аз мӯҳлат 1,5 маротиба зиёдтар ба вучуд меояд. Таваллуд бештар бо аворизҳо мегузарад. Сараки тифли калон дар даромади кос ҳаракатнок бисёр меистад, ки ин дар 40% ҳолатҳо ба барвақт ё пеш аз мӯҳлат рехтани обҳои наздитифлӣ оварда мерасонад. Дар давраи I-ӯми валодат вайроншавии амалиёти қувваҳои валодат мушоҳида карда мешавад. Дар давраи II-юми таваллуд тифли калон ҳангоми гузаштан аз роҳҳои валодат бо мушкилиҳо дучор мешавад. Дар ин ҳолат коси танги клиникӣ (функционалӣ) 5 маротиба зиёдтар нисбат ба вазни миёнаи тифл воমেҳӯрад. Ҳамчунон осебияти бофтаҳои нарми роҳҳои валодат ба вучуд омаданаиш мумкин аст. Давраи ҳамроҳакӣ ва баъдивалодатии бармаҳал бо хунталафдиҳии зиёд мегузарад. Дар навзод асфиксия ва осебияти тифл, кефалогематома, хунрезии дохилии касо-

хонаи сар, шикасти кулфак, осеби сутунмӯҳра бештар дида мешаванд. Агар таваллуд бо роҳҳои табиӣ валодат анҷом нагирад, он гоҳ биомеханизми таваллуд чун биомеханизми таваллуд ҳангоми коси танги баробар тангшуда мегузарад. Истодани сарак дар яке аз андозаҳои қачи кос бо хати сахмӣ дер ба амал меояд. Сипас қатшавии пурзӯри сарак ба вучуд меояд, ки нармаки хурд амиқ дар тири барандаи кос ҷой мегирад. Тобхӯрии чорбандӣ вақти зиёдро талаб мекунад, ҳамчунон тобхӯрии дохилии сарак вақти зиёдро сарф мекунонад.

Тобхӯрии берунии сарак аз ҳисоби ҳаҷми васеъи китфҳо мушкил мегардад. Тавлиди китфҳо бо мушкилӣ ба вучуд омада, баъзан ҳатто ба шикасти кулфак[о сабабгор мешавад. Ҳатто тавлиди танаки тифл кувваи муайяно талаб мекунад.

Бурдани ҳомиладорӣ ва таваллуд. Барои он ки аворизҳо ҳангоми валодат пеш гирифта шаванд, бояд ташхиси аниқ ва вазни аниқ тифлро муайян карда тавонист, ки инро кардан мушкил аст. Дар маслиҳатҳои занона занҳои гурӯҳи хатараш зиёдро пайдо намуда, ба сабзиши қачи тифл аз рӯи ҳисоби гирди шикам, баландистии қаъри бачадон назорат мекунанд. Таваҷҷӯҳи хосаро барои муайян кардани ташхиси бемории қанд зоҳир менамоянд. Дар ҳафтаи 38-уми ҳомиладорӣ дар шӯъбаи таваллодатӣ бистарӣ мекунанд. Дар ин шӯъба ташхиси амиқ мегузаронанд. Пеш аз таваллуд андозаи гирди шикам дар занҳое, ки тифли калон доранд аз 100 см зиёд мегардад, баландистии қаъри бачадон аз 40-42 см зиёд мешавад. Ҳангоми пешомади сарӣ ба воситаи косченкунак ё циркуляри махсус андозаи мустақими саракро чен кардан мумкин аст, ки аз 12 см зиёд аст. Яке аз усулҳои амиқ ташхис ҳангоми тифли калон ин усули ултрасадо мебошад, ки яке аз нишондодҳои муҳим ин андозаи бипариеталии сарак, андозаи гирди шикам, дарозии устухони рон ва таносуби дарозии устухони рон ба андозаи гирди шикам мебошад. Ба воситаи усули ултрасадо на танҳо вазни тифл ва шакли макросомияро муайян мекунанд. Шакли симметрии ин

баробар зиёд шудани нишондодҳои фетометриро нишон медиҳад. Ҳангоми шакли асимметрии андозаи бипариеталии сарак, дарозии устухонии рон аз меъёр каме зиёд мебошад, андозаи гирди шикам бошад, аз меъёр хеле зиёд мешавад. Шакли ассиметрии аксар вақт дар занҳое, ки касалии қанд доранд, вомерӯрад. Дар чунин кӯдакҳо ҳангоми таваллуди китфҳо мушкилии зиёде ба вучуд меоянд.

Нақшаи таваллудро аз рӯи собикаи ҳомиладорӣ, омодагии организми зан ба таваллуд, калонӣ ва ҳолати тифл, андозаҳои кос муайян месозанд. Буриши қайсариро дар занҳое, ки тифли калон доранд, Ҳангоми пешомади косӣ, хадша дар бачадон, косӣ танги анатомӣ, аз мӯҳлат гузаронидани ҳомиладорӣ, гипоксияи музмини тифл, шаклҳои вазнин гестоз ва амрози экстрагениталӣ гузаронида мешавад. Ҳангоми бурдани таваллудҳои муқаррарӣ пешгирии ҳипоксияи тифл, хунравӣ дар давраи ҳамроҳакӣ ва давраи бармаҳали баъди валодатӣ гузаронида мешавад. Дар давраи баъди таваллудӣ мумкин аст, ки аворизи уфунатии роҳҳои валодатӣ вомерӯрад, бинобар баъди таваллуд ингуна занҳо таваҷҷӯҳи хосаро талаб мекунанд.

Пешгирӣ: Дар Марказҳои Солими Репродуктивӣ гурӯҳи хатари баланд доштара пайдо намуда, ба чараёнҳои мубодилавӣ дар мӯҳлати ҳомиладорӣ назорат мекунанд, ду ҳафта пеш аз таваллуд бистарӣ карда, нақшаи валодатро аз рӯи ҳолати акушерӣ муайян месозанд.

ТАВАЛЛУД ҲАНГОМИ ҲОЛАТҲОИ КАЧ ВА КЕНДАЛАНГИ ТИФЛ

Агар тири тӯлии тифл бо тири тӯлии бачадон мувофиқ наояд, ин ҳолатро нодуруст меноманд. Агар тири тӯлии тифл бо тири тӯлии бачадон дар зери кунҷи рост бурида шавад, он гоҳ ин ҳолат ҳолати кӯндаланг ном дорад. Агар тири тифл бо тири бачадон таҳти кунҷи тез бурида шавад, он гоҳ, ин ҳолат ҳолати кач ном дорад. Ҳолатҳои нодурусти тифл хеле кам (0,2-0,4%) вомерӯранд.

Сабабҳо. Сабабҳои ба вучуд омадани ҳолатҳои нодурусти тифл бо сабабҳои пешомади каси ҳамшабеҳанд. Сабабҳои асосӣ:

**ин сусти шудани тонуси мушакҳои бачадон,
тағйир ёфтани шакли бачадон,
ҳаракатнокии зиёд ё маҳдуднокии ҳаракати тифл мебошанд, ки ин шароитҳо ҳангоми анамалияи инкишоф ва омосҳои бачадон,
пешомади машина,
бисёробӣ, камобӣ,
бисёртифлӣ,
сусти девораи шикам,
қоси танг ба вучуд меоянд.**

Ташхис. Ҳолати кундаланг ва қачи тифл аксар вақт бе мушкилӣ ташхис карда мешавад. Ҳангоми азназаргузаронӣ шикам бо шакли кундаланги бачадон диққатро ҷалб мекунад. Андозаи гирди шикам ҳама вақт аз меъёри мӯҳлати ҳомиладорӣ зиёд буда, баландистии қаъри бачадон аз меъёри мӯҳлат хурд аст. Ҳангоми истифода бурдани усули Леополд-Левицкий нишондодҳои зеринро ба даст овардан мумкин: дар қаъри бачадон ягон ҳел қисми калон вучуд надорад, дар қисмҳои паҳлуии бачадон бошад қисми калонро пайдо кардан мумкин аст (дар як тараф қисми калони саҳт, дар тарафи дигар қисми калони нарм вучуд дорад). Қисми пешомад муайян карда намешавад. Дилзании тифл дар минтақаи ноф беҳтар шунида мешавад.

Мавқеи тифл аз рӯи сарак муайян карда мешавад. Ҳангоми мавқеи якӯм сарак аз тарафи чап ва ҳангоми мавқеи дуҷум сарак аз тарафи рост палмосида мешавад. Намуди мавқеи тифл аз рӯи тахтапушт муайян карда мешавад: агар тахтапушт ба пеш нигарон бошад, он гоҳ намуди пеш, агар ба ақиб нигарон бошад, намуди ақиб ба вучуд меояд.

Муоинаи маҳбалӣ ҳангоми ҳомиладорӣ ва таваллуд, дар мавриди бутун будани обаки тифлӣ маълумоти зиёд нишон намедиҳад, ӯ фақат набудани қисми пешомад-

ро собит месозад. Ҳангоми рехтани обҳои наздитифлӣ ва кушодашавии гарданаки бачадон (4-5 см) китфак, шона, изофаҳои нӯгтези сутунмӯҳро муайян кардан мумкин аст. Аз рӯи ҷойгиршавии изофаҳои нӯгтез ва шона намуди мавқеи тифлро, аз рӯи чуқурчаи зеробағалӣ мавқеи тифлро ошкор кардан мумкин аст. Агар чуқурча ба рост нигарон аст, он гоҳ мавқеи якӯм аст, ҳангоми мавқеи дуҷум ба чап нигарон аст.

Равиш ва бурдани ҳомиладорӣ ва таваллуд. Ташҳиси ҳолати кӯндалангӣ ва қачро бояд ҳангоми ҳомиладорӣ муайян кард. Ёрии зиёд-ро ба ин санҷиши ултрасадоӣ медиҳад. Ба ҳомиладорон аз ҳафтаи 32-юм машқҳои росткунанда мефармоянд. Тобхӯрии берунии пешгирикунанда ҳангоми ҳолати кӯндаланг самарайи устувор намедиҳад. Таваллуд ҳангоми кӯндаланг омадани тифл ғайриэтидол мебошад. Он бо роҳҳои табиӣи валодат ҳангоми тифли зинда ғайриимконпазир аст. Агар таваллуд дар ҳона оғоз ёфта бошад муоинаи қаноатманд нагузаронида бошад, он гоҳ аворизҳо дар давраи якӯми таваллуд рӯй медиҳанд. Ҳангоми ҳолати кӯндаланг обҳои наздитифлӣ ба пешу ақиб ҷудо карда намешаванд, бинобар ҳамин онҳо пеш аз мӯҳлат мерезанд. Ин авориз мумкин ба афтидани банди ноф, дасти тифл оварда расонад.

Баъди рехтани обҳои наздитифлӣ бачадон тифлро зич ихота намуда, ҳолати дершудаи кӯндалангро ба вучуд меорад. Ҳангоми хуб будани қувваҳои валодатӣ китфак бештар ба ковокии кос мефарояд, сегменти поёнии бачадонро тунук мекунонад, ҳалқаи контраксионӣ боло баромада ҳолати қачро мегирад. Аломатҳои хатари кафидани бачадон ба вучуд меояд, ки агар сари вақт ёрӣ расонида нашавад, кафидани бачадон рӯй медиҳад. Оқибати дигар низ ҷой дошта метавонад. Агар қувваҳои валодат суст шаванду, обҳои наздитифлӣ резанд, он гоҳ чараёни валодат бозистода, уфунати болораванда хурӯҷ мегирад. Агар таваллуд тӯл кашад, ба фавти тифл оварда мерасонад. Барои ин, ки аворизҳои дар боло зикр шуда рӯй надиханд, зани ҳоила бояд 2-3 ҳафта пеш аз таваллуд бистарӣ карда ша-

вад, ўро муоинаи хуб намуда ба таваллуд тайёр кардан лозим аст. Дар замони муосир роҳи ягонаи таваллуд ҳангоми ҳолати кўндаланг - ин буриши қайсарӣ аст, ки ба манфиати ҳам модар ва ҳам тифл мебошад. Пешвақтҳо амалиёти классикии тобхӯрии тифлро ба пояш истифода мебурданд, ки натиҷаҳои қаноатбахш надод. Барои ҳамин ҳам ин усулро фақат ҳангоми таваллуди тифли дуҷоми дугоникҳо истифода мебаранд. Агар ҳолати дершудаи кўндаланг зоҳир гардад ва тифл фавтида бошад, он гоҳ амалиёти тифлвайронкунандаро истифода мебаранд. Тобхӯрии классикии тифл ба пояш ва амалиёти тифлвайронкунанда бояд дар зери наркози тўлонӣ, ҷудокунии дастии машина ва муоинаи дастии бачадон гузаронида шавад.

ТАВАЛЛУД ҲАНГОМИ ҲОМИЛАДОРИИ БИСЁРТИФЛӢ

Ҳомиладории бисёртифлӣ дар 0,5-2% занон вохӯрда бо таваллуди ду ё се тифл ба анҷом мерасад. Аз рӯи формулаи оммаи умум қабулшуда дугоникҳо дар 1:80 таваллуд, сегоникҳо дар 1:80² (6400) таваллуд, чоргоникҳо 1:80³ (512000) таваллуд, панҷгоникҳо дар 1:80⁴ (40960000) таваллуд воমেҳӯранд. Дар вақтҳои охир шумораи дугоникҳо дар занҳое, ки контросептивҳои ҳормоналӣ, бордоршавии экстракорпоралӣ ва индуксияи ҳомиладориро истифода бурдаанд, бештар воমেҳӯранд.

Сабаб ва патогенез. Аз рӯи қоида сабаби ба вучуд омадани ҳомиладории бисёртифлӣ ин омилҳои ирсӣ мебошад, ки аз тарафи модар 7,5%, аз тарафи падар 1,7% ташкил медиҳад. То вақтҳои охир чунин мешумориданд, ки агар синни зан аз 35 боло бошад, ин низ ба ҳомиладории бисёртифлӣ мусоидат мекунад. Дар замони муосир дар байни заноне, ки ҳомиладории дугоникӣ доранд, вазни хоси занони якҷумзоя дар синни 26-28 3 маротиба афзуд, ки эҳтимол ин бо усулҳои табобати безуретӣ вобастагӣ дошта бошад.

Ҳомиладории бисёртифлӣ мумкин аст ё дар натиҷаи бардоршавии якчанд тухмҳуҷайра ба вучуд ояд, ё дар натиҷаи аз як тухмҳуҷайра инкишоф ёфтани якчанд чанин ба вучуд меояд. Аз ин рӯ ду намуди дугоникхоро фарқ мекунанд: дизиготӣ (гуногунтухма) ё монозиготӣ (яктухма). Дар дугоникҳои дизиготӣ ду пардаи амнионӣ ва хорионӣ вучуд доранд, инчунин ду машина, яъне намуди биамнионӣ ва бихорионӣ. Дар дугоникҳои монозиготӣ ду пардаи амнионӣ ва як пардаи хорионӣ, як машина – монохорионӣ ва биамнионӣ вучуд дорад.

- **Ташҳиси ҳомиладории бисёртифлиро дар семоҳаи аввали ҳомиладорӣ танҳо ба воситаи усули ултрасадоӣ ошкор кардан мумкин аст.**
- **Дар семоҳаи дуюм андозаи бачадон аз мӯҳлаташ калон шудан мегирад, ки ин аз ҳомиладории бисёртифлӣ шаҳодат медиҳад. Ташҳиси охиринаро танҳо бо воситаи усули ултрасадоӣ муайян мекунанд. Дар ибтидои семоҳаи сеюм ҳаҷми бачадон ба таври назаррас аз мӯҳлат калон мешавад. Андозаи гирди шикам ва баландистии қаъри бачадон ба мӯҳлати ҳомиладорӣ мувофиқат намекунад. Ҳангоми усули палмосидани Леополд – Левицкий пизишк 3 ё 4 қисмҳои калони тифлҳоро муайян мекунад. Намудҳои ҷойгиршавии қисмҳои калони тифл гуногунанд, зеро ин ба ҳолатҳо ва пешомадҳои тифлҳо вобастагӣ доранд. Ба воситаи аускултатсия ду нуқтаи дилзании тифлҳоро шунидан мумкин аст, ки байни онҳо фосилаи ором ҷой дорад. Зудии дилзании тифлҳо 8 адад дар як дақиқа фарқ мекунанд, ки ин ташҳиси дугоникхоро собит месозад. Усули ултрасадоӣ на танҳо имкон медиҳад, ки ташҳиси аниқ гузошта шавад, балки андозаҳои аниқи тифлҳоро медиҳад.**

Ҳомиладории бисёртифлро бо ҳомиладорӣ бо тифли калон, бисёробӣ ва ҳубобчабеморӣ таххиси тафриқӣ мегузаронанд.

Равиш ва бурдани ҳомиладорӣ. Равиши мӯътадили ҳомиладорӣ фақат дар 11% ҳолатҳо ба назар мерасад. Анамалияи ҳолати тифлҳо 16 маротиба зиёдтар нисбат ба ҳомиладории якгонагӣ вомахӯрад. Сарторикии бармахал ва дерина 4 маротиба зиёдтар ба вучуд меояд. Яке аз хусусиятҳои бисёртифлӣ ин серобии яке аз тифлҳо мебошад. Қариб, ки дар нисфи ҳомиладорони бисёртифла яке аз тифлҳо аз сабзиш оқиб мемонад, ҳатто фавти ӯ мумкин аст. Аз се як ҳиссаи занон гирифтори хатари қатъи ҳомиладорӣ мебошанд, ки ин дар ҳафтаҳои 34-37 ҳомиладорӣ бештар рух медиҳад. Дар 40% ҳомилагон камхунӣ инкишоф меёбад. Назорати пизишк ба ҳомиладорон бисёртифла аз рӯи аворизҳои эҳтимолӣ гузаронида мешавад. Ҳатто дар рафти мӯътадили ҳомиладорӣ бояд муоинаи статсионарӣ дар ҳафтаи 28-30 ҳомиладорӣ гузаронида шавад, то ки хатари қатъи ҳомиладорӣ ошкор карда шавад, ҳолати тифлҳо ва андозаҳои эҳтимолӣ муайян карда шаванд. Табобати аворизаҳои ҳомиладориро ва касалиҳои экстрагениталиро бояд дар ин мӯҳлат гузаронид. Бистарии такрориро дар шӯъбаи аворизҳои ҳомиладорӣ 2-3 ҳафта пеш аз мӯҳлати таваллуд ба ҷо меоваранд, ки дар давоми он тарзи бурдани таваллудро аз рӯи ҳолати зан, тифлҳо ва аворизҳои инкишофёфтаре интихоб менамоянд.

Равиши таваллуд ва бурдани он. Ҳангоми таваллуд дар ҳомиладории бисёртифлӣ аворизҳои зиёд вомахӯранд. Аксарияти таваллуд пеш аз мӯҳлат оғоз меёбад, вазни наводон дар нисфи ҳолатҳо аз 2500 г зиёд нестанд. Бисёр вақт (қариб 50%) ҳарду тифл ё яке аз онҳо дар ибтидои таваллуд бо пешомади косӣ мебошанд, дар 10% ҳолатҳо бошад, ҳолати кӯндалангро мегиранд. Дар 60% ҳолатҳо бошад, обҳои наздителифлӣ пеш аз мӯҳлат мерезанд. Ин авориз мумкин аст бо афтидани нофаки тифл ё қисмҳои хурди он анҷом ёбад, ки ба ин ҳолати кӯндаланги тифл, пешома-

ди косӣ ва андозаҳои хурди тифлҳо мусоидат мекунанд. Дар 20-30% таваллуд аномалияи қувваҳои валодатӣ мушоҳида карда мешавад, бештар сустии кашишхӯрии бачадон вомехӯрад. Дар давраи рониш бошад, бармаҳал чудошавии машинаи эътидол ҷойгиршудаи тифли дуюм вомехӯрад. Ҳамаи аворизҳои номбаршуда эҳтимолияти хипоксияи тифл ва осебиятҳои валодатиро зиёд мекунанд. Ҳангоми бисёртифлӣ равиши мӯътадили давраи ҳамроҳӣ ва давраи бармаҳали баъдивалодатӣ вайрон мешавад, дар 24% ҳолатҳо хунталафдиҳии зиёд ба вучуд меояд.

Бурдани таваллуд ҳангоми бисёртифлӣ диққати зиёдро талаб мекунад. Инчунин баҳои дурусти ҳолати момой ва баландхиттосиро талаб мекунад, то ки амалиётҳои дилҳои момоиро иҷро карда тавонад.

Дар момоии муосир таваллуд танҳо ҳангоми дугоникҳо бо роҳҳои табиӣи валодатӣ имконпазир аст. Ҳангоми сегоникҳо ва чоргоникҳо амалиёти ҷарроҳиро бояд гузаронид, то ки тифлҳои солим ба даст оварда шаванд.

Баъди таваллуди тифли якӯм паузаи кӯтоҳмуддат ба вучуд меояд. Дар ин вақт санчиши берунии момой мегузаронанд, то ки ҳолат ва пешомади тифли дуюмро муайян созанд, инчунин дилзании тифлро мешунаванд. Баъди 4-5 дақиқа дардҳо барқарор мешаванд. Табиб санчиши маҳбали мегузаронад, то ки обаки наздитифлиро кушояд, пас таваллуд бо роҳҳои табиӣ бурда мешавад.

Ҳангоми ҳомиладории бисёртифлӣ давраи сеюми валодатӣ аз рӯи аҳамияти худ аз давраи 1 ва 2 валодат фарқе надорад, бинобарон аз табиб диққати зиёдро талаб мекунад. Фаъолияти нокифоя будани амалиёти кашишхӯррандагии бачадон дар давраи кушодашавӣ ва рониш, ҳангоми чудошавии машина ва баромадани ҳамроҳак давом меёбад. Хунталафдиҳии мӯътадил танҳо дар нисфи занон мушоҳида карда мешавад. Дар 32% зояндаҳо хунталафдиҳӣ то миқдори ҳудудӣ мерасад, дар 24% зояндаҳо бошад, хунталафдиҳии ғайриэътидолӣ

мушоҳида карда мешавад. Дар давраи бармаҳали баъдивалодатӣ бошад, мумкин аст хунравии гипо – ватоникӣ хурӯҷ гиранд.

Ҳамаи гуфтаҳои дар боло зикршуда аз он шаҳодат медиҳад, ки бояд давраи ҳамроҳакӣ ва давраи бармаҳали баъдивалодатиро бо истифодабарии маводҳои кашишдиҳандаи бачадон фаъолона бурд. Аз зӯрзании охирин сар карда, дар давраи 2 валодатӣ барои пешгирии хунравӣ дар давраи ҳамроҳакӣ ва давраи баъдивалодатии бармаҳал дар як лаҳза маводҳои кашишхӯранда (метилэргометрин, окситосин) мегузаронанд.

Баъди таваллуди машина ўро хуб аз назар гузаронида, ба андозаи масоҳати машина, сохти пардаҳо ва девораи байнитифлӣ аҳамият медиҳанд. Ҳангоми дугоникҳои бихорионӣ ва биамнионӣ девора аз 4 баргак иборат мебошад. Ҳангоми дугоникҳои биамнионӣ ва монокорионӣ аз ду баргак иборат мебошад.

Ҳангоми чараёни таваллуди авориздор сари вақт бояд ҷарроҳиро истифода бурд. Агар обҳои наздитифлӣ дар ҳафтаҳои 28-34-ум пеш аз мӯҳлат резад ва тифли якӯм дар пешомади сарӣ бошад, он гоҳ ҳомиладориро ба муддати 3 рӯз тӯл дода, пешгирии дистресс-синдроми тифлро бояд гузаронид. Пас аз ин амал таваллудро бедор мекунанд ё ҳудаш оғоз меёбад. Агар мӯҳлати ҳомиладорӣ аз 35 ҳафта гузарад, он гоҳ тифлҳо расида мебошанд, бинобарон баъди 2-3 соати рехтани обҳои наздитифлӣ бедоркунии таваллудро гузаронидан зарур аст. Дар ҳамаи ҳолатҳо бояд ба дараҷаи расидани гарданаки бачадон баҳо дод. Таваллудбедоркунӣ бо воситаи дохили варидӣ ворид намудани простогландинҳо ё окситосин гузаронида мешавад.

Агар таваллуд пеш аз мӯҳлат бошад баъди таваллуди тифли якӯм ҳатман ба ноф қаппак мегузаронанд, то ки ҳангоми мавҷуд будани як машина тифли дуҷум хунро талаф надиҳад. Давраи рониш барои тифли дуҷум ниҳоят хатарнок мебошад, зеро мумкин аст тифли дуҷум дар ҳолати кӯндаланг ё қач бошад. Момодоя ба воситаи истифодабарии тобхӯрии берунии момой бояд ўро ба ҳолати тӯлӣ бар-

гардонад, баъди тобхӯрӣ обаки наздитфлиро мекушоянд ва таваллуд бо роҳҳои тиббӣ ба анҷом мерасад. Агар тобхӯрии берунии момой бесамара ба анҷом расад, он гоҳ ба зоянда наркоз дода, амалиёти классикии чархонидани дохилӣ – берунаи момиро истифода мебаранд. Баъди ислоҳшавии ҳолати тифли дуюм ба экстраксияи тифл аз тарафи кос шурӯъ менамоянд. Дар давраи рониш бояд омили вақтро дар хотир нигоҳ дошт, чи қадар фосила байни таваллуди тифлҳо зиёд бошад, ҳамон қадар барои тифли дуюм хатар дорад. Фавти тифл аз асфиксия, инчунин, аз бармаҳал ҷудошавии машина ба вучуд омаданааш мумкин аст. Баъди таваллуди тифли якум мумкин аст, ки машина ҷудо шавад, ки ин бо инкишофи зухуроти саририи бармаҳал ҷудошавии машинаи тифли дуюмро оварда мерасонад. Дар ин бора пайдо шудани хун аз роҳҳои валодатӣ ва бад шудани ҳолати тифл шаҳодат медиҳад. Тифлро танҳо бо воситаи чангакҳои момой, вакуум-экстраксия ё аз пояш, вобаста аз вазъи момой наҷот додан мумкин аст. Агар дар давраи дуюми валодатӣ ягон амалиёт истифода бурда шавад, бояд ҳатман санҷиши дастии бачадонро баъди валодат гузаронид, то ки аз бутунии он эмин бошем.

Фавти перинаталӣ ҳангоми ҳомиладории бисёртифлӣ нисбат ба ҳомиладории яктифла 2 маротиба зиёдтар аст. Бинобар момии муосир нишондод барои буриши қайсарӣ ба манфиати тифлҳо зиёд аст. **Нишондод барои буриши қайсарӣ ин сегоникҳо, ҳолати кӯндаланги ҳарду ё як тифл, пешомади косӣ тифли якӯм ё ҳар ду мебошад.**

III. ХУНРАВӢ ДАР ДАВРАИ ҲОМИЛАДОРӢ ВА ВАЛОДАТ

ХУНРАВИИ ДАВРАИ 1-УМИ ҲОМИЛАГӢ

Хунравии давраи 1-уми ҳомилагӣ бештар дар мавридҳои зерин рух медиҳад.

1. Хунравие, ки ҳангоми қатъ шудани ҳомилагӣ (ҳангоми бачапартоии ихтиёрӣ) рух медиҳад.

2. Хунравие, ки дар натиҷаи қатъшавии ҳомилагии ғайрибатнӣ пайдо мешавад.

3. Хунравие, ки инкишофи хубобомос боиси он шудааст.

Ҳар кадоме аз ин иллатҳо боиси афзоиши хунравӣ мешаванд. Хунравӣ бошад аломати асосӣ ба ҳисоб рафта, дар суръати сари вақт ёрӣ нарасонидан ба вусъат ёфтани садамаи (шоки) геморрагӣ ва синдроми лахташавии умумии дарунирагӣ оварда метавонад.

Ҳомилагии ғайрибатнӣ – ин имплантатсияи тухмхуҷайраи бордоршуда на дар ковокии бачадон, балки масалан дар найчаи бачадон, тухмдонҳо ё дар сифок аст. Аз намудҳои гуногуни ҳомилагии ғайрибатнӣ бештар ҳомилагии найчагӣ воমেҳӯрад.

Сабабҳо, ки ҳомилагии ғайрибатниро ба вучуд меоранд:

- 1. Илтиҳоби найчаҳо**
- 2. Ҳипофунксияи тухмдонҳо**
- 3. Эндометриоз**
- 4. Омоси найчаҳо ва тухмдонҳо**
- 5. Истифода бурдани спирали дохили бачадонӣ**

Аломатҳои сарирӣ. Маъмулан занони гирифтори ҳомилагии хориҷи бачадонӣ дар ҳолати хеле возеҳ будани қатъшавии он ба дармонгоҳ муроҷиат мекунанд. Вобаста ба мавқеъ гирифтани тухми чанин ва тарзи қаткунии ҳомилагии найчагӣ 2 шакли он, яъне порашавии найча ва исқоти найчагиро фарқ мекунанд.

Ҳангоми порашавии найча аломатҳои зерин ба назар мерасанд: беҳушшавӣ, сарчархӣ, дарди шадидӣ шикам, инчунин аломати шок (паст шудани фишори хун, тахикардия, бемадории шадид).

Ҳангоми исқоти найчагӣ аломати асосии клиникӣ дар қисми поёни шикам пайдо шудани дардҳои шикампеч ва тадриҷан афзудани аломатҳои камхункунонӣ ба ҳисоб мераванд.

Ташхис:

**Қатъи ҳайзбинӣ;
Симптомҳои хунравии дарунӣ;
Муоинаи маҳбалӣ;
Пунксияи (тазриқи) гумбази ақибӣ маҳбал;
Муоинаи ултрасадоӣ;
Лапароскопия.**

Муолича: Ҳангоми ташхис гузоштани ҳомилагии найчагӣ роҳи асосии муолича дар ҳолати вучудодада ин ҷарроҳии фаврӣ мебошад, яъне бурида партофтани найчаи ҳомила (тубэктомия) ва раван кардани ҳамаи кушишҳои табобатӣ бар зидди шоки геморрагии авҷёфта ва анемияи пасигеморрагӣ.

ХУБОБОМОС

Хубобомос – ин бемории тухмаки чанинӣ буда, мӯяки (пати) хорион ба хубобчаҳое табдил меёбад, ки да-руни он аз моеъи шаффоф пур шудааст. Сабабҳои но-маълуманд.

Аломатҳои сарирӣ:

- 1. Хунравӣ аз бачадон симптоми асосӣ аст. Вай дар моҳҳои аввал оғоз ёфта, гоҳ суст ва гоҳ шиддат меёбад.**
- 2. Набудани аломатҳои ҳақиқии ҳомилагӣ.**
- 3. Ба мӯҳлати ҳомилагӣ мувофиқат накардани андозаи бачадон-вай аз он калонтар аст.**
- 4. Бармаҳал пайдо шудани сарторикии деринаи ҳомилагӣ.**
- 5. Баъзе вақтҳо аз роҳҳои таносулӣ пайдо шудани хубобчаҳои моеъдори шаффоф.**

Хубобомос маълуман дар моҳҳои 4-5 ҳомилагӣ ме-тавонад худ ба худ аз бачадон таваллуд шавад.

Ташхис:

- 1. Аз рӯи аломатҳои клиникӣ;**
- 2. Муоинаи маҳбалӣ;**
- 3. Муоинаи ултрасадоӣ.**

Муолича дар дармонгоҳ суръат мегирад. Агар андозаи бачадон аз 12 ҳафта зиёд набошад кюретаж ё амалиёти вакуум-аспирация зарур аст. Дар мавриди калон будани бачадон ду ангуштро ба бачадон дароварда, хубобомосро гирифта мепартоянд.

ИСКОТИ ҒАЙРИИХТИЁРӢ

Искоти ғайриихтиёрӣ дар 22 ҳафтаи аввал қатъ шудани ҳомилагиرو меноманд. Басомади искоти ғайриихтиёрӣ то 15% мерасад.

Сабабҳо: иллатҳои бачадон, ҳалалёбии имунологӣ, иллатҳои эндокриноложӣ, омилҳои сироятнокӣ, бемориҳои қисмонӣ (соматикӣ), омилҳои руҳӣ, оризаҳои қараёни ҳомилагӣ.

Патогенез: Ҳангоми искоти ғайриихтиёрӣ ҳар қадам аз сабабҳои дар боло зикршуда дар ниҳояти қор метавонанд, ки боиси шиддатнокишавии фаъолияти кашшихӯриҳои бачадон шуда, аз девори бачадон ҷудо шудани тухмаки чанин ва берун кардани он гарданд.

Клиника: Қараёни клиникӣ искоти ғайриихтиёрӣ марҳалаҳои зеринро дар бар мегирад:

1. Искоти саршуда.
2. Искот «дар роҳ» (авҷёфта).
3. Искоти нопурра.
4. Искоти пурра.

Дар искоти саршуда афзудани фаъолияти кашшихӯриҳои мушакҳои бачадон рӯй медиҳад ва боиси қаме кучидани тухмаки чанин ва пайдошавии хунобаҳо аз канали гарданаки бачадон мешавад.

Искот «дар роҳ» ё авҷёфта. Алоқаи тухмаки чанин аз ҷойгоҳи чанин қанда мешавад, вай ба қисми поёни бачадон ва ё канали гарданаки бачадон мефарояд. Ин намуни искотро дардҳои шадиди ҷангалқунандаи қисми поёнии шикам ва хунравихоҳе зиёд ва фаровон ҳамроҳӣ мекунанд.

Искоти нопурра: агар як қисми тухмаки чанин аз худуди бачадон баромада, дар ковокии бачадон фақат

боқимондаи вай монда бошад, чунин исқотро нопурра ме-
номанд. Симптоми асосии ин марҳалаи қатъкунии
ҳомилагӣ хунравиҳои гуногун аст: хунравиҳои кам ё фаро-
вон, ки ба шоки геморрагӣ оварда метавонад.

Дар исқоти пурра тухмаки чанин пурра ҷудо меша-
вад ва аз ковокии бачадон мебарояд. Хунравӣ дар ин на-
муд худ ба худ манъ мешавад.

Ташҳис.

Ташҳис дар асоси шикоятҳои бемор, маълумотҳои
муоинаҳои умумӣ ва гинекологӣ, усулҳои муоинаи
ҳормоналӣ ва ултрасадоӣ гузошта мешавад.

Дар бораи шикоятҳо мо аллакай сухан рондем,
ҳолати умумии бемор асосан аз дараҷаи талафоти хун,
давомнокӣ ва шиддати он вобаста аст. Хунравиҳои
тӯлонии на чандон зиёд боиси камхуншавии бемор меша-
ванд, ки инро аз ҳолати зани бемор муайян кардан мумкин
аст. Хунравии шадид боиси шоки геморрагии бемор гашта
метавонад.

Маълумотҳои муоинаи гинекологӣ: ҳангоми исқоти
таҳдидкунанда мувофиқ будани андозаи бачадон ба
таваккуфи ҳайзбинӣ гувоҳӣ медиҳад. Тағйироти сохти
гарданаки бачадон дида намешавад.

Ҳангоми исқоти саршуда гарданаки бачадон каме
кӯтоҳ шуда,
дахани берунияш каме боз аст. Ҳангоми сакти «дар роҳ»
бачадони тарангшуда ба мӯҳлати ҳомилагӣ мувофиқат ме-
кунад, қутби поёни тухмаки чанинро аз гарданаки канали
бачадон ба осонӣ дастрас кардан мумкин аст.

Ҳангоми исқоти нопурра андозаи бачадон хурд ва
дахони берунӣ кушода аст.

Муолиҷа.

Занҳои гирифтори исқоти ғайриихтиёрии саршуда
бояд, ҳатман дар дармонгоҳ табобат шаванд.

Муолиҷа иборат аст аз:

1. Речаи бистарӣ шудан;
2. Парҳез;

3. Дорухое, ки шиддати психоэмоционалиро паст ва мушакҳои бачадонро сушт мекунад (баралгин, $MgSO_4$ ва ғ.).

Барои исқоти «дар роҳ» ва нопурра ба таври фаврӣ бистарӣ кардан ва гузаронидани чарроҳӣ тавсия мешавад: тозакунии инструменталии бачадон, ки боиси манъшавии хунравӣ мегардад.

ХУНРАВИИ НИМАИ ДУЮМИ ҲОМИЛАҒӢ

Хунравии нимаи дуҷуми ҳомилагӣ аксар вақт ба пешомади машина, пеш аз мӯҳлат ҷудо шудани машинаи дуруст ҷойгиршуда, ба патологияи марҳалаи III валодат, яъне ҳалалёбиҳои ҷудошавии плацента, хунравии гипотоникӣ вобаста аст. Ин хунравиҳо метавонанд ба шоки геморрагӣ оваранд ва дар системаи хунлаҳткунандаи хун тағйироти ғуноғун ба вучуд биёранд.

ПЕШОМАДИ МАШИМА

Пешомади машина – нодуруст ҷойгиршавии онро меноманд: ба ҷои дар девор ё дар қаъри бачадон ҷойгир шудан, машина сегменти поён ва ноҳияи даҳони дарунии гарданаки бачадонро фаро мегирад. Басомади ин ориза 0,5-0,8% аст.

Тасниф

1. Пешомади пурраи машина (марказӣ) – ин дар даҳони дарунии гарданаки бачадон пурра ҷой гирифта ва онро пӯшонидани плацента.

2. Паҳлӯӣ ҷой шудани машина, дар ин маврид қисми он дар сегменти поёни бачадон ҷой мегирад ва даҳони даруниро пурра наепӯшонад.

Ҷунин вариантҳои пешомади плацентаро танҳо дар ҷараёни валодат ва бо андозаи 5-6 см боз шудани даҳанаи гарданаки бачадон тахмин кардан мумкин аст.

Этиология: 1. Бисёр таваллудкунӣ

2. Бемориҳои музминии илтиҳобии бачадон

3. Тарошидани бисёри инструменталии

бачадон

4. Хадшаи бачадон

5. Миомаи бачадон

6. Нокифоягии истмикӣ-сервикалӣ

Аломатҳои сарирӣ: Симптоми асосии пешомади машина хунравӣ аст. Вай дар натиҷаи аз девори бачадон чудо шудани машина рӯй медиҳад, зеро дар чараёни ҳомиладорӣ сегменти поёни меёзад ва мӯякҳои пласента аз сабаби ёзиши кофӣ надоштан, аз девораи бачадон чудо мешавад. Вобаста ба тарзи пешомади машина хунравӣ метавонад дар вақти ҳомилагӣ ва ё ҳангоми таваллудкунӣ ба амал ояд. Агар машина дар марказ ҷойгир шуда бошад, хунравӣ дар триместри II, агар дар паҳлӯ бошад дар триместри III ва ё ҳангоми таваллудкунӣ ба амал меояд.

Шиддати хунравӣ дар вақти пешомади пурраи машина нисбат ба пешомади нопурраи машина хеле зиёд аст. Гипоксияи тифл яке аз симптомҳои асосии пешомади машина аст. Дараҷаи гипоксия аз масоҳати ҷудошавӣ ва суръати ҷудошавии машина вобаста аст.

Таъхис:

1. Аз рӯи аломатҳои клиникӣ

2. Муоинаи гинекологиро дар дармонгоҳ ба шартӣ омода будани мизи ҷарроҳӣ қардан зарур аст. Ҳангоми муоина бо дастаҳо дар атрофи гумбази маҳбал бофтаҳои мулоим, яъне машимаро ҳис қардан мумкин аст.

3. Дар шароити имрӯза усули бонуфузи таъхиси пешомади машина муоинаи ултрасадоӣ ба шумор меравад.

Муолича.

Ҳангоми ин ё он усули табобати ҳомилагиро интихоб намудан вариантҳои пешомади машина, давраи ҳомилагӣ, ҳолати роҳҳои таваллудкунӣ, тифл ва миқдори хунравиро ба эътибор бояд гирифт.

Агар хунравӣ набошад ва ҳомилагӣ нотамои бошад, дар ҳамаи намудҳои пешомади машина доруҳои пасткунандаи фаъолнокии кашишхуриҳои бачадон, пешгирии камхуншавии зани ҳомила ва дуруст қардани вазъи тифлро истифода мебаранд.

Амалиёти қайсарии нақшавӣ дар вақти дар ҳафтаи 38-ӯми ҳомилагӣ ва пешомади пурраи (марказии) машина гузаронида мешавад, хунравии имконпазирро интизор набояд шуд.

Амалиёти қайсарии таъчилаго ҳангоми хунравии шадид ё миёна, новобаста аз мӯҳлати ҳомилагӣ, ҳолати тифл ва варианти пешомади машина иҷро кардан лозим аст.

Агар пешомади нопурраи машина ва хунравии наҷандон зиёд, пешомади сари тифл ва фаъолияти қувваҳои валодати хуб ҷой дошта бошанд, ҳангоми ба 3-4 см боз шудани гарданаки бачадон пардаи наздитифлиро мекафонанд. Сарак ба зудӣ поён мефарояд ва қисми ҷудошудаи машимаро ба девори бачадон ҷафс мекунад, хунравӣ маъмулан манъ мешавад ва таваллудкунӣ одатан бо осонӣ аз роҳҳои табиӣ ба хубӣ анҷом меёбад.

ПЕШ АЗ МҶҲЛАТ ҶУДУШАВИИ МАШИМАИ МҶЪТАДИЛҶОЙГИРШУДА

Дар ҳолати эътидол машина танҳо баъд аз таваллудкунӣ аз девори бачадон канда мешавад. Агар вай пеш аз вақт ҳангоми ҳомилагӣ, дар давраи I ё II таваллудкунӣ ҷудо шавад, ин ҳел аворизро ҷудошавии пешазмӯҳлати машинаи дуруст (эътидол) ҷойгиршударо меноманд. Басомади он ба 0,5% ташкил медиҳад. Ин авориз ба шаклҳои вазнини оризаҳои ҳомилагӣ дохил мешавад.

Этиология: Дар замони ҳозира дар пайдошавии ҷудошавии пешазмӯҳлати машина ба тағйиротҳои рағҳо аҳамияти калон медиҳанд, ки дар натиҷаи гестози дерина, бемориҳои гипертоникӣ ва ё бемориҳои гурдаҳо ба вучуд меояд. Зудшикан будани рағҳо, боиси порашавии онҳо ва ба вучуд омадани гематомаи байни машина ва девораи бачадон мегардад, ки онҳо машимаро аз девораи бачадон ҷудо мекунанд.

Аломатҳои клиникӣ: Симптомҳои асосии пеш аз мӯҳлат ҷудо шудани машина хунравӣ ва дарди умумӣ ва

махдуд ҳангоми ламскунӣ дар бачадон, гипертонуси мушакҳои он, гипоксияи тифл ё мурдани он аст. Вазнинии ин ҳолат аз дараҷаи талафоти хун вобаста ба масоҳати ҷудошавии машина (ҷузъи, пурра) ва суръати он аст.

Дар дараҷаи сабук вазъи умумии ҳомилагон ва ё зояндагон тағйир намеёбад. Нишондодҳои гемодинамикӣ мӯътадил боқӣ мемонанд. Тапиши дили тифл тағйир намеёбад.

Дараҷаи вазнини ҷудошавии машимаро бад шудани вазъи бемор, пайдошавии симптомҳои шок ҳамроҳӣ мекунаманд. Берангшавии қабатҳои пӯст, тахикардия, паст шудани фишор бо суръат инкишоф меёбад. Симптомҳои гипоксияи дохилибатнии тифл пайдо шуда, зиёд мешаванд, марги вай ба зудӣ фаро мерасад.

Хунравии дохилӣ, берунӣ ва омехта мавҷуд аст. Намуди хунравӣ аз мавқеи хуномос вобаста аст. Агар хуномос дар маркази машина бошад хунравии берунӣ ба вучуд наомаданаш мумкин аст. Гематомаи калони ретропласентарӣ роҳи баромад наёфта девораи бачадонро меҷабад (бачадони Кувелер). Агар ҷудошавии машина дар канор рӯй диҳад, хун пардаҳои чанинро дур карда ба берун мебарояд. Ранги хун ҳамеша сурхи баланд аст.

Дард аломати асоси он аст, вай дар натиҷаи кашишхӯриҳои пардаи серозии бачадон пайдо шуда, сабук ва шадид буда метавонад.

Ташҳис

Ҷудошавии машимаро дар асоси аломатҳои клиникӣ ва муоинаи ултрасадоӣ ташҳис мекунаманд.

Бурдани занони гирифтори ҷудошавии пешазмӯҳлати машина ба вазъи умумии таваллудкунандагон, дараҷаи хунравӣ, ҳолати роҳҳои валодат, мӯҳлати ҳомилагӣ ва ғайра вобаста аст.

Муолича бояд ҷиҳатҳои зеринро фаро гирад:

- 1. Манъкунии хунравӣ**
- 2. Ҳар чӣ зудтар таваллуд кардан**
- 3. Зиёд кардани мӯҳлати зиндамонии тифл**
- 4. Пешгирӣ кардани системаи хунлахтакунии**

Ҳангоми пеш аз вақт чудо шудани машина пешгирӣ кардани инкишофи шоки геморрагӣ ва синдроми лахташавии умумии дарунира-
гӣ зарур аст. Аз ин рӯй вазифаи асосии табобатӣ таваллудкунии боэҳтиётона ва зуд мебошад. Дар вақти ҳомилагӣ ва марҳалаи I таваллуд ин чорабинии амалиёти қайсарӣ аст.

Дар охири марҳалаи I ва дар марҳалаи II ин корро тавассути чангакҳои акушерӣ, вакуум –экстрактсия ба анҷом мерасонанд.

ХУНРАВИИ МАРҲИЛАИ СЕЮМИ ТАВАЛЛУДКУНӢ

Хунравие, ки дар 24 соати аввали баъди таваллуд рӯй медиҳад, бештар ба ҳалалёбии қобилияти кашишхӯрии бачадон, вазъи гипо- ва атоникии он, дер мондани ҳамроҳак ё қисми он, осеб ёфтани роҳҳои валодатӣ ва инкишоф ёфтани синдроми ЛУД вобаста аст. Басомади ин оризаҳо ба 3-4% баробар аст.

Хунравӣ баъди таваллудшавии тифл ин талафдодани хун бо миқдори 500 мл ба ҳисоб меравад (ТУТ).

Дар занҳое, ки камхунӣ доранд хунравӣ баъди таваллудшавии тифл ин талафдодани хун бо миқдори 300 мл ба ҳисоб меравад.

Ҳангоми гипотония пастшавии тонус ва қобилияти нокифояи кашишхӯрии бачадон ба назар мерасад. Ҳангоми дар бачадон манъ шудани ҳиссаҷаҳои ҳамроҳак, хунравии калони хавфнок, касалиҳои септикии баъдивалодатӣ ба вучуд меоянд. Хунравӣ метавонад баъди ҷудошавии машина баъди якчанд соат ва ҳатто баъди якчанд рӯз пайдо шавад. Ин хавфнокиро ба ҳисоб гирифта ҳангоми дар бачадон нигоҳ доштани ҳамроҳак ё пайдо шудани шубҳа ба часпиши пурагии он зарур аст, ки бо тезӣ муоинаи дасти бачадонро гузаронида, ҳиссаҷаи боқимондари гирифта лозим аст.

Аворизҳои хавфнок ва асосии давраи баъдивалодатии барвақт гипотония ва атонияи бачадон мебошанд. Онҳо бо хунравии бисёр ки беморро ба коллапси

постгемаррагӣ, ба ҳолати терминалӣ ва баъзан ба марг оварда мерасонад, зоҳир мешаванд.

Ба мафҳуми «Гипотонияи бачадон» норасогии қобилияти кашишхӯрии бачадон ва тонусҳои бавучуднаомадаи вайро ифода мекунанд. Сабабҳои гипотонияи бачадон монанди сабабҳои сустии қувваҳои валодатӣ мебошанд, дар баъзе ҳолатҳо гипотонияи бачадон баъди қувваи зиёди фаъолияти валодатӣ ва баъдивалодатӣ бо-суръат пайдо мешавад.

Дар бисёр ҳолатҳо ин вазъият, гарчанде ки амрози бошад ҳам, лекин баргарданда аст, ҳангоми табобати саривактӣ ва дуруст тонус ва қобилияти кашишхӯрии бачадон барқарор мешавад. Баъзан гипотония амиқтар шуда ё афзуда ба атония мубаддал мегардад.

Атония – ин пурра нестшавии тонус ва қобилияти кашишхӯрии бачадон мебошад; чунин беморӣ хело кам вомехӯрад. Сабабҳои атонияи ҳақиқӣ то ҳол пурра омӯхта нашудаанд. Дар баъзе ҳолатҳо ин сабабҳо монанди сабабҳои гипотония мебошанд, дар дигар ҳолатҳо атонияи бачадон бе гипотонияи пешгузашта ба вучуд меояд. Ба ин ориза пастсифатии модарзодии мушакҳои бачадон, афсурдашавии чуқури аксуламали физиологии дастгоҳи асабию азалии бачадон мерасонад.

Мафҳумҳои «гипотония» ва «атония» баробар ё ҳаммаъно нестанд ва ҳамаи ҳолатҳои пастшавии фаъолияти бачадонро атония номидан мумкин нест. Фарқи яги ин фаҳмишҳоро доништан на танҳо аҳамияти назариявӣ, балки аҳамияти калони амалӣ ҳам дорад, зеро табобати гипотония ва атония гуногунанд.

Клиника: Фавран баъди таваллуд бачадон қобилияти кашишхӯриҳоро аз даст медиҳад. Вай гипо- ва атоникӣ аст, аз дақиқаҳои аввал хунравӣ шадид аст ва занро ба зудӣ ба ҳолати шоки геморрагӣ мерасонад. Гипотонияи бачадон гуногун мебошад. Дар баъзе қанонҳои навроида дарҳол баъди баромадани машина хунравӣ сар мешавад ва бачадон ҳангоми палмосидан мулоим ё лаҳм шуда, пурра кашиш намекунад. Дар дигар ҳолатҳо баъди 10-15-30

дақиқаи баромадани машина хунравии на он қадар зиёд, ки баъди холишавии масона (пешобдон), молиши берунаи бачадон ва қабули маводҳои кашишдиҳандаи бачадон қатъ мегардад, ба вучуд меояд. Лекин баъди муддати кӯтоҳе бачадон боз мулоим шуда, қарри бачадон то сатҳи ноф ва аз он боло шуда, хунравӣ боз сар мешавад. Ҳангоми молиши бачадон аз маҳбал бо миқдори зиёд лахтаҳои хун мебароянд. Ин тарзи хунравии такрорёбанда хавфи зиёд дорад, барои он ки вай ба анемияи постгемаррагии вазнин оварда мерасонад. Ғайр аз ин, мумкин аст, ки духтури камтаҷриба қатъшавии муваққатии хунравӣ, такроран баромадани лахтаҳои на он қадар зиёди хун ва вучуд надоштани маҷрои хунравиро ба асос гирифта, ба ҳолати хавфноки хунравӣ баҳои дуруст надихад. Натиҷаи чунин хатоӣ ба ҳаёти зани навзод хатарнок мебошад. Чи хеле, ки қайд карда шуд, хунравӣ бештар дарҳол баъди валодат ба вучуд меояд, дар баъзе ҳолатҳо бошад, вай баъди якчанд соат сар мешавад. Хунравие, ки бо нигоҳ доштани ҳиссаҳои ҳамроҳак ва ё бо сироятҳои баъдивалодатӣ алоқа дорад, хело дертар дар ҳафтаи 1 ва 2-юми баъдивалодатӣ ба амал меояд. Чунин хунравиро хунравии дери баъдивалодатӣ меноманд.

Хунравии ҳангоми атонияи бачадон бавучудомада доимо бисёр мебошад, аз таъсири қабули маводҳои доругӣ, барангезандаҳои механикӣ, электрикӣ ва ҳароратӣ қатъ намегардад.

Муолича. Таботати хунравӣ дар давраи баъдивалодатии барвақт пеш аз ҳама бо маълумкунии сабабҳои вай: мондани қисме аз ҳамроҳак дар бачадон, гипотония (атония)-и бачадон, осеб ёфтани роҳҳои валодатӣ ва инкишоф ёфтани синдроми ЛУД вобаста аст.

Таботати хунравии баъдивалодатӣ аз комплекси чорабиниҳои ба якдигар алоқаманд иборат мебошад.

- **Муайян сохтани ҳолати зани зоида шуда, басомади нафас, ҳолати пӯст (ранг, ҳарорат, намнокӣ), фишори шараёнӣ**

- Таклиф намудани гӯруҳи ёрирасон (2-то акушер-гинеколог, акушерка, анестезиолог-реаниматолог, анестезистка)
- Хангоми таъхис шудани аломати садамаи постгеморрагӣ амалиётҳои зерин гузаронидан лозим:
 1. Катетеризатсия кардан 2 вариди калон дар давоми 5 дақиқа
 2. Даруни вариди ворид кардани маҳлули Рингер бо суръати 1 литр дар давоми 15-20 дақиқа, 1 литри давомаш дар муддати 30 дақиқа
 3. Назорати ҷиддӣ аз нишонаҳои фишори шараёни (аз 90 мм сут сим зиёд), набз (то 90 зарба дар як дақиқа), диурез (аз 50 мл кам набояд)
 4. Гарм кардани занн зоидашударо

Баъди бартараф намудани аломатҳои садамаи постгеморрагӣ сабаби хунравӣ муайян кардан лозим. Агар ҳамроҳак то ҳоло таваллуд нашудааст:

1. Аз ноф кашидани ҳамроҳак гузаронидан лозим
2. Агар натиҷаи қаноатбахш нест, бо даст ба даруни бачадон даровардари машимари мекананд ва ҳамроҳакро ба берун хориҷ мекунанд
3. Хангоми кучидани бо даст машимари, агар аз ҷояш он канда нашавад ва хунталафдиҳӣ зиёдтар шуд, лапаротомия бо гистерэктомия гузаронидан ҳатмист.

Агар ҳамроҳак таваллуд шудааст:

1. Ҳамроҳакро аз назар гузаронида, бутунии онро муайян сохтан лозим. Агар ягон қисмаш боқимондааст дар бачадон таъхиси дастакии ковокии бачадонро гузаронидан лозим ва 10 АД окситосин дохилимушакӣ ворид мекунанд.
2. Хангоми паст шудани тонуси мушакҳои бачадон мушти берунаи бачадонро гузаронида, 10 АД окситосин дохилимушакӣ ворид мекунанд, ва инфузияи 500

- мл маҳлули Рингер омехта бо 20 АД окситосин бо суръати 30 чакра дар як дақиқа сар кардан лозим.
3. Агар хунталафдихи давом дода шавад (миқдори он ба 1000 мл баробар шуд) гемостази чарроҳӣ гузаронидан ҳатмист (лапаротомия, гистерэктомия, бастани шараёнҳои бачадонӣ).
 4. Роҳҳои валодатӣ аз назар гузаронида мешавад, агар кафидагҳои он вучуд дошта бошад, онро бояд барқарор кард.
 5. Агар вайроншавии лахташавии хун дида шавад – вақти лахташавии хун бо усули Ли-Уайт 7 дақиқа ва аз он зиёд бошад, трансфузияи плазмаи яхшударо сар кардан лозим.
 6. Дар шароити давом додани хунрезӣ, баъди ворид намудани 3 литр моеъ ва мейёри гемоглобин будани 70 г/л ва камтар трансфузияи массаи эритроцитарӣ мегузаронанд.

САДАМАИ ҲЕМОРРАГӢ

Садамаи геморрагӣ ҳолате мебошад, ки ҳангоми ҳомилагӣ, зоидан ва баъди таваллуд хунравии шаддиду зиёд рух медиҳад боиси шадидаи кам шудани ҳаҷми хуни гардишкунанда, хунронии дил ва перфузияи бофтаҳо мешавад, ки дар натиҷаи он декомпенсатсияи механизмҳои муҳофизатӣ ба вучуд меоянд.

Одатан геморрагияи зиёда аз 1000 мл боиси шоки геморрагӣ мешавад.

Сабабҳои хунравӣ, ки ба садампи геморрагӣ оварда метавонанд, инҳоянд:

1. Пеш аз мӯҳлат ҷудо шудани машинаи эътидол ҷойгиршуда;
2. Пешомади машина;
3. Даридани бачадон;
4. Сиқти ғайриихтиёрӣ;
5. Қатъшавии ҳомиладорӣ ғайрибатнӣ;
6. Халалёбии ҷудошавии машина дар марҳалаи III таваллудкунӣ;

7. Хунравихои гипотонӣ ва атонӣ дар давраи аввали марҳалаи баъдитаваллудӣ.

Аломатҳои клиникӣ: чунин марҳалаҳои садамаи геморрагӣ эътироф шудааст:

Марҳалаи I – садамаи компенсатсияшаванда (чуброншаванда)

Марҳалаи II – садамаи чуброннашавандаи барқароршаванда

Марҳалаи III – садамаи барқарорнашаванда

Марҳалаи I – маъмулан ҳангоми талафоти тақрибан 20%-и ҳаҷми хуни гардишкунанда (700-1200 мл) пайдо мешавад. Аломатҳои клиникӣ: рангпарيداгии қабатҳои пӯст, тахикардия то 100 зарба дар як дақиқа, олигурия (кампешобӣ).

Марҳалаи II - ҳангоми талафоти 30-35% ҳаҷми хуни гардишкунанда (1200-2000 мл) руҳ медиҳад. Фишори хун то 100 мм ст. сим. паст мешавад, тахикардия (120-130 зарба дар як дақиқа), тангнафасӣ, акросианоз, арақи сард ва нооромӣ, кампешобӣ камтар аз 30 мл/с, паст шудани фишори вариди марказро мушоҳида кардан мумкин аст.

Марҳалаи III – ҳангоми талафоти 50%-и ҳаҷми хуни гардишкунанда (зиёда аз 2000 мл) инкишоф меёбад. Фишори систоликӣ ба 60 мм сут. сим. паст мешавад, набз то 140 зарба дар як дақиқа тез мешавад. Рангпарيداгии қабатҳои пӯст ва хунукшавии дасту пойҳо ниҳоят зиёд аст, бар ҳам арақи сард, анурия, ва беҳушӣ мушоҳида мешавад.

Таъхис: Садамаи геморрагӣ маъмулан ба осонӣ таъхис карда мешавад, ба хусус агар хунравии фаровон возеҳ мавҷуд бошад. Барои арзёбии дараҷаи шок комплекси симптомҳои оддиро истифода кардан зарур аст:

- 1. Ҳосияту хусусияти ранг ва ҳарорати қабатҳои пӯст;**
- 2. Арзёбии набз;**
- 3. Чен кардани фишори хун;**
- 4. Арзёбии индекси шокӣ;**
- 5. Муайян кардани диурез аз рӯи соат;**

6. Чен кардани фишори вариди марказӣ (50 мм. рт. ст);

7. Муайян кардани нишондоди гематокрит (0,43);

Нишондоди оддӣ ва нисбатан маълумотдиҳандаи дараҷаи гиповолямия (камии ҳаҷми хун) ҳангоми садамаи геморрагӣ индекси шокии Алиговер – таносуби басомади набз дар як дақиқа бо ҳаҷми фишори систоликӣ ба ҳисоб меравад. Ин индекс дар одамони солим 0,5 аст. Ҳангоми то 20-30% паст шудани ҳаҷми хуни гардишкунанда вай то 1,0 зиёд мешавад, ҳангоми 30-50% талаф ёфтани бошад, ба 1,5 мерасад.

Муолича:

Ҳангоми ташхис шудани аломати садамаи постгеморрагӣ амалиётҳои зерин гузаронидан лозим:

- 1. Катетеризатсия кардан 2 вариди калон дар давоми 5 дақиқа**
- 2. Даруни вариди ворид кардани маҳлули Рингер бо суръати 1 литр дар давоми 15-20 дақиқа, 1 литри давомаш дар муддати 30 дақиқа**
- 3. Назорати ҷиддӣ аз нишонаҳои фишори шараёнӣ (аз 90 мм сут сим зиёд), набз (то 90 зарба дар як дақиқа), диурез (аз 50 мл кам набошад)**
- 4. Гарм кардани зани зоидашударо**

Амалҳои аз ҳолати садама баровардани бемор бояд ҳамзамон бо ҷорабиниҳои манъкунии хун суръат гирад. Агар барои манъ кардани хунравӣ бачадонро бурида гирифтани зарур бошад, ин корро кардан лозим аст.

СИНДРОМИ ЛАХТАШАВИИ УМУМИИ ДАРУНИРАГӢ (ЛУД)

Дар амалияи акушерӣ ин синдромро бештар ҳангоми шаклҳои вазнини гестоз (ҷараёни номӯътадили хомилагӣ), пеш аз мӯҳлат ҷудо шудани машина, эмболияи

обҳои наздифлӣ, шоки геморрагӣ, сепсис (фосидшавии хун) ва ғайра, мушоҳида намудан мумкин аст.

Тасниф: Синдроми ЛУД дар шакли фазаҳои пай дар пай якдигарро ивазкунанда суръат мегирад. Чор марҳала мавҷуд аст.

Марҳалаи I - гиперкоагулятсия

Марҳалаи II –гипокоагулятсия:

бе фаъолшавии фибринолиз

бо фаъолшавии фибринолиз

Марҳалаи III - коагулопатия бо фаъолшавии

фибринолизи умумӣ

Марҳалаи IV – барқароршавӣ

АЛОМАТҲОИ КЛИНИКӢ

Аломатҳои клиники синдроми шадиди ЛУД дар натиҷаи ҳалалёбиҳои тромботикӣ (суддашавӣ) ва геморрагӣ зухур мекунанд, ки чунинанд:

1. Хунравӣ аз пӯст, пардаи луобӣ, хунравӣ дар ҷои сӯзанхалӣ, ҷароҳатҳои ҷарроҳӣ, бачадон.

2. Ҳалалёбии қобилияти системаи асаби марказӣ дар шакли эйфория, дезориентатсия, тирашавии шуур.

4. Нокифоягии шадиди гурдаҳо, чигар ва шуш.

Таъхис:

Барои муқаррар кардани ҷараёни синдроми ЛУД тестҳои зерини экспресс-таъхис мавҷуд аст:

1. Вақти лахташавии хун (тести асосии дар таъхиси ЛУД)

2. Тромбин – тест

3. Муайян кардани ПДФ

4. Миқдори тромбоситҳо

5. Вақти тромбшавӣ

Дар фазаи I кӯтоҳшавии вақти лахташавии хун ва вақти тромбшавӣ ба назар мерасад.

Дар фазаи II кам шудани миқдори тромбоситҳо ($120 \times 10^9/\text{л}$), вақти тромбшавӣ то 60 сон. ва аз он зиёд дароз мешавад, ПДФ ва эритроцитҳои осебдида дида мешаванд.

Дар фазаи III дароз шудани вақти лахташавии хун, то 100×10^9 /л кам шудани миқдори тромбоцитҳо дида мешавад, лизиси зудии лахтаи ҳосилшудаи хун руҳ медиҳад.

Дар фазаи IV лахтаҳои хун ба вучуд намеоянд, тромбин-тест зиёда аз 60 сон. аст, миқдори тромбоцитҳо камтар аз 60×10^9 /л аст.

Муолича:

Табоботи синдроми ЛУД аз се бахш иборат аст:

- 1. Терапияи садамаи гемморагӣ**
- 2. Аз байн бурдани сабабҳои асосии ба вучуд овардан он**
- 3. Мӯътадил сохтани лахташавии хун**

Дар соҳаи акушерӣ сабаби пайдошавии синдроми ЛУД тақрибан ҳамеша ба иллати бачадон вобаста аст. Маҳз аз бачадон ҳосилҳои тромбопластикӣ ба хуни организмӣ модар дохил мешаванд. Ин манбаи тромбопластин-хоро аз байн набурда, гемостазро мӯътадил ва синдроми ЛУД-ро нест кардан мумкин нест, аз ин сабаб ҷарроҳии таъҷилӣ – ампутатсияи бачадон тавсия мешавад.

Шаклҳои шадиди синдроми ЛУД одатан бо шоки геморрагӣ якҷоя мешаванд. Барои табобати он терапияи инфузионӣ – трансфузионӣ дар чунин ҳолатҳо истифодаи плазмаи яхкуноншударо (15мл/кг) беҳтар меҳисобанд.

Вазифаи душвортарин аснои табобати шакли шадиди синдроми ЛУД ин барқарор кардани коагулятсияи мӯътадили сифатҳои хун мебошад. Барои ин корро анҷом додан ҷараёни хунлахташавии дохилии рағҳоро манъ кардан, сушт кардани фаъолнокии фибринолиз ва барқарор намудани потенциали коагулятивии хун зарур аст.

1. Дар марҳалаи I - 500 воҳиди гепарин мегузаронанд (лекин ин марҳалаи ЛУД хеле каму душвор таъхир карда мешавад, чунки кӯттоҳмудат аст).

2. Дар марҳалаи II-III

- 1. Контрикал 20.000 воҳид, Трассисол 25 000 воҳид, Гордокс 100 000 воҳид**
- 2. Усули аз ҳама беҳтарин донисташудаи барқарор намудани сифатҳои коагулятсионии**

хун табобати ивазкунанда аст. Ба ин мақсад плазмаи яхкуноншударо истифода мебаранд.

IV. МАЧРҶҲИЯТИ ВАЛОДАТӢ

Дар вақти таваллудкунӣ осеб дидани бофтаҳои на-
рми роҳҳои валодат имкон дорад.

Бофтаҳои фарҷ, маҳбал, чатан ва гарданаки бачадон
низ метавонанд, ки иллатнок шаванд. Даридани бачадон
иллати вазнинтарин ба шумор меравад. Басомади чунин
оризаҳои таваллудкунӣ тақрибан 20%-ро ташкил
медиханд.

Даридани чатан

Даридани чатан аз ҷумлаи осебҳои маъмули мода-
рон аст ва 3 дараҷаи он ба назар мерасад:

- Даридани дараҷаи I** – иллати лиҳомаи ақибӣ, як
қисми девораи ақибии
маҳбал ва пӯсти чатан;
- Даридани дараҷаи II** – бутунии пӯсти чатан,
девораи маҳбал ва
мушакҳои чатан халал
меёбанд.
- Даридани дараҷаи III** - бар иловаи бофтаҳои
зикршуда, халқаи мушак
(сфинктер)-и беруни рӯдаи
рост, баъзан девораи пеши
рӯдаи рост то қабати
луобӣ (даридани нопурраи
рӯдаи рост)
- Даридани дараҷаи IV** - даридани рӯдаи рост ва
қабати луобии он.

Этиология ва патогенез. Аксар маврид чатанҳои
хадшадор меавад. Даридани чатан маъмулан асноӣ зои-
дани зуд ва шадид, рост шудани сараки тифл дар кос, тиф-
ли калон, амалиётҳои ҷарроҳӣ (гузоштани чангакҳои
момой, вакуум-экстрактсия) пайдо мешавад. Даридани ча-
тан дар охири давраи рониш ба амал меояд. Сараки пеш

ҳаракаткунанда ба бофтаҳои нарми канали валодат фишор меорад, ки дар натиҷаи он бозистии варидӣ рух медиҳад; аломатҳои вай кабудранг гаштани пӯсти чатан мебошад. Сусти шудан ва бозистии хун дар варид боиси ба бофтаҳо ҷаббида шудани қисми моеъи хуни рағҳо мешавад, ки дар зери таъсири ин ҳодиса пӯст рангу ҷилои махсус мегирад. Фишори минбаъдаи сарак боиси тангшавии шарён мешавад ва дар ин ҳолат пӯсти чатан рангпаридида мешавад. Ҳалалёбии просессҳои мубодила муқовимати бофтаҳо сусти мекунад ва аломати клинӣ хатари даридани чатан ба вуҷуд меояд. Агар хатари даридани чатан пешгирӣ карда нашавад, яъне вайро агар ҷок накунад, чатан меорад.

Дар вақти захмдор шудани чатан хунрезии дараҷаҳои гуногун ба назар мерасад, ҷарроҳат даромадгоҳи сироят шуда менамояд.

Ташҳис. Ҳангоми аз назар гузаронидани чатан баъди валодат маҷруҳияти он ташҳис кардан мумкин. Дар мавриди даридани дараҷаи 3 ва 4-и чатанро гумонбар шудан, васекунадаи ГеҒар ба рӯдаи рост андохта, ба девораи пеш фишор меорад, ба ин восита маълум месозанд, ки рӯдаҳо ва сфинктер осеб дидаанд, ё не.

Муолиҷа. Барқарор кардани бутунии чатан зери бедаркунии мавзӣ ва ё нарқози умумӣ сурат мегирад.

Амалиёти дӯхтани даридани чатанро аз кунҷи болоии даридани сар мекунад.

Ҳангоми даридани дараҷаи I чатан аз боло ба поён дар пардаи луобии маҳбал то лиҳомаи (спайка) ақибӣ як қатор ғиреҳҳои кетгутӣ меҳузданд. Пӯсти чатанро бо кӯкҳои абрешимӣ меҳузданд.

Ҳангоми даридани дараҷаи II чатан аввал бо кӯкҳои кетгутӣ мушакҳои пораишудаи чатанро пайвасти мекунад, баъд аз он дар пардаи луобии маҳбал то лиҳомаи ақибиву пӯст кӯк мегузаронанд.

Дар мавриди даридани дараҷаи III чатан аввал ҳалалёбиҳои рӯдаи ростро бартағриф месозанд,

пас аз ин нӯғҳои порашудаи сфинктерро ёфта, онҳоро пайваст мекунад, танҳо баъди анҷом додани ин амалиёт боқимондашро мисли даридани дараҷаи II онро медӯзанд.

Ҳангоми даридани дараҷаи IV-ми чатан аввал бутунии пардаи луобии рӯдаи ростро барқарор кардан лозим, пас аз ин нӯғҳои порашудаи сфинктерро ёфта, онҳоро пайваст мекунад, танҳо баъди анҷом додани ин амалиёт боқимондашро мисли даридани дараҷаи III чатан бо ҷо меоваранд.

ДАРИДАНИ ГАРДАНАКИ БАЧАДОН

Даридани гарданаки бачадон назар ба такрорзояндагон бештар дар навзодон рух медиҳад.

Тасниф

Дараҷаи I – дарозии даридагии гарданаки бачадон 2 см.

Дараҷаи II - дарозии даридагӣ зиёда аз 2 см, вале то гумбази маҳбал намерасад.

Дараҷаи III - даридагии гарданаки бачадон то гумбази маҳбал расида, ба вай мегузарад.

Этиология ва патогенез:

1. Нест шудани қобилияти элаستيкии бофтаҳои гарданаки бачадон (инфантилизм, хадшаҳо, илтиҳоб);

2. Аномалияҳои қувваҳои валодат, ҳалал ёфтани ҷараёни бозшавии гарданаки бачадон;

3. Калон бадани сарак (тифли калон, пешомадҳои ростшавандаи сарӣ, пеш аз мӯҳлат ростшавии сарӣ тифл);

4. Особбинии маҷбурӣ - ҳангоми бо ёрии ҷарроҳӣ зӯндан

(чангакҳои акушерӣ, вакуум-экстрактсия, стимулятсияи зоиш).

Аломатҳои клиникӣ

Даридани дараҷаи I бачадон одатан бе зухурот сураат мегирад. Ҳангоми даридагиҳои нисбатан амиқтар

(чукуртар) хунравӣ пайдо мешавад, ин ҳолат фавран баъди таваллуд шудани навзод сар мешавад. Суръати хунравӣ гуногун аст, вай метавонад ночиз бошад ва ё зиёд чорӣ шавад.

Ташхис. Даридагии гарданаки бачадон бо ёрии муоинаи гарданаки бачадон тавассути оина ташхис мешавад, гузаронидани ин амалиёт барои ҳамаи зоидагон дар марҳалаи аввали баъди таваллуд зарур аст.

Муолича. Даридагии гарданаки бачадонро бо дарзҳои кетгутӣ медӯзанд. Барои ин гарданакро бо анбурҳои нӯгдор ё тирдор ба тарафи даромадгоҳи маҳбал мекашанд ва ба тарафи муқобили даридат мебаранд. Кӯки якумро аз ҷои даридагӣ каме болотар мегузоранд, то ин ки боварӣ ҳосил намоянд, ки даридагии гарданаки бачадон то гӯмбаз давом намекунад. Агар кунҷи бологии ҷарроҳати гарданаки бачадонро ба ҷашм дида нашавад, гузаронидани ташхиси дасти кӯвокии бачадон барои муайян кардани бутунии девораи он зарур аст.

Даридагии гарданаки бачадон боз аз он ҷиҳат хатарнок аст, ки вай на танҳо боиси хунравӣ мешавад, балки манбаи ҷарроҳатҳои баъдитаваллудӣ ва сирояти болоравӣ шуда метавонад. Агар даридагии гарданаки бачадон табобат карда нашавад, ҳадшаҳо пайдо мешаванд, ки инҳо боиси чаппагардоншавии гараданаки бачадон (экстропион), пайдошавии эрозия ва дигар бемориҳои заминавӣ пеш аз саратонии гарданаки бачадон мегардад.

Пешгирӣ: аз ҷиҳати техникӣ дуруст гузоштани ҷангакҳои момӣ, ба танзим даровардани суръати таваллудкунӣ даридани гарданаки бачадонро пешгирӣ кардан мумкин аст.

Кафидани бачадон

Аз ҷумлаи миқдори умумии зоиданҳо даридани бачадон 0,1-0,05%-ро ташкил медиҳад. Дар байни ҳодисаҳои фавти модарон даридани бачадон яке аз ҷойҳои аввалинро ишғол мекунад.

Тасниф

- I. Аз рӯи вақти пайдошавӣ:**
 - 1. Даридаи аснои ҳомилагӣ
 - 2. Даридаи аснои таваллудкунӣ
- II. Аз рӯи аломатҳои патогенезӣ:**
 - 1. Даридагиҳои ихтиёрӣ
 - а) типӣ
 - механикӣ (ҳангоми мавҷуд будани монеаи механикӣ ва солим будани девораи бачадон)
 - б) атипӣ
 - гистопатологӣ (аснои ҳалалёбиҳои ғайриэътдолии девораи бачадон)
 - механикӣ гистопатологӣ (аснои омезиш ёфтани монеа ва ҳалалёбии девораи бачадон)
 - 2. Мачбури (амалиётҳои ҷарроҳӣ, стимулятсия, тарзи Кристеллер).
- III. Аз рӯи равиши клиникӣ:**
 - 1. Даридагии таҳдидкунанда
 - 2. Даридагии оғозёфта
 - 3. Даридагии мукамал
- IV. Аз рӯи ҳислати иллат:**
 - 1. Кафидагӣ (трещина)
 - 2. Даридагии нопурра
 - 3. Даридагии пурра
- V. Аз рӯи ҷойгиршавӣ:**
 - 1. Даридани қаъри бачадон
 - 2. Даридани тани бачадон
 - 3. Даридани сегменти поёнӣ
 - 4. Аз гумбазҳо ҷудо шудани бачадон.

Исбот шудааст, ки дар патогенези даридани бачадон омезиши омилҳои гистопатологӣ бо омилҳои механикӣ ҷой дорад. Ҳалалёбии патологияи мушакҳои бачадон омилҳои гумонбаршавӣ буда, монеаи механикӣ бошад, омилҳои ҳалкунанда аст.

Мувофиқи назарияи Бандл даридани бачадон оқибати аз ҳад зиёд таранг шудани сегменти поёнӣ аст, ки дар натиҷаи вучуд доштани монеаи механикӣ ҳангоми та-

валлудшавии тифл рух медиҳад. Монеаҳои зоидан, ки бои-си даридани бачадон мешаванд, гуногунанд: коси танг, тифли калон, нодуруст ҷойгиршавии сарак, ҳолатҳои нодурусти тифл, омоси тухмдони зан ва бачадон.

Вербов дар ибтидои асри XX дар баҳси таърихияш бо Бандл исбот кард, ки сабаби даридани бачадон дар ҳалалёбии морфологии девории бачадон ниҳон аст, ки инро муоинаҳои гистологии девораи бачадон пас аз кафидани бачадон тасдиқ намуданд.

Сабабҳои номукаммалии миометрий гуногунанд: инфантилизм, нуқсонҳои инкишофи бачадон, ҳадшаҳои баъди сикт, амалиёти собиқи қайсарӣ ва ҳамчунин бемориҳои музмини илтиҳобии бачадон.

Аломатҳои клиникӣ

1. Таҳдиди (хавфи) даридани бачадон:

- Зоянда аз тарсу ваҳм ноором аст, ба дарди қатънашавандаи шикам ва миён шикоят мекунад.
- Қуввати дардҳо хеле сахт аст, зуд-зуд, шадид ва дардоканд.
- Бачадон дароз мешавад, махсусан, ноҳияи сегменти поёни тунук мешавад, ҳангоми вайро ламс кардан дард мекунад.
- Дар вақти пурра боз шудани даҳони гарданаки бачадон ҳалқаи контраксионӣ то баробари ноф меравад, ки дар натиҷа бачадон ба «соати қумӣ» монанд мешавад.
- Пешобкунӣ дарнок, бошиддат аст ва ё умуман пешоб намекунад, ин ҳолат дар натиҷаи фишорёбии масона ба амал меояд.
- Азбаски бачадон таранг аст, ламс кардани қисмҳои тифл душвор мебошад.
- Ҳангоми номутаносиб будани андозаи косу сараки тифл аломати мусбати Вастен зоҳир мегадад.

- Ҳаракати қисми пешистодаи тифл дида наме-
шавад, омоси возеҳи зоидаи дар сараки тифл
пайдо мешавад.
- Гарданаки бачадон ва узвҳои берунии чинсӣ
варам мекунад.

Даридагии оғозёфтаи бачадон: клиникааш ба дарида-
гии таҳдидунада монанд аст. Каме даридани девораи ба-
чадон аломатҳои навро ба вучуд меорад:

- Дардҳо ба рагкашиҳо табиал меёбанд,
- Аз маҳбал ифрозоти хунолуд меояд, пешоб низ хуно-
луд аст.
- Симптомҳои гипоксияи тифл пайдо мешаванд.

Даридагии мукамал. Дар лаҳзаи даридани бачадон
ҷуни аломатҳои клиникӣ инкишоф меёбанд:

- Дарди ногаҳонии «ханҷарӣ» пайдо мешавад.
- Зоянда доду ғиғон карда ишкामашро мекапад.
- Фаъолияти кашишхӯрандаи бачадон якбора қатъ ме-
гардад.
- Тифл аз ковокии бачадон ба шикам мебарояд ва дар
наздикии бачадон ламс карда мешавад.
- Задани дили тифл шунида намешавад.
- Аз роҳҳои таносуӣ (чинсӣ) ҷорӣ шудани ифрозоти
хунолуд мушоҳида мешавад. Аммо, хунравӣ аксар
вақт дар ковокии шикам рух медиҳад. Дарачаи
хунравӣ ва характери даридани бачадон аломатҳои
шоки геморрагиро муайян мекунад.

Агар ба зоянда ёрии таъҷилии тиббӣ расонида наша-
вад, вай аз хунравӣ вафот карданаш мумкин аст. Фавтида-
ни модарон ҳангоми даридагии мукаммали бачадон 80%-
ро ташкил медиҳад. Сабаби марг асосан шоки геморрагӣ
ва травмикианд.

Муолича. Ба зояндагоне, ки дар онҳо аломатҳои да-
ридагии таҳдидунада ва оғозёфтаи бачадон зоҳир меша-
вад, ёрии фаврӣ расонидан зарур аст, зеро даридани бача-
дон дар кӯтоҳтарин вақт рух дода метавонад. Дар навбати
аввал фаъолияти кашишхӯрандагии бачадонро бо роҳи

додани наркози амиқ қатъ кардан лозим аст. Вақте ки хоби наркотикӣ ва оромии пурраи бачадон зоҳир мегардад, беморро ба каталка бор карда, ба утоқи ҷарроҳӣ бурдан лозим аст.

- Дар ҳолати таҳдидӣ даридани бачадон ин хел занҳоро бо ёрии амалиёти қайсарӣ таваллуд мекунонанд.
- Ҳангоми даридагии оғозёфта лапаротомия мегузаронанд.
- Ҳангоми даридагии мукаммали бачадон дар заминаи табобати шоки геморрагӣ ва бедардкунӣ пурра амалиёти лапаротомияро мегузаронанд. Ковокии шикамро боз карда, онро тафтиш мекунанд, тифли мурдагиро мегиранд. Баъд аз ин бачадонро муоина мекунанд, микдори осебҳоро муайян мекунанд, ҷойгиршавӣ ва амикии онҳоро мефаҳманд. Узвҳои ҳамсояро низ ба таври ҷиддӣ аз назар мегузаронанд (масонаро). Ҳаҷми ҷарроҳӣ (дӯхтани даридагӣ, ампутатсия, экстирпатсияи бачадон), вақти гузашта аз лаҳзаи даридан, хусусияти вай ва ғайра вобастагӣ дорад. Дар мавридҳои хеле кам дӯхтани бачадон муяссар мешавад. Ҷарроҳии типикӣ ҳангоми даридагии мукаммали бачадон ин экспиратсияи он аст.

Пешгирӣ. Барои пешгирӣ кардани даридани бачадон гурӯҳи хатарноки ҳомилаҳоро муайян мекунанд.

1. Ҳомилаҳое, ки бачадонашон ҳадша дорад
2. Бисёрзояндаҳо
3. Ҳомилаҳое, ки коси танг, тифли калон, ҳолати нодуруст ҷойгир шавии тифлро доранд.

Онҳоро сари вақт дар беморхона бистарӣ карда, муоина мекунанд ва нақшаи самарабахши таваллуди онҳоро тартиб медиханд.

V. АМРОЗИ УФУНАТИИ БАЪДИВАЛОДАТӢ

Яке аз сабабҳои бонифузи бемориҳои модарон ва фаоти онҳо дар давраи пас аз валодат, ин бемориҳои фасодиву сироятӣ мебошанд, ки басомади вай 5-26% буда, майли камшавӣ низ надорад.

Омили сирояти баъдивалодатӣ ин мавҷуд будани даромадгоҳҳо аст, ки аз майдони машина (пласентарӣ) ва иллатнокшавии роҳҳои нарми валодатӣ иборат мебошад. Ҳамчунин ҳолати имунодефитсита муваққатӣ низ дар пайдошавии ин оризаҳо нақшаи муҳимро мебозад.

Имрӯз процесҳои фасодиву сироятиро бо як қатор хусусиятҳои таъсиф мекунад;

- паст шудани реактивияти (қобилияти аксуламаш) макроорганизм;
- яъне мавҷуд будани якҷанд барангезандаи полиэтиологият;
- муқовимоти микроорганизмҳо дар муқобили антибиотикҳо ва ҳангоми истеъмоли онҳо зиёд шудани оризаҳои аллергият;
- зиёд шудани шаклҳои маъмулӣ ва ғайримукаррарӣ (атипӣ);
- босуръат инкишоф ёфтан ва паҳн шудани сироят;
- зиёд шудани басомади сирояти госпиталӣ (хламидияҳо, микоплазмҳо, бактерияҳои анаэробӣ ва ғайра).

ТАСНИФИ КЛИНИКӢ (САРИРӢ)

Ин таъсиф дар заминаи тасаввуроти сирояти баъдитаваллудӣ ба сифати процесси ягонаи динамикӣ бунёд шудааст, ки дар он 4 марҳилаи паҳншавии протсессаи патологиро зикр мекунад:

I – сироят дар минтақаи захми узвҳои таваллудӣ маҳдуд мешавад:

эндометрити баъдитаваллудӣ, захми баъдивалодатӣ.

II – сироят берун аз ҳудуди захм паҳн шудааст, вале маҳдуд аст:

метрит, параметрит, тромбофлебити маҳдуд (метрофлебит, тромбофлебити кос, тромбофлебити варидҳои пой), аднексит, пелвиоперитонит.

III – сироят, ки аз ҷиҳати аломатҳои клиникӣ ба сирояти паҳншуда монанд аст: перитонити паҳншудаи баъдивалодатӣ, шоки септикӣ, тромбофлебити инкишофёбанда.

IV – сирояти паҳншуда: фасод (сепсис) бе метастазҳои возеҳ, сепсис бо метастазҳо.

ШАКЛҲОИ МАРҲАЛАИ ЯКУМИ СИРОЯТҲОИ БАЪДИТАВАЛЛУДӢ

Заҳми баъдитаваллудӣ. Истилоҳи заҳми баъдитаваллудиро ҳангоми мавҷуд будани заҳмҳои сироятноке (кафидагиҳо, порашавиҳо), ки ҳангоми таваллудкунӣ дар чатан, маҳбал ва гарданаки бачадон рух медиҳанд, истифода мекунанд. Ба вучуд омадани некрози сатҳӣ ҳоси заҳмҳои баъдитаваллудӣ аст. Болои заҳмро қабати ифлоси бӯр пӯшонидааст, вайро аз бофтаи зерин базӯр ҷудо кардан мумкин аст. Ҷарроҳат ба осонӣ хуншор мешавад, дар гирдаш бофтаҳо варам мекунанд, гиперемияи илтиҳобӣ ба назар мерасад. Ҳолати умумӣ кам ҳалал меёбад. Баъзан таби наҷданон баланд, ҳангоми роҳ рафтан дар атрофии ҷарроҳат дард пайдо мешавад. Ташҳиси беморӣ душвор нест.

Табобат:

1. Бо салфеткаи докаи пок ҷароҳатро хушк мекунанд.
2. Кӯкҳои болоиро қандан, то ин ки барои хориҷ шудани ҳунобаи ҷароҳат роҳ кушода шавад.
3. Бофтаҳои мурдари бозхатиёт бурдан.
4. Бо салфеткаи докаи дар маҳлули гипертонии NaCl ду маротиба дар як рӯз пок кардан.
5. Баъди 72 соат, агар нишонаҳои илтиҳоб ба назар нарасанд, салфеткаи марҳами Вишневский ва марҳами солкосерилдорро ба ҷароҳат гузоштан.

Эндометриити баъдитаваллудӣ

Илтиҳоби баъдитаваллудӣ ин илтиҳоби пардаи луобии бачадон аст, ки сироят аз тариқи рағҳои лимфавӣ ба даруни миометрий паҳн мешавад.

Вай яке аз оризаҳои маъмули давраи баъдитаваллудӣ буда, дар 0,5-8%-и зояндаҳо инкишоф меёбад.

Барангезандаи сироят маъмулан қаламчаҳои рӯда, стафилококк ва стрептококк аст.

Клиника: Аломатҳои клинӣи эндометриитро симптомҳои умумӣи интоксикатсия ва аломатҳои мавзёии сироятнокшавӣи пардаҳои луобӣ ва мушакии бачадон ташкил медиҳанд.

Симптомҳои умумӣ:

- То 38°C ва аз он зиёд баланд шудани ҳарорати бадан, тахикардия, варача (табларза).

Симптомҳои мавзёӣ:

- Дарди поёни шикам.
- Ҳангоми ламскунӣ дарднок будани бачадон.
- Чиркобаи бачадон (лохӣи) тираранги бадбӯӣ.

Ташҳис:

1. Мавҷуд будани симптомҳои зарурӣ
2. Дар муоинаи хун лейкоцитоз, нейтрофилёз, ба тарафи чап гузоштани лейкоформула, лимфоситопения.
3. Муоинаи маҳбалӣ – дарднокии шадиди бачадон, тарҳро (контур) на ҳамеша возеҳ муайян кардан мумкин аст.
4. Муоинаи ултрасадоӣ - аломатҳои эхографияи эндометриит ин сӯст шудани тонуси бачадон, васеъ шудани ковокии он, дар ковокӣ мавҷуд будани газ, тарашшӯхот (инфилтрат)-и миометрий.

Вобаста аз возеҳ будани аломатҳои клиникӣ шаклҳои сабук ва вазнини онро ҷудо мекунам. Аз ҷиҳати ҷараёни клиникӣ онро ба намудҳои классикӣ, маъмулӣ (стертый), ниҳонӣ (абортӣ) ва эндометриити баъди ҷарроҳӣ қайсарӣ тақсим кардаанд.

Табобат: асоси табобатро инҳо ташкил мекунанд:

1. Санатсияи ҷарроҳии манбаи фасодӣ.

2. Антибиотикотерапияи самаранок.

3. Муолиҷаи инфузионӣ.

1. Санатсияи ҷарроҳии манбаи фасодӣ: агар мӯҳтавои он зиёд набошад, барои беҳтар шудани ҷараёни онҳо фақат канали гарданаки бачадонро васеъ кардан кифоя аст. Агар мӯҳтаво бисёр бошад, кюретаж (тарошида партофтан)-и ковокии бачадон ва ё вакуум-аспиратсия менамоянд. Воситаи самаранок ин бо маҳлули фурацилин дренажкунӣ аспиридонӣ-шустушӯӣи ковокии бачадон ба ҳисоб меравад.

2. Табобати антибиотикӣ дар мавриди ба антибиотикҳо ҳассосият доштани барангезанда истифода мешавад. Одатан пенисиллин нимсунӣ, сефалоспорин ва метронидазолро ба кор мебаранд.

3. Ҳангоми захролудии возеҳ муолиҷаи инфузионӣ суръат мегирад: маҳлулҳои кристалоидӣ – маҳлули Рингер ва ғайра истифода мешаванд.

Дорувориҳои десенсебилизатсионӣ, калсий, маводҳои суфтаи кашишдиҳандаи бачадонро истифода мекунанд. Барои беҳтар хориҷ шудани ҷиркоби бачадон спазмолитикҳоро истифода мекунанд.

ШАКЛҲОИ МАРҲАЛАИ ДУЮМИ СИРОЯТҲОИ БАЪДИТАВАЛЛУДӢ ПАРАМЕТРИТ.

Параметрити баъдивалодат илтиҳоби хучайрабофти назди бачадон, ки маъмулан ҳангоми паҳншавии лимфогении сироят рӯй медиҳад. Беморӣ дар рӯзҳои 10-12-уми баъди таваллудкунӣ сар мешавад. Одатан параметрити баъди эндометрит ба вучуд меояд. Вобаста аз ҷойгиршавиаш онро ба параметрити ақибӣ ва паҳлӯӣ тақсим мекунанд. Зардоб (экссудат)-е, ки дар хучайрабофти параметралӣ ҷамъ мешавад, дар ибтидо серозӣ (мухотӣ) аст ва баъзан дар вай торҳои фибрин

тахшин шуда, тарашшӯхоти (интифлтрати) сахт пайдо мекунад.

Параметрит аз таби баланд, то 39-40°C ва ларза сар мешавад. Ҳолати умумӣ қариб, ки тағйир намеёбад, беморон танҳо аз дарди кашандаи поёни шикам шикоят мекунанд. Параметрит одатан чунин чараён дорад: инфилтрат маъмулан нест мешавад, баъзе вақтҳо дар ҳафтаҳои 3-4-уми беморӣ инфилтрат римнок мешавад. Дар вақти рим кардан таби сабук (ремиттӣ) ва хурӯҷҳои ларза дида мешавад. Агар мадда (чиркхона) чок карда нашавад, чирку фасод метавонад, ки ба зери мушаки сурин, ба рон, ба ноҳияи наздигурдагӣ, ба рӯдаи рост гузарад.

Ташхиси беморӣ асосан дар заминаи симптомҳои пайдошуда ва муоинаи маҳбал гузошта мешавад. Ҳангоми муоинаи маҳбал варами иллатнок дар гумбази маҳбал ба назар мерасад. Баъди 2-3 рӯз тарҳи инфилтрат маълум мешавад, вай аввал ҳамирмонанд асту бад сахт мешавад.

Табобат: табобаташ мисли дигар бемориҳои илтиҳобӣ аст. Агар ҳучайрабोфти параметралӣ чирк кунад, аз тариқи гумбази маҳбал чиркхонаро чок мекунанд. Ҳоло истеъмоли антибиотикҳо ба он оварда расонид, ки параметрит ҳамчун шакли мустақили беморӣ хеле кам ба назар мерасад.

ПЕЛВИОПЕРИТОНИТ

Пелвиоперитонити баъдитаваллудӣ илтиҳоби сифок аст, ки дар ковокии коси хурд маҳдуд мешавад. Илтиҳоби сифоки кос метавонад, ки ҳангоми аз тариқи девораи бачадон ва бандаки васеъ бо роҳи лимфогенӣ паҳн шудани сироят инкишоф ёбад: бо роҳи интраканаликулярӣ (бештар дар вақти сӯзок); дар натиҷаи сироятнок шудани сифок ҳангоми иллатнокии бачадон, маҳбал ва ғайра. Дар марҳилаи шадиди беморӣ дар ковокии шикам тарашшӯхот (экссудат)-и серозӣ пайдо мешавад ва дар рӯзҳои 3-4-ум вай чирк мекунад. Дар пелвиоперитонити сӯзокӣ экссудати фиброзӣ дида мешавад. Қабатҳои фиброзиё, ки дар сарҳади илтиҳоб пайдо шудаанд, чарбу ва гирехи рӯдаро

бо узвҳои кос мепайвандад ва манбаи фасодно маҳдуд месозад. Пелвиоперитонит аксар вақт дар тӯли ҳафтаи якуми баъди таваллудкунӣ пайдо мешавад, ҳангоми сӯзнок бошад, вай дертар руҳ медиҳад. Оғози пелвиоперитонит бо аломатҳои клиникӣ перитонити паҳнфто монандӣ дорад. Беморӣ ба таври шадид сар мешавад, таби баланд, ларза, дардҳои саҳти поёни шикам, дилбеҳузуршавӣ, қайкунӣ, дамиши шикам, симптоми мусбати Щеткин-Блюмберг ба назар мерасанд. Баъд аз як-ду шабонарӯз аломатҳои беморӣ возеҳтар мешаванд, вазъи умумии бемор беҳтар мегардад, дамиши шикам танҳо дар қисми поёни боқӣ мемонад, дар девораи пеши шикам дар сарҳади байни қисмҳои илтиҳобнок ва солими ковокии шикам ҷӯяки кундаланг ба назар мерасад.

Ҳангоми муоинаи маҳбал дар рӯзҳои аввали беморӣ танҳо дарднокии гумбази ақиб мушоҳида мешавад: рӯзҳои минбаъда дар ақиб бачадон тарашшӯҳоте (экссудате) ба назар мерасад, ки бо гумбази оқиб маҳбал барҷаста аст ва аввал ҳамирмонанд асту, баъдтар саҳти эластикӣ мешавад ва бачадонро ба пеш ва ба боло тела медиҳад.

Табобат: Табобат тавассути антибиотикҳо, табобати инфузионӣ ва десенсибилизатсионӣ суръат мегирад. Дар вақти чирк кардани экссудат колпотомияро иҷро кардан лозим аст.

ШАКЛҲОИ МАРҲАЛАИ СЕҶОМИ СИРОЯТИ БАЪДИТАВАЛЛУДӢ

Перитонити акушерӣ

Перитонити баъдитаваллудӣ бештар ба зоидаи абдоминалӣ, шиддатнок шудани илтиҳоби иловагӣҳои бачадон, аппендисити шадид ва ё инкишофи септикопиемия вобаста аст. Вале дар аксар мавридҳо (дар 90%) вай дар натиҷаи ҷарроҳии қайсарӣ руҳ медиҳад. Дар ҳолатҳои аз сироятҳои септикӣ фавтидани модарон ҷойи махсусро перитонити баъди ҷарроҳии қайсарӣ ишғол мекунад вай то 37% мерасад.

Сабаби асосии перитонити баъди ҷарроҳии қайсарӣ ин эндомиометрит ва метротромбофлебит бо ташаккули бекуватии ноаён ва ё айёни кӯкҳои бачадон мебошанд.

Ангезандаи перитонити баъди ҷарроҳии қайсарӣ аксар вақт флораи омехтаи аэробиву анаэробист:

- **микрофлораи грам-манфӣ, стафилококки патогенӣ ва стрептококк;**
- **анаэробҳои споратавлиднакунанда: бактероидҳо, пептострептококҳо, пептококкҳо.**

Патогенез.

Ҷиҳатҳои асосии патогенези баъди ҷарроҳии қайсарӣ;

- **заҳролудшавӣ;**
- **гиповолемиа;**
- **халалёбии микросиркулятсия;**
- **нокифоягии полиорганӣ.**

Заҳролудшавӣ. Токсинҳои сафедагӣ ба хун ҷаббида шуда, боиси тағйиротҳои амиқи патофизиологии организм мешаванд. Заҳролудшавӣ боиси иллатёбии дастгоҳи асабии рӯдаҳо ва системаи марказии асаб мегардад.

Гиповолемиа. Камшавии сафеда ҳангоми экссудатсия ва дар ковокии рӯда ба кам шудани протеини хун, паст шудани фишори коллоидивуонкотикӣ оварда мерасонад, ки ин барои ба фосилаи байни бофтаҳо убур кардани (ҷаббида шудани) моеъ мусоидат мекунад.

Халалёбии микросиркулятсия вобаста аст аз:

- гиповолемиа ва нокифоягии хунгардиши канорӣ (периферӣ);
- агрегатсияи дохилирагии унсурҳои шаклии хун.

Гиповолемиа, спазми рағҳои канорӣ (периферӣ), ва микросиркулятсияи халалёфта боиси тағйирёбии ҷараёни хуни канорӣ, шиддат гирифтани иллатҳои сиркулятсия дар рағҳои шикам, ҷигар, гурдаҳо гашта, минбаъд синдроми нокифоягии полиорганиро ба вучуд меорад.

Се фазаи ҷараёни перитонит мавҷуд аст.

- **Фазаи 1 – реактивӣ (24 соати аввал) дар давоми ин фаза дар ковокии шикам экссудат пайдо мешавад ва**

симптомҳои мавзёи ниҳоят возеҳ мешаванд: таҳриқоти сифоқпарда, қайқунӣ, баландшудани фишори шараёни, тез шудани набз ва нафасгирӣ.

- **Фазаи 2 – захролудӣ (24-72 соат)** реаксияҳои умумӣ бартарӣ доранд, аммо синдроми дард ва таҳриқоти сифоқ кам мешавад. Ихтилоли гемодинамика, микросиркулятсия, нокифоягии гурда ва чигар инкишоф меёбад, гипоксия авҷ мегирад.
- **Фазаи 3 – терминалӣ (зиёда аз 72 соат).** Дар давоми ин фаза шоки гиповолемӣ, бактериалӣ, халалёбии қори дил мушахсида карда мешавад. Зухуроти мавзёи – дамиши шикам, дарди паҳншуда дар тамоми шикам меафзоянд.

Клиника: симптомҳои асосии перитонити паҳншуда инҳоянд -дарди шикам, дилбеҳузурӣ, қайқунӣ, дамиши шикам (метеоризм), нимфалаҷи инкишофёбандаи рӯдаҳо, хушкии забон, тарангшавии девораи пеши шикам, «+» будани аломати Щеткин – Блюмберг. Таби баланд, набзи тез-тез, паст будани фишори хун.

Ташхис. Перитонити акушерӣ аз перитонити ҷарроҳӣ бо як қатор аломатҳои клиникаш фарқ мекунад. Танҳо баъди арзёбии ҳамаи симптомҳо дар якҷоягӣ ва динамикии онҳо метавон, ки ташхиси саривактӣ ва дуруст гузошта шавад. Иҷро кардани муоинаҳои лабораторӣ (муоинаи умумии хун, таҷзияи биохимӣ, муайян кардани ҳолати системаҳои гемостаз) ва муоинаи ултрасодой ҳатмӣ аст.

Ташхиси саривактӣ хеле муҳим аст, зеро дар фазаи реактиви беморӣ табобат ҳамеша босамар аст, дар фазаи захролудшавӣ бошад, натиҷаи табобатро пешгӯӣ кардан душвор аст.

Принсипҳои табобати комплексии перитонит

Муолиҷаи интенсивии гайриҷарроҳӣ танҳо дар тӯли 18-24 соат гузаронида мешавад. Агар он ғоидабахш набошад, ба табобати ҷарроҳӣ рӯ меоваранд.

Таботати чарроҳии таъчилӣ дар мавридҳои зерин зарур аст;

- ҳангоми норасогии кӯкҳои бачадон;
- ҳалалёбии қобилияти монёкунандаи рӯдаҳо.

Ҳаҷми амалиёти чарроҳӣ: экстирпатсияи ё ампутатсияи бачадон бо дренажкунии ковокии шикам аз тариқи маҳбали дӯхтанашуда ва дренаж дар қисмҳои поёнии каналҳои паҳлӯӣ.

Асоси табобатро табобати инфузионӣ-трансфузионӣ ташкил медиҳад. Ҳаҷми умумии он 4-5 л аст. Баъди ҳар як литри моеъ диурези босуръат бо дохил кардани 20 мг лазикс гузаронида мешавад.

Таботати инфузионӣ-трансфузионӣ ҳангоми перитонит иборат аст аз дохил кардани моеъ ва хунивазкунандаҳо: маҳлули Рингер, массаи эритроцитарӣ, плазмаи яхкуношуда.

Яке аз ҷузъҳои асосии табобат табобати зиддибактериалӣ аст. Принсипҳои табобати антибактериалӣ:

- бо истифодаи 2-3 дору суръат мегирад;
- вобаста ба пайдо шудани ҳассосият ҳар 7-10 рӯз иваз кардани антибиотикҳо. Комбинацияи антибиотикҳо аз пеницилинҳои нимсинтетикӣ, тетрациклин, сефалоспорин, аминогликозид иборат аст. Азбаски перитонитро асосиатсияи аэробӣ-анаэробӣ ба вучуд овардааст, ба анаэробҳо низ таъсир расонидан лозим аст. Ба ин мақсад истифодаи доруҳои метранидазол (клион, метрогил, трихопол) самараноканд.

Таботати нимфалачи рӯдаҳо;

- декомпрессияи роҳҳои ҳозима, дренажкунии меъда;
- стимулятсияи рӯдаҳо - прозерин (0,05% - 1,0), маҳлули гипертоники NaCl (то 60 мл дохили варид), имолаи гипертоникӣ.
- электростимулятсияи рӯдаҳо;

САДАМАИ СЕПТИКӢ

Садамаи септикӣ - ҳалалёбии шадиди гемодинамикӣ буда, боиси пайдошавии синдроми пешравандаи нокифоягии полиорганӣ мешавад.

Дар таҷрибаи амалии акушерӣ садамаи септикӣ бештар ҳангоми сиқти септикӣ ва хориоаминонит дида мешавад.

Патогенез. Дар патогенези садамаи септикӣ эндотоксин аҳамияти бештар дорад, вай ба маҷрои хун дохил шуда, мембранаи ҳучайраҳои системаи ретикуло-эндотелиявии чигару шуш, тромбоциту лейкоцитро иллатнок мекунад. Дар ин маврид лизосомҳо, ки ферментҳои протеолитӣ ва маводи фаъолкунандаи вазоактивӣ доранд, озод мешаванд: кинин, гистамин, серотонин, катехоламин, простогландин. Ин моддаҳои вазоактивӣ қобилияти ба то-нуси рағҳои канорӣ (периферӣ) таъсир расонида, хунгардиши капилляриро суст мекунад ва ба ихтилоли хунгардиш оварда мерасонад, ки дорои ҳалалёбии назарраси ҳислатҳои реологии хун ва инкишофи синдроми лахташавии умумии дохилирағӣ аст.

Ба ақидаи Гелфанд септикӣ просесси марҳаладор аст.

1. Фазаи I-ро гипердинамикӣ ё «гарм» меноманд. Хусусиятҳои фарқкунандаи ин марҳала:

- таби баланд то 40-41°C,
- пӯсти гарми (варамида) гиперемӣ,
- ларза,
- симптомҳои таҳрики системаи марказии асаб (эйфория, дезориентатсия, таҳриқоти психомоторӣ) аст,
- фишори шарёӣ мӯътадил аст, ё каме паст шудааст. Ин марҳалаи шок аз 30 дақиқа то 1-2 соат давом мекунад.

2. Марҳалаи гиподинамикӣ ва ё «сард»:

- бо шадидан ва дуру дароз паст шудани фишори шарёӣ то 80-90 мм сут. сим.,

- паст шудани ҳарорати бадан то 2-4⁰С фарк мекунад
- пӯст сард мешавад, тасвирҳои мармарӣ пайдо мешаванд дар пӯст,
- акросианоз,
- тахипноэ,
- тахикардияи вазеҳ то 125 зарба дар як дақиқа,
- олигурия то 20 мл дар як соат пайдо мешавад.

Чунин ҳолат аз якчанд соат то як чанд шабонарӯз давом мекунад. Дар аломатҳои клинӣ шоки бактериализаҳролудӣ симптомҳои нокифоягии гурда ва шадиди роҳҳои нафас, инчунин хунравӣ, ки дар натиҷаи пешравии синдроми лахташавии умумӣ дохилирагӣ авҷ мегирад, дида мешавад.

Ташҳис. Садамаи септикӣ барои бемор хатари марговар дорад, аз ин рӯ ташҳиси саривактӣ вай ҳеле муҳим аст. Ташҳис дар асоси зуҳуроти зарурии клиникӣ гузошта мешавад.

Муоинаи клинӣ хун бо ҳисоб кардани тромбоцитҳо барои ташҳис ёрӣ расонида метавонад: тромбоцитопения яке аз аломатҳои аввалини шоки септикӣ ба шумор меравад. Барои ошкор сохтани синдроми лахташавии умумӣ дохилирагӣ муоинаи коагулограмма мувофиқи мақсад аст.

Таъбиат. Принсипҳои таъбати садамаи септикӣ:

- таъбати инфузионӣ – трансфузионӣ;
- таъсиррасонӣ ба манбаи сироят ва нест кардани он;
- таъбати зиддибактериявӣ;
- таъбати симптоматикӣ: таъбати устуворсозии умумӣ; таъбати гипосенсибилизӣ; иммунокоррексионӣ; таъбати гормоналӣ.

Муолиҷаи зиддибактериявӣ иборат аст аз ба таври дохиливаридӣ гузаронидани дозаи зиёди антибиотикҳо (бензилпенисиллин 40-60 млн 6-8 бор, метисилин 1-2 г - 6 бор, кефзол, сефалексин 1 г – 6 бор дар як шабонарӯз).

Ба комплекси доруҳои зиддибактериявӣ доруҳои метронидазолро дохил бояд кард.

Мубориза бар зидди сироят аз несткунии манбаи сироят иборат аст. Агар манбаи сироят бачадон бошад, вайро ампутатсия ё экстирпатсия мекунанд. Дар мавриди маститҳои фасоддор чиркхонахоро васеъ чок мекунанд, то ки вай хуб қорӣ шавад. Дар вақти хорионамнионит бо ёрии доруҳои зоиданро тезонанда ва амалиётҳои акушерии таваллудкунӣ – вакуум-экстрактсия, чангакҳои акушерӣ, амалиётҳои тифлпоракунӣ ва ғайра, тезонидани таваллудкунӣ муҳим аст.

Табобати инфузионӣ-трансфузионӣ иборат аст аз дохил кардани моеъ ва хунивазкунандаҳо: маҳлули Рингер, массаи эритроцитарӣ, плазмаи яхкуношуда.

Бо пешгирӣ ва табобати нокифоягии нафасгирӣ тамоми чорабиниҳои асосии аз байн барандаи садамаи септикиро таъмин мекунанд.

ШАКЛҲОИ МАРҲАЛАИ ЧОРУМИ СИРОЯТҲОИ БАЪДИТАВАЛЛУДӢ СЕПСИСИ АКУШЕРӢ

Сепсис (фосидшавии хун) бемории умумии вазнини сироятӣ аст, дорои токсемияи микробиву бофтагӣ буда, доимо ва ё давра ба давра аз манбаи сироят ба маҷрои умумии хун мегузарад ва дар баъзе мавридҳо метастазҳои римнокро ба вучуд меорад.

Сабаби асосии вай флораи граммусбат ва анаэробҳои факултативиянд. Сепсиси акушерӣ доимо бемории «дуҷум» аст, яъне вай дар ҳолати мавҷуд будани манбаи якуми фасод (рим) пайдо мешавад.

Ду шакли асосии клиникӣ сепсис мавҷуд аст:

- сепсиси метастазӣ (септикопиемия)
- сепсиси бе метастаз (септисемия)

Септисемия – дар маҷрои хунбар ва дар тамоми организм мавҷуд будани бактерия ва токсинҳои он, ки вақт аз вақт аз манбаи ибтидоӣ ба маҷрои умумии хун дохил

мешаванд. Ташхиси септисемиро ба таври эътимоднок баъди тадқиқи бактериологии хун пайдо кардани микробҳо, муайян кардан мумкин аст.

Септикопиемия – дар узвҳо ва бофтаҳои гуногун пайдо шудани манбаи тақрири римнок (метастаз) мебошад. Механизми пайдошавии метастазҳо мураккаб аст. Чунин мешуморанд, ки дар зери таъсири омилҳои токсикӣ ва аллергӣ артериити асептикӣ инкишоф меёбад ва минбаъд дар ноҳияҳои иллатноки эндотелии рағҳо микробҳо часпида инкишоф меёбанд ва метастазро ба вучуд меоваранд.

Сепсиси бе метастаз. Ин беморӣ ба зудӣ маълум мешавад: дар рӯзҳои дуҷум-сеҷуми баъди таваллудкунӣ бо ларза ва таби баланд то 40-41⁰С сар мешавад. Табларза доимӣ аст, ларзаҳои тақрирӣ ба назар мерасад, набз тез ва нодуруст аст. Ҳолати умумии бемор аз аввали беморӣ вазнин мебошад. Беҳавсалагӣ, ҳоболудагӣ, рӯҳафтадагӣ, гоҳо ҳазёнгӯи, сардари, ғазабнокӣ дида мешавад. Ранги пӯсти хира мешавад. Дар пӯст хуншориҳои майда пайдо мешаванд. Баъзан дарднокӣ ва варамидаи бугумҳо рух медиҳад. Забон хушк буда, ғуборолуд аст. Зуд-зуд исҳоли токсикӣ пайдо мешавад. Сепсиси бе метастазро баъди тақриран дар хун пайдо кардани микробҳо бо муоинаи бактериологӣ ба таври боварибахш ташхис кардан мумкин аст.

Сепсис бо метастаз. Ин беморӣ одатан дар рӯзҳои 10-17-ӯми баъди таваллудкунӣ сар мешавад. Аз ҳама бештар осеб дидани шуш аз он гувоҳӣ медиҳад, ки шуш дар роҳи ҳаракати сироят мисли филтри маҳсус аст. Ҳангоми ба таври лимфогенӣ паҳн шудани сироят эмболи микробӣ аз тариқи маҷрои қафаси сина ба маҷрои вараидӣ меафтанд, аз он ҷо ба дили рост ва шушҳо дохил мешаванд. Гоҳо микробҳо ба шуш нарасида ба дили чап ва аз он ба хунгардиши калон дохил мешаванд. Дар ин намуди сепсис таб гоҳ пасту гоҳ баланд гашта, табларза дида мешавад ва баъди он арақи зиёд пайдо мешавад. Набз тез буда, ба душворӣ пурра мегардад. Қабатҳои пӯст рангпарида ме-

шаванд. Нафаскашӣ зуд-зуд ва нафастангӣ дида мешавад. Дар хун лейкоцитози устуворӣ ба назар мерасад, лейкоформула ба тарафи чап зиёд майл дорад, камхунӣ вусъат меёбад. Диурез кам буда, бактериурия дида мешавад, дар пешоб сафеда, эритроцит, лейкоцит ва цилиндрҳо мавҷуданд.

Якчанд намудҳои сепсиси бо метастаз инкишоф ёфтара фарқ мекунанд: тромбофлебитӣ, эндокардит, перитонеалӣ.

Намуди тромбофлебитӣ – асоси онро тромбофлебитӣ римнок ташкил медиҳад, дар ин маврид метастази римнок дар шуш ҷойгир мешавад.

Намуди эндокардит – дар ин намуд эндокард иллатнок мешавад. Клапанҳои дил ба нскроз гирифта ва яра мешаванд, дар болои онҳо қабати тромботикӣ дида мешавад. Метастази римнок дар хунгардиши калон, дар гурдаҳо, мағзи сар, испурҷ пайдо мешавад.

Дар сепсиси перитонеалӣ таб гоҳ баланду гоҳ паст мешавад, хуруҷҳои тақрибии табларза, исҳоли септикӣ ба назар мерасад. Дар шуш метастаз пайдо мешавад.

Бо пайдо шудани метастаз ҳоли бемор бад мешавад, таб мекунад ва табларза пайдо мешавад.

Муолиҷаи сепсис (фосидшавии хун)

Принсипҳои табобати сепсис:

- табобати инфузионӣ – трансфузионӣ;
- таъсиррасонӣ ба манбаи сироят ва нест кардани он;
- табобати зиддибактериявӣ;
- табобати симптоматикӣ: табобати устуворсозии умумӣ; табобати гипосенсибилизӣ; иммунокоррексионӣ; табобати гормоналӣ.

Беморони гирифтаи сепсисро бо ду роҳ табобат мекунанд: аз байн бурдани манбаи сироят ва муолиҷаи комплексӣ. Агар манбаи сироят бачадон бошад, баъди 3 рӯзи табобати ғайриҷарроҳии бесамар экстирпатсия бо гирифта партофтани найчаҳои бачадон ва ампутатсияи он гузаронида мешавад. Антибиотикҳоро мувофиқи флораи микробӣ ва маълумоти антибиотикограмма, дар мӯҳла-

ти 14-20 рӯз таъин мекунанд. Дозаи шабонарӯзии антибиотикҳо чунин тавсия карда мешавад: амписиллин 3-4 г дохиливаридӣ; бензилпенисиллин – 16 000 000 – 20 000 000 ЕД дохиливаридӣ; оксасиллин ва метисиллин – 200 – 240 мг дохилимушакӣ, сепорин – 4 г дохиливаридӣ. Аз омехтаи антибиотикҳо инҳо беҳтар ба ҳисоб мераванд: амписилин бо гентамисин, канамицин бо линкомисин.

Табобати инфузионӣ-трансфузионӣ иборат аст аз дохил кардани моеъ ва хунивазкунондаҳои зерин: маҳлули Рингер, массаи эритроситарӣ, плазмаи яхкуношуда.

Матбааи ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Ба матбаа супорида шуд 07. 09. 2009с. Ба чоп иҷозат дода шуд 25. 09. 2009с . Формат 60 x 84¹/₁₆. 8,0 ҷузъи чопӣ. Қоғази офсетии 80^с / м² . Теъдод 250 нусха. Супориши №14. Нархаи шартномавӣ.